القلبية

بنك الأسئلة الموحد والشامل (مرتب حسب المواضيع)

207 سؤال • 11 مواضيع • 2018 - 2026

فهرس المواضيع والتصنيفات

التظاهرات السريرية	2025 - 2018	13 سؤال
قصور القلب	2026 - 2019	36 سؤال
الداء الإكليلي	2026 - 2018	40 سؤال
أمراض الشغاف والصمامات	2026 - 2018	42 سؤال
اضطرابات النظم والنقل	2026 - 2018	29 سؤال
ارتفاع الضغط الشرياني	2025 - 2018	18 سؤال
أمراض العضلة القلبية	2025 - 2023	3 سؤال
أمراض القلب الخلقية	2023 - 2018	7 سؤال
أمراض التامور	2026 - 2019	12 سؤال
المداواة القلبية	2025 - 2020	4 سؤال
جراحة الصدر والأوعية	2025 - 2023	3 سؤال

التظاهرات السريرية

13 سؤال

1. راجعت مريضة أربعينية تشكو من ارتفاع ضغط شرياني نوبي شديد مصحوب بتوهج وخفقان وصداع، ما هو التوجه التشخيصي الأرجح: دكتوراه 2025

A. متلازمة كون.

B. متلازمة كوشينغ.

C. ورم القواتم.

D. داء أديسون.

E. فرط الدريقية الأولي.

الإجابة الصحيحة: C — ورم القواتم.

التعليل السريري: ورم القواتم ورم مفرز للكاتيكولامينات ينشأ عادة من لب الكظر، يسبب إفرازاً نوبياً للأدرينالين والنورأدرينالين محدثاً نوباً من ارتفاع الضغط الشديد المصحوب بتوهج (تعرق)، خفقان (تسرع قلب)، وصداع نابض بسبب التقبض الوعائي المفاجئ وزيادة قلوصية القلب.

الخيارات الأخرى: **A)** متلازمة كون تسبب ارتفاع ضغط مستمر مع نقص بوتاسيوم دون نوب توهج وخفقان نموذجية. **B)** متلازمة كوشينغ تتظاهر بسمنة مركزية وعلامات فرط الكورتيزول دون نوب انتيابية. **D)** داء أديسون يسبب هبوط ضغط لا ارتفاعه. **E)** فرط الدريقية الأولي يسبب فرط كالسيوم الدم دون نوب ضغطية مميزة.

الفكرة من السؤال: يتظاهر ورم القواتم كلاسيكياً بالثالوث: صداع نوبي، خفقان، وتعرق مع نوب ارتفاع ضغط شديدة انتيابية؛ يُشخّص بمعايرة الكاتيكولامينات/الميتانفرينات في البول أو البلازما.

---

2. كل مما يلي يعد من الأسباب قلبية المنشأ (Cardioembolic) لحدوث احتشاء أو نشبة دماغية عدا: دكتوراه 2025

A. العصيدة الشريانية.

B. التهاب الشغاف.

C. احتشاء قلب.

D. تضيق تاجي.

E. الورم المخاطي الأذيني.

الإجابة الصحيحة: A — العصيدة الشريانية.

التعليل السريري: العصيدة الشريانية (Atherosclerosis) تسبب السكتة عبر آلية شريانية-شريانية (تصلب وتضيق الشرايين السباتية/داخل القحف مع انصمام لاحق منها)، وليست مصدراً قلبياً للصمات، لذا تُستبعد من قائمة الأسباب قلبية المنشأ.

الخيارات الأخرى: **B)** التهاب الشغاف يشكل نباتات جرثومية قابلة للانصمام. **C)** احتشاء القلب يترافق بخثرة جدارية بطينية مصدر للصمات. **D)** تضيق التاجي يسبب ركودة دموية أذينية وتشكل خثرات. **E)** الورم المخاطي الأذيني قد ينفتت مسبباً صمات جهازية.

الفكرة من السؤال: مصادر الصمات القلبية للسكتة تشمل: الرجفان الأذيني، التهاب الشغاف، الخثرة الجدارية بعد الاحتشاء، تضيق التاجي، والورم المخاطي الأذيني؛ أما العصيدة الشريانية فهي آلية شريانية-شريانية وليست قلبية المنشأ.

3. فتاة شابة عانت من فقدان وعي مفاجئ وسريع التراجع مباشرة بعد خروجها من حمام ساخن ممتد، ما هو التشخيص الأرجح للحالة: دكتوراه 2025

A. غشي وعائي.
B. غشي قلبي المنشأ.
C. غشي انتصابي دوائي.
D. نوبة صرع حركية كبرى.
E. صمة رئوية حادة.

الإجابة الصحيحة: A — غشي وعائي.

التعليل السريري: التعرض الممتد للحرارة (حمام ساخن) يسبب توسعاً وعائياً محيطياً ونقصاً في العود الوريدي، فينخفض الامتلاء البطيني ويحدث تفعيل ودي بدئي يحرض المستقبلات الميكانيكية البطينية، مما يؤدي لتنشيط منعكس نظير ودي مفرط (بطء قلب وتوسع وعائي) وهبوط ضغط وغشي سريع التراجع.

الخيارات الأخرى: **B)** الغشي القلبي المنشأ يكون فجائياً دون محرض حروري واضح ويشير لآفة بنيوية أو اضطراب نظم. **C)** الغشي الانتصابي الدوائي يحدث عند الوقوف المفاجئ وليس بالضرورة بعد حمام ساخن ممتد دون سياق دوائي مذكور. **D)** نوبة الصرع الحركية الكبرى تترافق بحركات لا إرادية وتخليط ذهني وعودة بطيئة للوعي. **E)** الصمة الرئوية الحادة تسبب غشياً مع ضيق نفس وألم صدري وليس بهذا السياق النموذجي.

الفكرة من السؤال: الحرارة العالية والوقوف المديد ينقصان العود الوريدي محرضين الغشي القلبي العصبي (المبهمي)؛ يتميز ببدء تدريجي مع أعراض بادرة (غثيان، توعك) وعودة وعي سريعة نسبياً بعد الاستلقاء.

4. يمكن أن يؤدي إلى هبوط ضغط انتصابي ما عدا: آذار 2023

A. نقص الحجم.
B. الداء السكري.
C. مقبضات الأوعية.
D. التقدم بالسن.
E. مضادات الاكتئاب.

الإجابة الصحيحة: C — مقبضات الأوعية.

التعليل السريري: هبوط الضغط الانتصابي ينجم عن فشل آلية التقبض الوعائي التعويضي عند الوقوف، بينما مقبضات الأوعية تعزز التقبض الوعائي المحيطي وترفع الضغط، فهي بذلك تُستخدم أحياناً لعلاج الهبوط الانتصابي لا كسبب له.

الخيارات الأخرى: **A)** نقص الحجم يقلل الحمل القبلي والنتاج القلبي عند الوقوف. **B)** الداء السكري يسبب اعتلال عصبي ذاتي يعطل التقبض الوعائي التعويضي. **D)** التقدم بالسن يترافق بضعف الاستجابة الانعكاسية الودية. **E)** مضادات الاكتئاب من الأدوية المعروفة المسببة لهبوط الضغط الانتصابي.

الفكرة من السؤال: أسباب هبوط الضغط الانتصابي: نقص الحجم، ضعف التحكم الودي (السكري، التقدم بالعمر)، والأدوية الموسعة للأوعية أو مضادات الاكتئاب؛ أما مقبضات الأوعية فتزيد المقاومة الوعائية وتقي من الهبوط لا تسببه.

5. يحدث الألم الصدري الشديد الممزق في: أيلول 2022

A. احتشاء العضلة القلبية السفلي الحاد.
B. تسلخ الابهر.
C. التهاب التامور الحاد الفيروسي.
D. استرواح الصدر.
E. داء المنطقة.

الإجابة الصحيحة: B – تسلخ الابهر.

التعليل السريري: تسلخ الأبهر ينتج عن تمزق الطبقة الداخلية للأبهر مع اندساس الدم بين طبقات الجدار، مما يسبب ألماً حاداً ممزقاً شديد الشدة ومفاجئ البدء بشكل نموذجي، وغالباً ما ينتشر نحو الظهر بين الكتفين تبعاً لامتداد التسلخ.

الخيارات الأخرى: **A)** احتشاء العضلة القلبية السفلي يسبب ألماً ضاغطاً عاصراً يتطور تدريجياً وليس ممزقاً. **C)** التهاب التامور الفيروسي يسبب ألماً حاداً يتأثر بالوضعية والتنفس دون طابع ممزق. **D)** استرواح الصدر يسبب ألماً حاداً طاعناً جنبياً مع ضيق نفس مفاجئ دون طابع تمزقي نموذجي. **E)** داء المنطقة يسبب ألماً حارقاً بتوزع جلدي مع طفح مميز لاحق.

الفكرة من السؤال: ألم تسلخ الأبهر: شديد، حاد، ممزق، مفاجئ البدء، وغالباً ينتشر نحو الظهر؛ يفرَّق عن الألم الإقفاري الذي يتطور تدريجياً على مدى دقائق.

---

6. يعد كل مما يلي من مثيرات الألم الخناقي (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. الجهد.
B. الوقوف.
C. الاستلقاء.
D. تناول وجبة دسمة.
E. التعرض للبرد.

الإجابة الصحيحة: B – الوقوف.

التعليل السريري: الألم الخناقي ناجم عن زيادة الطلب الأكسجيني للعضلة القلبية بما يفوق التروية الإكليلية المتاحة، وهذا يحدث بالجهد أو زيادة الحمل القلبي؛ أما الوقوف فلا يزيد الطلب الأكسجيني القلبي بل قد يخفف العود الوريدي والحمل القبلي، لذا ليس من المثيرات النموذجية للخناق.

الخيارات الأخرى: **A)** الجهد هو المثير الكلاسيكي الأساسي للخناق المستقر. **C)** الاستلقاء يزيد العود الوريدي والحمل القبلي محرضاً الخناق الاستلقائي. **D)** الوجبة الدسمة تزيد الطلب الاستقلابي والجريان الحشوي محرضة الألم. **E)** التعرض للبرد يسبب تقبضاً وعائياً محيطياً يزيد الحمل على القلب.

الفكرة من السؤال: مثيرات الخناق: الجهد، الوجبة الدسمة، البرد، والاستلقاء (الخناق الاستلقائي)؛ يخف الألم بالراحة خلال دقائق، والوقوف ليس من مثيراته النموذجية.

---

7. من أسباب هبوط الضغط الانتصابي (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. العلاج بمانعات الحمل الفموية.
B. العلاج بالموسعات الوعائية.
C. داء السكري.
D. العلاج بالمدرات.
E. التقدم بالعمر.

الإجابة الصحيحة: A – العلاج بمانعات الحمل الفموية.

التعليل السريري: مانعات الحمل الحاوية على الإستروجين مذكورة كسبب لفرط الضغط الشرياني الثانوي (احتباس الصوديوم والماء وتفعيل الجملة الرينين-أنجيوتنسين)، وهذا عكس آلية هبوط الضغط الانتصابي، لذا فهي ليست من أسبابه.

الخيارات الأخرى: **B)** الموسعات الوعائية تخفض المقاومة الوعائية المحيطية مسببة هبوطاً انتصابياً. **C)** الداء السكري يسبب اعتلالاً عصبياً ذاتياً يعطل التعويض الوعائي. **D)** المدرات تنقص حجم البلازما (الحمل القبلي). **E)** التقدم بالعمر يضعف الاستجابة الانعكاسية الودية.

الفكرة من السؤال: مانعات الحمل الفموية ترتبط بارتفاع الضغط الشرياني والخطورة الخثارية، وليست من أسباب هبوط الضغط الانتصابي.

8. كل ما يلي يسبب هبوط ضغط انتصابي ما عدا:

تشرين 2021

A. العلاج بمانعات الحمل.
B. العلاج بالمدرات.
C. السكري.
D. التقدم بالعمر.
E. المعالجة بموسعات الأوعية.

الإجابة الصحيحة: A – العلاج بمانعات الحمل.

التعليل السريري: نفس آلية السؤال السابق، مانعات الحمل الحاوية على الإستروجين تفعّل جملة الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون وتسبب احتباس الصوديوم والماء مما يرفع الضغط لا يخفضه انتصابياً.

الخيارات الأخرى: **B)** المدرات تنقص الحجم الدوراني الفعال. **C)** السكري يسبب اعتلالاً عصبياً ذاتياً معطلاً للتقبض الوعائي التعويضي. **D)** التقدم بالعمر يضعف الاستجابة الودية الانعكاسية. **E)** موسعات الأوعية تخفض المقاومة الوعائية المحيطية مباشرة.

الفكرة من السؤال: مانعات الحمل الفموية سبب معروف لفرط الضغط الشرياني الثانوي عبر احتباس الماء والصوديوم، وليست من أسباب هبوط الضغط الانتصابي.

9. أسباب صدمة من منشأ قلبي، كل ما يلي صحيح ما عدا:

حزيران 2021

A. التهاب تامور حاد.
B. صمة رئوية كتلية.
C. احتشاء عضلة قلبية.
D. تسرع بطيني تال للاحتشاء.
E. قصور أبهري حاد.

الإجابة الصحيحة: A – التهاب تامور حاد.

التعليل السريري: التهاب التامور الحاد وحده، دون تطور إلى سطام تأموري (اندساف انصباب مضغوط)، لا يعيق الامتلاء البطيني بشكل كافٍ لإحداث انخفاض حرج في النتاج القلبي، وبالتالي لا يُصنَّف كسبب مباشر للصدمة القلبية المنشأ ما لم يتعقد بالدكاك.

الخيارات الأخرى: **B)** الصمة الرئوية الكتلية تعيق الجريان عبر الدوران الرئوي فجأة مسببة فشلاً بطينياً أيمن حاداً وصدمة. **C)** احتشاء العضلة القلبية يُضعف القلوصية مباشرة، وهو السبب الأشيع للصدمة القلبية. **D)** التسرع البطيني التالي للاحتشاء يعيق الامتلاء والقذف الفعالين. **E)** القصور الأبهري الحاد يسبب فرط حمل حجمي مفاجئ يفوق قدرة البطين على التعويض.

الفكرة من السؤال: أسباب الصدمة القلبية: احتشاء العضلة القلبية، الصمة الرئوية الكتلية، السطام التأموري، التهاب شغاف الصمام التاجي، واضطرابات النظم الحادة (كالتسرع البطيني)؛ التهاب التامور الحاد غير المصحوب بسطام لا يسبب صدمة.

---

10. كل مما يلي من أسباب الصدمة قلبية المنشأ ما عدا:

تشرين 2019

A. احتشاء العضلة القلبية الحاد.
B. التهاب شغاف الصمام التاجي.
C. التسرع الجيبي.
D. السطام التاموري.
E. الصمة الرئوية الكبيرة.

الإجابة الصحيحة: C – التسرع الجيبي.

التعليل السريري: التسرع الجيبي ينشأ عادة كاستجابة تعويضية فيزيولوجية (تفعيل ودي) لحالة أخرى مسببة لنقص التروية أو الإجهاد، وليس آلية بحد ذاتها لفشل مضخة القلب أو انسداد ميكانيكي يؤديان للصدمة، بخلاف اللانظميات البطينية الخبيثة المذكورة كسبب مباشر للصدمة القلبية.

الخيارات الأخرى: **A)** احتشاء العضلة القلبية الحاد يضعف القلوصية مباشرة وهو السبب الأشيع. **B)** التهاب شغاف الصمام التاجي قد يسبب قصوراً صمامياً حاداً وصدمة. **D)** السطام التأموري يعيق الامتلاء البطيني الانبساطي بشكل حرج. **E)** الصمة الرئوية الكبيرة تسبب فشلاً بطينياً أيمن حاداً وانخفاضاً في النتاج القلبي.

الفكرة من السؤال: التسرع الجيبي استجابة فيزيولوجية تعويضية غالباً (كرد فعل على الألم أو نقص الحجم أو الحمى) وليس سبباً بحد ذاته للصدمة القلبية المنشأ، بخلاف اضطرابات النظم الخبيثة كالتسرع البطيني.

---

11. كل مما يلي صحيح في الغشي القلبي العصبي عدا:

تشرين 2019

A. يتحرض في ظروف معينة.
B. يحدث بشكل أكثر شيوعاً بسبب انخفاض العود الوريدي.
C. يحدث فيه تسرع قلب.
D. تحرض المستقبلات الميكانيكية في جدران البطينين.
E. يتم تأكيد التشخيص بإجراء اختبار الميلان.

الإجابة الصحيحة: C – يحدث فيه تسرع قلب.

التعليل السريري: في الغشي القلبي العصبي، يسبب التفعيل الودي البدئي تقلصات قوية في بطينات ناقصة الامتلاء، مما يحرض المستقبلات الميكانيكية البطينية فتُفعّل الجملة نظيرة الودية وتُثبَّط الودية، محدثة بطء قلب و/أو توسعاً وعائياً وليس تسرع قلب، وهذا عكس ما ورد في الخيار المطلوب استثناؤه.

الخيارات الأخرى: **A)** يتحرض بظروف معينة كالوقوف المديد أو الحرارة أو غشي السعال/التبول. **B)** ينجم غالباً عن انخفاض العود الوريدي. **D)** تحريض المستقبلات الميكانيكية البطينية هو حجر الأساس الفيزيولوجي المرضي للحالة. **E)** اختبار الميلان هو الفحص المؤكد للتشخيص.

الفكرة من السؤال: الغشي القلبي العصبي ينجم عن تفعيل نظير ودي مفرط يحدث بطء قلب و/أو توسعاً وعائياً بعد تفعيل ودي بدئي ينشط المستقبلات الميكانيكية البطينية؛ يُؤكد التشخيص باختبار الميلان (Tilt Test).

12. كل من الحالات التالية تسبب هبوط ضغط انتصابي ما عدا:

تشرين 2018

A. المعالجة بالميتفورمين.
B. الداء السكري المختلط.
C. المعالجة بمضادات الاكتئاب.
D. المعالجة بموسعات الأوعية.
E. التقدم بالعمر.

الإجابة الصحيحة: A – المعالجة بالميتفورمين.

التعليل السريري: الميتفورمين يعمل مركزياً على إنقاص إنتاج الغلوكوز الكبدي وتحسين حساسية الأنسولين، دون تأثير مباشر على المقاومة الوعائية المحيطية أو الجملة العصبية الودية، لذا لا يُعد سبباً لهبوط الضغط الانتصابي خلافاً لبقية الخيارات.

الخيارات الأخرى: **B)** الداء السكري (خاصة المختلط) يسبب اعتلالاً عصبياً ذاتياً يعطل التقبض الوعائي التعويضي. **C)** مضادات الاكتئاب من الأسباب الدوائية المعروفة لهبوط الضغط الانتصابي. **D)** موسعات الأوعية تخفض المقاومة الوعائية المحيطية مباشرة. **E)** التقدم بالعمر يضعف الاستجابة الودية الانعكاسية عند الوقوف.

الفكرة من السؤال: الميتفورمين خافض سكر لا يؤثر على التوتر الوعائي المحيطي أو التحكم الودي، وليس من أسباب هبوط الضغط الانتصابي، بخلاف الداء السكري نفسه الذي يسببه عبر الاعتلال العصبي الذاتي.

13. من أسباب الغشي القلبي:

تشرين 2018

A. اعتلال العضلة القلبية الضخامي.
B. الصرع الكبير.
C. بعد التبول.
D. بعد تناول الوجبات الكبيرة.
E. غشي الجيب سباتي.

الإجابة الصحيحة: A — اعتلال العضلة القلبية الضخامي.

التعليل السريري: في اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد، يعيق التضخم الحاجزي مخرج البطين الأيسر، وعند الجهد ينخفض الحمل البعدي والمقاومة المحيطية فيزداد الانسداد ويهبط النتاج القلبي مسبباً غشياً قلبياً حقيقياً (سبب بنيوي/ميكانيكي).

الخيارات الأخرى: الصرع الكبير سبب عصبي غير قلبي للغياب عن الوعي مع حركات تشنجية وتخليط بعدي. غشي ما بعد التبول والوجبات الكبيرة من أشكال الغشي القلبي العصبي (المنعكس) الناجم عن هبوط العود الوريدي. غشي الجيب السباتي مفرط الحساسية ناجم عن استجابة انعكاسية شاذة وليس عن آفة قلبية بنيوية.

الفكرة من السؤال: اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد يسبب غشياً جهدياً بسبب انسداد مخرج البطين الأيسر وعدم ارتفاع النتاج القلبي بشكل كافٍ أثناء الجهد.

قصور القلب

36 سؤال

1. العرض الأكثر شيوعاً في قصور القلب الأيسر:

أيار 2026

A. ضيق النفس.
B. زرقة.
C. وذمات الطرفين السفليين.
D. ضخامة كبد.
E. حبن.

الإجابة الصحيحة: A — ضيق النفس.

التعليل السريري: انخفاض نتاج البطين الأيسر يرفع ضغط الأذينة اليسرى والضغط الوريدي الرئوي، مما يسبب احتقاناً وتسرب سوائل إلى الأسناخ الرئوية، فيتظاهر سريرياً بضيق النفس كعرض رئيسي ومبكر.

الخيارات الأخرى: الزرقة علامة متأخرة وغير نوعية لنقص التأكسج. وذمات الطرفين وضخامة الكبد والحبن هي علامات احتقان جهازي مميزة لقصور القلب الأيمن وليس الأيسر.

الفكرة من السؤال: قصور القلب الأيسر يتظاهر أساساً باحتقان رئوي يسبب ضيق نفس جهدي أو اضطجاعي أو نوبي ليلي.

2. واحد مما يلي يرفع BNP:

أيار 2026

A. قصور القلب.
B. نقص الحديد.
C. فرط نشاط الدرق.
D. فقر الدم.
E. الربو.

الإجابة الصحيحة: A — قصور القلب.

التعليل السريري: في قصور القلب يرتفع الحمل القبلي وضغط الامتلاء البطيني، مما يحرض الخلايا العضلية القلبية على إفراز BNP كآلية تعويضية لطرح الصوديوم والماء وتوسيع الأوعية.

الخيارات الأخرى: نقص الحديد لا يرفع BNP بآلية مباشرة. فرط نشاط الدرق قد يترافق مع قصور قلب عالي النتاج لكنه ليس السبب المباشر النموذجي المطلوب هنا. فقر الدم والربو لا يسببان ارتفاعاً نوعياً في BNP إلا إذا أديا لقصور قلب ثانوي.

الفكرة من السؤال: يرتفع BNP استجابة لتمدد جدران البطينين وزيادة الضغط داخل الحجرات القلبية، ويستخدم كاختبار كشف لقصور القلب.

3. يسمع الصوت الثالث S3 في واحد مما يلي: أيار 2026

A. تضيق الصمام الأبهري.

B. قصور القلب الأيسر.

C. التهاب التامور.

D. الرجفان الأذيني.

E. ارتفاع الضغط الشرياني.

الإجابة الصحيحة: B — قصور القلب الأيسر.

التعليل السريري: في قصور القلب الأيسر يتوسع البطين وتقل مطاوعته، فيسبب الامتلاء الانبساطي السريع اهتزازاً مسموعاً يُشكل الصوت الثالث (نظم الخبب الثلاثي).

الخيارات الأخرى: تضيق الأبهري يترافق مع نفخة انقباضية قذفية وليس S3 نموذجياً. التهاب التامور يترافق مع فرك تأموري لا S3. الرجفان الأذيني اضطراب نظم لا يولد صوتاً إضافياً محدداً. ارتفاع الضغط الشرياني قد يترافق مع S4 (بسبب ضخامة وتيبس البطين) وليس S3.

الفكرة من السؤال: S3 يعكس امتلاء بطيني سريع في بطين متوسع وضعيف القلوصية، وهو علامة مسموعة في قصور القلب رغم كونه فيزيولوجياً أحياناً عند الشباب والحوامل.

4. دواء واحد مما يلي يحسن البقيا في قصور القلب: أيار 2026

A. ديجوكسين.

B. فوروسيميد.

C. حاصرات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.

D. نترات.

E. أملوديبين.

الإجابة الصحيحة: C — حاصرات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.

التعليل السريري: تمنع مثبطات ACE تفعيل جملة الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون المسؤولة عن التقبض الوعائي واحتباس الماء والصوديوم، فتقطع الحلقة المفرغة المولدة لتفاقم قصور القلب وتحسن البقيا طويلة الأمد.

الخيارات الأخرى: ديجوكسين يخفف الأعراض وينقص الاستشفاء دون تأثير على البقيا. فوروسيميد يحسن الاحتقان أعراضياً دون إثبات تحسين للبقيا. النترات موسعة وريدية عرضية فقط. أملوديبين حاصر كالسيوم لا دور مثبت له في تحسين البقيا في قصور القلب.

الفكرة من السؤال: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين تحسّن تحمل الجهد والوفيات في قصور القلب المتوسط إلى الشديد وبعد الاحتشاء.

5. في وذمة الرئة الحادة، العلاج الأولي: أيار 2026

A. السوائل الوريدية.

B. الفوروسيميد الوريدي.

C. حاصرات بيتا الوريدية.

D. الصادات الحيوية.

E. الديجوكسين الوريدي.

الإجابة الصحيحة: B — الفوروسيميد الوريدي.

التعليل السريري: الفوروسيميد الوريدي مدر عروة سريع المفعول ينقص حجم البلازما والحمل القبلي بسرعة، مما يخفف الاحتقان الرئوي والضغط في الشعيرات الرئوية ويحسن الأعراض بسرعة.

الخيارات الأخرى: السوائل الوريدية تزيد الحمل القبلي وتفاقم الوذمة الرئوية فهي مضاد استطباب. حاصرات بيتا الوريدية قد تفاقم الحالة الحادة بتثبيطها للقلوصية. الصادات الحيوية لا تفيد إلا بوجود خمج مرافق. الديجوكسين الوريدي ليس علاجاً أولياً للحالة الحادة.

الفكرة من السؤال: يعتمد علاج وذمة الرئة الحادة على الأكسجين، وضعية الجلوس، النترات، والفوروسيميد الوريدي لإنقاص الحمل القبلي والاحتقان الرئوي.

---

6. يتظاهر قصور القلب منخفض النتاج بنقص الإرواء النسيجي المحيطي، ويترافق النقص الشديد في حجم ضربة البطين مع علامة محيطية هي: دكتوراه 2025

A. نبض قافز ومتسع السعة.

B. نبض خيطي ضعيف.

C. أطراف دافئة ومحمرة.

D. ارتفاع الضغط الانقباضي المعزول.

E. غياب المنعكسات النباتية.

الإجابة الصحيحة: B — نبض خيطي ضعيف.

التعليل السريري: انخفاض حجم الضربة البطينية الشديد يقلل من ضغط النبض والسعة الشريانية المحسوسة، مع تفعيل ودي تعويضي يسبب تسرعاً وتقبضاً وعائياً محيطياً، فيُجس النبض ضعيفاً وسريعاً (خيطياً) مع نهايات باردة.

الخيارات الأخرى: النبض القافز المتسع السعة يميز حالات فرط الديناميكية أو القصور الأبهري وليس انخفاض النتاج. الأطراف الدافئة المحمرة تعاكس ما يحدث فعلياً (النهايات تكون باردة). ارتفاع الضغط الانقباضي المعزول لا يتوافق مع هبوط النتاج القلبي. غياب المنعكسات النباتية غير مرتبط بآلية قصور القلب منخفض النتاج.

الفكرة من السؤال: النبض الخيطي الضعيف (نبض صغير السعة وسريع) علامة كلاسيكية لانخفاض حجم الضربة ونقص التروية المحيطية في قصور القلب الحاد أو الصدمة القلبية.

---

7. ما هو العرض السريري الرئيسي والاحتقاني الموجه لتشخيص قصور القلب الأيمن المزمن: كانون 2025

A. الزلة التنفسية الانتيابية الليلية الوصفية.

B. الألم الصدري الإقفاري الحاد.

C. الخفقان الناجم عن عود الدخول الأذيني.

D. الوذمة الانطباعية المتناظرة في الطرفين السفليين.

E. السعال المنتج للقشع الرغوي الزهري.

الإجابة الصحيحة: D — الوذمة الانطباعية المتناظرة في الطرفين السفليين.

التعليل السريري: في قصور القلب الأيمن يرتفع الضغط في الأذينة اليمنى والجهاز الوريدي الجهازي، مما يسبب تسرب السوائل إلى الأنسجة المحيطية بفعل الجاذبية، فتظهر الوذمة الانطباعية المتناظرة في الكاحلين أو المنطقة العجزية.

الخيارات الأخرى: الزلة الانتيابية الليلية عرض احتقان رئوي يميز قصور القلب الأيسر. الألم الصدري الإقفاري يوجه لداء الشرايين التاجية وليس لقصور القلب بحد ذاته. الخفقان بعود الدخول الأذيني اضطراب نظم منفصل. السعال بقشع رغوي زهري علامة وذمة رئة حادة (قصور أيسر).

الفكرة من السؤال: الوذمة المحيطية المتناظرة (الكاحلين عند المتحركين، العجزية عند طريحي الفراش) مع ارتفاع الضغط الوريدي الوداجي واحتقان الكبد هي العلامات المميزة لقصور القلب الأيمن.

8. كل مما يلي يعد من أعراض وعلامات قصور القلب الأيسر المعزول نموذجياً ما عدا: كانون 2025

A. الوذمة الانطباعية المتناظرة في الطرفين السفليين.

B. الزلة التنفسية الجهدية المترقية.

C. الصوت الثالث المسموع بالإصغاء (S3) في القمة.

D. انتباج واحتقان أوردة العنق الوداجية.

E. الخراخر الشهيقية الناعمة في قاعدتي الساحتين الرئويتين.

الإجابة الصحيحة: A — الوذمة الانطباعية المتناظرة في الطرفين السفليين.

التعليل السريري: الوذمة الانطباعية بالطرفين السفليين تنتج عن ارتفاع الضغط الوريدي الجهازي (الأذينة اليمنى)، وهذا يحدث في قصور القلب الأيمن أو ثنائي البطينات، وليس في القصور الأيسر المعزول الذي يقتصر تأثيره على الدوران الرئوي.

الخيارات الأخرى: الزلة الجهدية المترقية عرض احتقان رئوي نموذجي للقصور الأيسر. S3 بالقمة علامة امتلاء بطيني أيسر سريع مميزة للقصور الأيسر. انتباج الأوردة الوداجية يعكس ضغطاً أيمن مرتفعاً وقد يرافق القصور المتقدم لكنه ليس معزولاً بالأيسر (يجعله أقرب لخيار آخر خاطئ نسبياً، لكنه أقل تحديداً من الوذمة). الخراخر الشهيقية القاعدية علامة احتقان رئوي كلاسيكية للقصور الأيسر.

الفكرة من السؤال: قصور القلب الأيسر المعزول يعطي احتقاناً رئوياً (زلة جهدية، S3، خراخر قاعدية) بينما الوذمة المحيطية علامة احتقان جهازي تخص قصور القلب الأيمن.

9. ما هو الإجراء التشخيصي النوعي والأكثر دقة المعتمد سريريّاً لتقييم وحساب الكسر القذفي ودراسة وظيفة البطين الأيسر: كانون 2025

A. تخطيط القلب الكهربائي ECG القياسي.

B. صورة الصدر الشعاعية البسيطة.

C. اختبار الجهد الكهربائي على السير المتحرك.

D. عيار وتدبير الخمائر القلبية في المصل.

E. صدى القلب بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو).

الإجابة الصحيحة: E — صدى القلب بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو).

التعليل السريري: صدى القلب يتيح تصويراً مباشراً وحياً لحركة الجدران وحجوم البطين الأيسر، مما يسمح بحساب الكسر القذفي بدقة وتحديد السبب البنيوي (صمامي، إقفاري، أو اعتلال عضلة قلبية).

الخيارات الأخرى: ECG القياسي يعطي معلومات غير مباشرة (ضخامة، احتشاء قديم) دون قياس دقيق للوظيفة الانقباضية. صورة الصدر الشعاعية تكشف الضخامة القلبية والاحتقان دون تقييم كمي للكسر القذفي. اختبار الجهد يقيّم نقص التروية والقدرة الوظيفية وليس الكسر القذفي مباشرة. الخمائر القلبية تشخص الأذية العضلية الحادة لا الوظيفة الانقباضية المزمنة.

الفكرة من السؤال: يجب إجراء تخطيط صدى القلب عند جميع مرضى قصور القلب لتحديد السبب وتقييم شدة تأذي البطين الأيسر والكسر القذفي.

10. واحد مما يلي يعد من المشعرات والواسمات البيولوجية النوعية المستخدمة لتشخيص ومراقبة قصور القلب المزمن: كانون 2025

A. ناقلة أمين الألانين (ALT).

B. الببتيد الدماغي المدر للصوديوم (BNP).

C. ناقلة أمين الأسبارتات (AST).

D. الكرياتين فوسفوكيناز الكلي (CPK).

E. التروبونين القلبي النوعي (Troponin).

الإجابة الصحيحة: B — الببتيد الدماغي المدر للصوديوم (BNP).

التعليل السريري: يُفرز BNP من الخلايا العضلية القلبية استجابة لارتفاع الحمل القبلي وضغوط الامتلاء البطيني، فيعكس مباشرة شدة الاحتقان ودرجة قصور القلب، مما يجعله واسماً حيوياً نوعياً للتشخيص والمتابعة.

الخيارات الأخرى: ALT وAST خمائر كبدية غير نوعية لقصور القلب وإن ارتفعت ثانوياً باحتقان الكبد. CPK الكلي خميرة عضلية غير نوعية للقلب. التروبونين نوعي للأذية العضلية القلبية الحادة (الاحتشاء) وليس لقصور القلب المزمن بحد ذاته.

الفكرة من السؤال: BNP واسم حيوي نوعي يرتفع بتمدد جدران القلب ويُستخدم كاختبار كشف وأداة مراقبة في قصور القلب.

11. كل الأدوية التالية تفيد في تحسين البقيا في قصور القلب على المدى البعيد ماعدا:

تموز 2025

A. حاصرات بيتا.
B. حاصرات الخميرة المحولة للأنجيوتنسين.
C. الديجوكسين.
D. السبيرونولاكتون.
E. مثبطات SGLT2.

الإجابة الصحيحة: C — الديجوكسين.

التعليل السريري: الديجوكسين يحسن القلوصية وضبط النظم في الرجفان الأذيني المرافق لقصور القلب، مما يقلل من نوب انكسار المعاوضة والاستشفاء، لكنه لا يقطع الحلقة العصبية الهرمونية المرضية، وبالتالي لا يؤثر في معدل الوفيات طويل الأمد كما هو موثق صراحة.

الخيارات الأخرى: حاصرات بيتا تنقص الوفيات باضطرابات النظم والموت المفاجئ. مثبطات ACE تقطع الحلقة العصبية الهرمونية وتحسن البقيا. السبيرونولاكتون يحسن النتائج بعيدة المدى في القصور الشديد. مثبطات SGLT2 أثبتت تحسيناً في البقيا والاستشفاء في قصور القلب الحديث.

الفكرة من السؤال: حاصرات بيتا، مثبطات ACE، السبيرونولاكتون، ومثبطات SGLT2 تحسّن البقيا؛ أما الديجوكسين فيخفف الأعراض وينقص الاستشفاء دون تأثير مثبت على البقيا طويلة الأمد.

12. المدر الإسعافي الذي يستعمل وريدياً لعلاج وذمة الرئة الحادة هو:

تموز 2025

A. المانيتول.
B. الهيدروكلورثيازيد.
C. الفوروسيميد.
D. السبيرونولاكتون.
E. الأميلوريد.

الإجابة الصحيحة: C — الفوروسيميد.

التعليل السريري: مدرات العروة مثل الفوروسيميد تُنقص حجم البلازما بسرعة وتخفف الحمل القبلي والاحتقان الوريدي الرئوي، وهي جزء أساسي من بروتوكول تدبير وذمة الرئة الحادة إسعافياً.

الخيارات الأخرى: A) المانيتول مدر تناضحي يُستخدم في الوذمة الدماغية لا وذمة الرئة. B) الهيدروكلورثيازيد مدر ثيازيدي فموي بطيء التأثير غير مناسب للحالات الإسعافية. D) السبيرونولاكتون مدر حافظ للبوتاسيوم يُستخدم في العلاج المزمن. E) الأميلوريد مدر حافظ للبوتاسيوم لا دور إسعافي له.

الفكرة من السؤال: الفوروسيميد (مدر عروة) يُعطى وريدياً بجرعة ٥٠-١٠٠ مغ في وذمة الرئة الحادة، إلى جانب النترات والأكسجين والوضعية الجالسة.

تشرين 2024

13. كل ما يلي يؤدي إلى قصور القلب الأيسر ماعدا:

A. الصمة الرئوية الحادة.
B. تضيق الصمام الأبهري.
C. ارتفاع الضغط الشرياني المزمن غير المضبوط.
D. احتشاء العضلة القلبية الأمامي الواسع.
E. قصور الصمام التاجي الشديد.

الإجابة الصحيحة: A – الصمة الرئوية الحادة.

التعليل السريري: الصمة الرئوية تزيد المقاومة الوعائية الرئوية فجأة مما يرفع الحمل البعدي على البطين الأيمن ويسبب فشله الحاد، مع تخطيط قلب كهربائي يُظهر علامات إجهاد القلب الأيمن وتوسعه بالإيكو، دون تأثير مباشر على البطين الأيسر.

الخيارات الأخرى: B) تضيق الأبهر يسبب فرط حمل ضغطي على البطين الأيسر مؤدياً لقصوره. C) ارتفاع الضغط الشرياني المزمن يرفع الحمل البعدي على البطين الأيسر. D) الاحتشاء الأمامي الواسع يُضعف قلوصية البطين الأيسر مباشرة. E) قصور التاجي الشديد يسبب فرط حمل حجمي على البطين الأيسر.

الفكرة من السؤال: الصمة الرئوية الحادة تسبب إجهاداً وقصوراً حاداً بالبطين الأيمن (Cor pulmonale حاد) وليس قصور قلب أيسر.

تشرين 2024

14. كل ما يلي يسبب ظهور الوذمات المحيطية الانطباعية عدا:

A. قصور قلب أيمن.
B. قصور قلب أيسر.
C. حاصرات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACEIs.
D. الأمليوديبين.
E. القصور الكلوي المزمن.

الإجابة الصحيحة: C – حاصرات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACEIs.

التعليل السريري: حاصرات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين توسع الأوعية الشريانية والوريدية بشكل متوازن ولا تسبب احتباساً هيدروستاتيكياً محيطياً، بل قد تُحسّن الاحتقان في قصور القلب.

الخيارات الأخرى: A) قصور القلب الأيمن يرفع الضغط الوريدي الجهازي مسبباً وذمات. B) قصور القلب الأيسر قد يتطور لقصور أيمن ثانوي مع وذمات. D) الأمليوديبين يوسع الشرينات ويرفع الضغط الشعري مسبباً وذمة. E) القصور الكلوي المزمن يسبب احتباس ماء وصوديوم ووذمات.

الفكرة من السؤال: الوذمة الانطباعية المحيطية الناجمة عن الأدوية تترافق نموذجياً مع حاصرات قنوات الكالسيوم (كالأمليوديبين) عبر توسع شرياني انتقائي، وليس مع حاصرات ACE.

تشرين 2024

15. أي مما يلي يسبب وذمة رئة حادة قلبية المنشأ:

A. قصور القلب الأيمن.
B. قصور القلب الأيسر.
C. الصمة الرئوية.
D. الاحتشاء الرئوي.
E. التليف الرئوي.

الإجابة الصحيحة: B — قصور القلب الأيسر.

التعليل السريري: عجز البطين الأيسر عن ضخ الدم بكفاءة يرفع ضغط الامتلاء في الأذينة اليسرى والشعيرات الرئوية، فيتسرب السائل إلى الأسناخ محدثاً وذمة رئة حادة قلبية المنشأ.

الخيارات الأخرى: **A)** قصور القلب الأيمن يسبب احتقاناً جهازياً ووذمات محيطية لا رئوية. **C)** الصمة الرئوية تسبب نقص تروية رئوي لا وذمة قلبية المنشأ. **D)** الاحتشاء الرئوي نتيجة انسداد وعائي لا احتقان وريدي. **E)** التليف الرئوي مرض مزمن غير مرتبط بارتفاع الضغط الشعري الحاد.

الفكرة من السؤال: ارتفاع الضغط في الأذينة اليسرى الناجم عن قصور القلب الأيسر يرفع الضغط الشعري الرئوي محدثاً وذمة الرئة الحادة (قشع زهري رغوي، خراخر منتشرة).

16. يتضمن العلاج الدوائي الأساسي لمرضى قصور القلب كل ما يلي ماعدا:

أيار 2024

A. حاصرات بيتا.
B. حاصرات الإنزيم القالب للأنجيوتنسين.
C. المدرات في حالات فرط الحمل.
D. مضادات مستقبلات الألدوستيرون.
E. مضادات الالتصاق الصفيحي.

الإجابة الصحيحة: E — مضادات الالتصاق الصفيحي.

التعليل السريري: مضادات الالتصاق الصفيحي تُستخدم للوقاية من الأحداث الخثارية الشريانية (كالداء الإكليلي) وليست جزءاً من العلاج النوعي الموجه لتحسين وظيفة القلب أو الإنذار في قصور القلب.

الخيارات الأخرى: **A)** حاصرات بيتا تحسن البقيا والأعراض. **B)** حاصرات ACE تقطع الحلقة العصبية الهرمونية المرضية. **C)** المدرات تخفف الاحتقان عند فرط الحمل. **D)** مضادات مستقبلات الألدوستيرون تحسن الإنذار في القصور الشديد.

الفكرة من السؤال: ركائز علاج قصور القلب: حاصرات ACE/ARB، حاصرات بيتا، مضادات الألدوستيرون، والمدرات عند الاحتقان؛ مضادات الصفيحات ليست من العلاج الأساسي لقصور القلب بحد ذاته.

17. كل العلاجات التالية تفيد في تدبير وذمة الرئة الحادة ماعدا:

أيار 2024

A. نتروغليسيرين وريدي.
B. مدرات العروة.
C. حاصرات بيتا.
D. المورفين.
E. الأوكسجين.

الإجابة الصحيحة: C — حاصرات بيتا.

التعليل السريري: حاصرات بيتا تُضعف القلوصية العضلية ومعدل ضربات القلب بشكل حاد، مما قد يفاقم انخفاض النتاج القلبي ويُسرّع انكسار المعاوضة في الحالة الحادة، لذا تُستخدم فقط لاحقاً بعد الاستقرار وبشكل تدريجي.

الخيارات الأخرى: **A)** النتروغليسيرين يخفف الحمل القبلي والاحتقان الرئوي. **B)** مدرات العروة تنقص حجم البلازما والاحتقان. **D)** المورفين يخفف القلق وضيق التنفس بحذر. **E)** الأكسجين يصحح نقص الأكسجة.

الفكرة من السؤال: بروتوكول وذمة الرئة الحادة: جلوس، أكسجين عالي التركيز، نترات وريدية، مدر عروة، ± مورفين بحذر؛ حاصرات بيتا تُجنّب لتأثيرها التثبيطي السلبي على القلوصية حالياً.

18. واحدة من الآفات القلبية التالية تزيد الحمل الحجمي على البطين الأيسر: تشرين 2023

A. تضيق الدسام الأبهري.
B. قصور الدسام الأبهري.
C. تضيق برزخ الأبهر.
D. ارتفاع التوتر الشرياني الجهازي.
E. تضيق فوق الدسام الأبهري.

الإجابة الصحيحة: B — قصور الدسام الأبهري.

التعليل السريري: في قصور الأبهري يرتد جزء من الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر أثناء الانبساط إضافة للحجم القادم من الأذينة، مما يزيد حجم نهاية الانبساط ويُحمّل البطين حجمياً وفق آلية فرانك-ستارلينغ.

الخيارات الأخرى: **A)** تضيق الأبهري يفرض مقاومة انقباضية = حمل ضغطي. **C)** تضيق برزخ الأبهر يرفع الحمل البعدي = حمل ضغطي. **D)** ارتفاع التوتر الشرياني يرفع الحمل البعدي = حمل ضغطي. **E)** تضيق فوق الدسامي آلية مشابهة لتضيق الأبهر = حمل ضغطي.

الفكرة من السؤال: قصور الصمام الأبهري يسبب فرط حمل حجمي بطيني أيسر (ارتجاع الدم دياستولياً)، بينما تضيق الأبهر وارتفاع التوتر الشرياني يسببان فرط حمل ضغطي.

19. كل ما يلي من العلامات السريرية لقصور البطين الأيمن ماعدا: تشرين 2023

A. الاحتقان الوداجي.
B. الوذمات في الأطراف السفلية.
C. الخراخر الناعمة في الساحتين الرئويتين.
D. الضخامة الكبدية الممضة.
E. نفخة تزداد بالشهيق شاملة للانقباض تسمع تحت القص.

الإجابة الصحيحة: C — الخراخر الناعمة في الساحتين الرئويتين.

التعليل السريري: قصور البطين الأيمن يرفع الضغط الوريدي الجهازي فيسبب احتقاناً وريدياً محيطياً وكبدياً ووذمات، بينما الخراخر الرئوية تعكس احتقاناً وريدياً رئوياً ناجماً عن قصور القلب الأيسر وليس الأيمن.

الخيارات الأخرى: **A)** الاحتقان الوداجي علامة كلاسيكية لقصور الأيمن. **B)** الوذمات السفلية من علامات قصور الأيمن الجهازي. **D)** الضخامة الكبدية الممضة تعكس الاحتقان الوريدي الكبدي. **E)** نفخة القصور مثلث الشرف تزداد بالشهيق (علامة كارفالو) وتشير لقصور أيمن.

الفكرة من السؤال: الخراخر الرئوية الناعمة علامة لقصور القلب الأيسر (احتقان رئوي)، بينما احتقان الأوداج، الوذمات، الضخامة الكبدية المؤلمة، ونفخة القصور مثلث الشرف علامات قصور القلب الأيمن.

20. كل ما يلي يستخدم في علاج وذمة الرئة الحادة ما عدا: تشرين 2023

A. الفورسميد.
B. كارفيديول.
C. المورفين.
D. أوكسجين.
E. النترات وريدياً.

الإجابة الصحيحة: B – كارفيديول.

التعليل السريري: في الحالة الحادة يحتاج القلب لدعم قلوصيته لا تثبيطها؛ حاصرات بيتا تُضعف الاستجابة الودية التعويضية وقد تُسرّع الانحلال الهيموديناميكي، لذا تُدخل لاحقاً بعد الاستقرار التام وبالتدريج.

الخيارات الأخرى: **A)** الفوروسميد مدر عروة إسعافي أساسي. **C)** المورفين يخفف الزلة والقلق. **D)** الأكسجين يصحح نقص الأكسجة. **E)** النترات وريدياً تخفف الحمل القبلي والاحتقان.

الفكرة من السؤال: كارفيديلول حاصر بيتا يُستخدم في العلاج المزمن التدريجي لقصور القلب المستقر، لا في المعالجة الإسعافية الحادة لوذمة الرئة.

آذار 2023

21. تحسن الأدوية التالية إنذار قصور القلب ما عدا:

A. حاصرات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.
B. حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين.
C. حاصرات بيتا.
D. الديجوكسين.
E. السبيرونولاكتون.

الإجابة الصحيحة: D – الديجوكسين.

التعليل السريري: الديجوكسين يُحسّن القلوصية وضبط النظم في الرجفان الأذيني المرافق لقصور القلب، وقد يُقلل من مرات دخول المشفى عند المرضى الشديدين، لكن الدراسات لم تُظهر تحسناً في معدل الوفيات طويل الأمد كما هو الحال مع الأدوية الأخرى.

الخيارات الأخرى: **A)** حاصرات ACE تُحسّن البقيا في القصور المتوسط إلى الشديد. **B)** حاصرات ARB لها نفس الفائدة على الوفيات كحاصرات ACE. **C)** حاصرات بيتا تُقلل اللانظميات والموت المفاجئ وتُحسّن البقيا. **E)** السبيرونولاكتون يُحسّن النتائج بعيدة المدى في القصور الشديد.

الفكرة من السؤال: حاصرات ACE/ARB، حاصرات بيتا، ومضادات الألدوستيرون تُحسّن الوفيات في قصور القلب؛ الديجوكسين يُنقص معدل الاستشفاء فقط دون تأثير على البقيا طويلة الأمد.

آذار 2023

22. في قصور القلب المزمن كل ما يلي صحيح ما عدا:

A. تنجم الزلات بأنواعها عن قصور القلب الأيمن.
B. الوذمات من العلامات الهامة.
C. القصور الكلوي من اختلاطات قصور القلب.
D. نقص الصوديوم قد يكون تمددياً أو بسبب المدرات.
E. يحدث الموت المفاجئ بسبب اضطرابات النظم البطينية على الأغلب.

الإجابة الصحيحة: A – تنجم الزلات بأنواعها عن قصور القلب الأيمن.

التعليل السريري: ارتفاع ضغط الأذينة اليسرى في قصور القلب الأيسر يرفع الضغط الشعري الرئوي مسبباً احتقاناً رئوياً وزلة جهدية واضطجاعية وليلية انتيابية، وهذا ما يجعل العبارة A خاطئة إذ تنسب الزلات خطأً لقصور القلب الأيمن.

الخيارات الأخرى: **B)** الوذمات فعلاً من العلامات الهامة في قصور القلب المزمن. **C)** القصور الكلوي اختلاط معروف بسبب سوء التروية الكلوية. **D)** نقص الصوديوم قد يكون تمددياً أو بفعل المدرات كما ذُكر. **E)** الموت المفاجئ يحدث غالباً بسبب اللانظميات البطينية.

الفكرة من السؤال: الزلة التنفسية بأنواعها تعكس الاحتقان الوريدي الرئوي الناجم عن قصور القلب الأيسر؛ قصور القلب الأيمن يتظاهر باحتقان جهازي (وذمات، احتقان كبدي) لا بالزلة.

23. كل ما يلي من طرق تدبير وذمة الرئة الحادة ما عدا: أيلول 2022

A. وضعية الاضطجاع الظهري.
B. اوكسجين عالي التركيز.
C. مراقبة مستمرة للضغط.
D. مراقبة مستمرة لنظم القلب.
E. إعطاء الفيروماسيد الوريدي.

الإجابة الصحيحة: A – وضعية الاضطجاع الظهري.

التعليل السريري: الاستلقاء الظهري يرفع العود الوريدي إلى القلب فيزيد الضغط الشعري الرئوي ويُفاقم وذمة الرئة والزلة التنفسية، بعكس وضعية الجلوس التي تُنقص الحمل القبلي وتُريح المريض.

الخيارات الأخرى: B) الأكسجين عالي التركيز (٦٠٪) جزء أساسي من البروتوكول. C) مراقبة الضغط الشرياني ضرورية لتقييم الاستجابة والجرعات. D) مراقبة نظم القلب تكشف اضطرابات النظم المطلقة أو المرافقة. E) الفوروسميد الوريدي مدر عروة أساسي في العلاج.

الفكرة من السؤال: وضع المريض بوضعية الجلوس يُخفف الاحتقان الرئوي عبر تقليل العود الوريدي؛ الاضطجاع الظهري يزيد العود الوريدي ويُفاقم الاحتقان والزلة.

24. التشخيص المؤكد لقصور القلب هو: أيلول 2022

A. القصة السريرية المتأنية.
B. تخطيط كهربائية القلب.
C. صور الصدر الشعاعية البسيطة.
D. اختبار تحمل الجهد.
E. تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية.

الإجابة الصحيحة: E – تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية.

التعليل السريري: الإيكو يقدم دليلاً مباشراً على الآلية المرضية (اضطراب حركة الجدار، الآفات الصمامية، الكسر القذفي) وهو ما يحول الشك السريري إلى تشخيص مؤكد.

الخيارات الأخرى: A) القصة السريرية توجه الشك لكنها غير كافية للتأكيد - B) ECG قد يشير للسبب لكنه غير نوعي - C) صورة الصدر تدعم التشخيص دون تأكيده - D) اختبار الجهد يقيّم الإقفار لا قصور القلب مباشرة.

الفكرة من السؤال: الإيكو يحدد الآفة السببية (صمامية، إقفارية) ويقيّم شدة تأذي البطين الأيسر؛ يجب إجراؤه عند كل مرضى قصور القلب.

25. تؤدي كل من الأمراض التالية إلى قصور قلب عالي النتاج (إجابة خاطئة وحيدة): آذار 2022

A. الانسمام الدرقي.
B. القناة الشريانية الكبيرة.
C. فقر الدم الشديد.
D. داء باجيت.
E. تضيق الصمام التاجي.

الإجابة الصحيحة: E — تضيق الصمام التاجي.

التعليل السريري: تضيق الصمام التاجي يعيق امتلاء البطين الأيسر فيخفض النتاج القلبي، وهو آلية مغايرة تماماً لآليات قصور القلب عالي النتاج التي تعتمد على زيادة الحاجة الاستقلابية المحيطية أو التحويلة الشريانية الوريدية.

الخيارات الأخرى: **A)** التسمم الدرقي يرفع الاستقلاب فيزيد النتاج - **B)** القناة الشريانية الكبيرة تحدث تحويلة يسرى-يمنى تزيد الحمل - **C)** فقر الدم الشديد ينقص اللزوجة ويزيد النتاج تعويضياً - **D)** داء باجيت يزيد الجريان الدموي العظمي.

الفكرة من السؤال: قصور القلب عالي النتاج ينجم عن حالات تزيد الحاجة الاستقلابية أو تخلق تحويلة شريانية وريدية (تسمم درقي، فقر دم شديد، PDA، باجيت، بري بري)؛ أما تضيق التاجي فيسبب انخفاض النتاج.

26. يعد كل مما يلي من الأدوية المستخدمة لعلاج قصور القلب المزمن (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. مدرات العروة.

B. ACE.

C. النترات.

D. ARB.

E. حاصرات الكلس.

الإجابة الصحيحة: E — حاصرات الكلس.

التعليل السريري: حاصرات الكلس تنقص القلوصية العضلية القلبية وتزيد الحمل الديناميكي السلبي على البطين الفاشل، لذا لا تدخل ضمن بروتوكولات علاج قصور القلب المزمن خلافاً للأدوية الأخرى المذكورة.

الخيارات الأخرى: **A)** مدرات العروة تخفض الحمل القبلي وتحسن الاحتقان - **B)** ACEI تقطع الحلقة العصبية الهرمونية المفرغة - **C)** النترات موسعة وريدية تخفض الحمل القبلي - **D)** ARB بديل فعال عند عدم تحمل ACEI.

الفكرة من السؤال: حاصرات قنوات الكالسيوم (غير ثنائية الهيدروبيريدين خاصة) لها تأثير مثبط للقلوصية وليست من علاجات قصور القلب المزمن القياسية، بل قد تفاقمه.

27. الاختبار الأهم لتشخيص قصور القلب:

حزيران 2021

A. الأمواج فوق الصوتية.

B. تخطيط القلب.

C. صورة الصدر البسيطة.

D. اختبار الجهد.

E. القصة المرضية المتأنية.

الإجابة الصحيحة: A — الأمواج فوق الصوتية.

التعليل السريري: يوفر الإيكو تقييماً تشريحياً ووظيفياً مباشراً للبطينين والصمامات، مما يجعله الاختبار الأكثر أهمية لتأكيد التشخيص وتحديد السبب.

الخيارات الأخرى: **B)** ECG قد يوجه للسبب لكنه غير نوعي - **C)** صورة الصدر تدعم لكنها غير كافية للتأكيد - **D)** اختبار الجهد يقيّم الإقفار أساساً - **E)** القصة المرضية تثير الشك لكنها ذاتية وغير كافية للتأكيد.

الفكرة من السؤال: الإيكو يقيّم الوظيفة الانقباضية والانبساطية والآفات الصمامية معاً، وهو حجر الأساس التشخيصي عند كل مرضى قصور القلب.

28. في قصور القلب المزمن، كل ما يلي صحيح ما عدا: حزيران 2021

A. اضطرابات النظم.
B. انخفاض البوتاسيوم.
C. فرط الصوديوم.
D. ارتفاع الكرياتنين.
E. ارتفاع البوتاسيوم.

الإجابة الصحيحة: C – فرط الصوديوم.

التعليل السريري: الاحتباس غير المتناسب للماء بسبب فرط إفراز الهرمون المضاد للإدرار أو استخدام المدرات يؤدي لنقص الصوديوم المصلي (دلالة سوء إنذار)، وليس فرط الصوديوم كما تنص العبارة الخاطئة.

الخيارات الأخرى: **A)** اضطرابات النظم شائعة بسبب اضطراب الشوارد والتفعيل الودي - **B)** نقص البوتاسيوم ناجم عن المدرات - **D)** القصور الكلوي بسبب سوء التروية الكلوية - **E)** فرط البوتاسيوم بسبب ACEI/سبيرونولاكتون وسوء الوظيفة الكلوية.

الفكرة من السؤال: في قصور القلب المتقدم يشيع نقص الصوديوم (سوء إنذار) وليس فرط الصوديوم، إضافة لاضطرابات البوتاسيوم (نقصاً أو فرطاً حسب العلاج) والقصور الكلوي واضطرابات النظم.

29. مريض لديه قصور قلب أيسر حاد كل ما يلي صحيح ما عدا: تشرين 2020

A. من الأسباب الرجفان الأذيني مع استجابة بطينية سريعة.
B. الهياج والشحوب.
C. التخطيط يفيد بتحديد السبب العضلي القلبي.
D. وجود خطوط كيرلي B.
E. تسمع خراخر ناعمة في قاعدتي الرئتين في نهاية الشهيق.

الإجابة الصحيحة: C – التخطيط يفيد بتحديد السبب العضلي القلبي.

التعليل السريري: تحديد السبب البنيوي (العضلي/الصمامي) لقصور القلب الأيسر الحاد يعتمد أساساً على تخطيط صدى القلب، وليس تخطيط القلب الكهربائي الذي يفيد أكثر في كشف الاحتشاء أو اضطراب النظم كعامل مطلق.

الخيارات الأخرى: AFib **(A)** مع استجابة بطينية سريعة سبب معروف خاصة مع تضيق تاجي - **B)** الهياج والشحوب من المظاهر النموذجية - **D)** خطوط كيرلي B علامة شعاعية مميزة لوذمة الرئة - **E)** الخراخر الشهيقية القاعدية موجودة نموذجياً.

الفكرة من السؤال: ECG يساعد في كشف السبب المطلق (احتشاء، اضطراب نظم)، بينما الإيكو هو الاستقصاء الذي يحدد الآفات البنيوية والصمامية المستبطنة.

30. مريض قصور قلب مزمن الإجابة الصحيحة): تشرين 2020

A. تعب وكسل وتحمل سيء للجهد.
B. شاحب ومتهيج.
C. زلة تنفسية مفاجئة.
D. صدمة القمة غير منزاحة.
E. لديه فرط صوديوم.

الإجابة الصحيحة: A – تعب وكسل وتحمل سيء للجهد.

التعليل السريري: انخفاض النتاج القلبي المستمر في الحالة المزمنة يقلل التروية العضلية المحيطية فيسبب تعباً وكسلاً وتحملاً سيئاً للجهد، وهي السمة السريرية المميزة لقصور القلب المزمن.

الخيارات الأخرى: **B)** الشحوب والتهيج أكثر توافقاً مع الصورة الحادة - **C)** الزلة المفاجئة نموذجية للقصور الحاد لا المزمن - **D)** صدمة القمة تكون منزاحة بسبب توسع البطين المزمن - **E)** الشائع هو نقص الصوديوم لا فرطه.

الفكرة من السؤال: قصور القلب المزمن يتظاهر بتعب وكسل وتحمل سيء للجهد نتيجة انخفاض النتاج القلبي المزمن، خلافاً للصورة الحادة الهياجية.

---

31. من الأسباب الشائعة لقصور القلب عند البالغين كل ما يلي عدا:

تشرين 2020

A. تشوهات القلب الخلقية.
B. احتشاء عضلة قلبية سابق.
C. ارتفاع ضغط الدم الدم المزمن غير المعالج.
D. اعتلال عضلة القلب التوسعي.
E. داء السكري مع اعتلال القلب السكري.

الإجابة الصحيحة: A – تشوهات القلب الخلقية.

التعليل السريري: التشوهات القلبية الخلقية هي سبب رئيسي لقصور القلب في مرحلة الطفولة وليست من الأسباب الشائعة عند البالغين، الذين تغلب عندهم الأسباب المكتسبة (إقفارية، ضغطية، استقلابية).

الخيارات الأخرى: **B)** الاحتشاء السابق سبب رئيسي شائع - **C)** ارتفاع الضغط المزمن غير المعالج سبب شائع جداً - **D)** اعتلال العضلة التوسعي من الأسباب الشائعة - **E)** اعتلال القلب السكري سبب استقلابي شائع.

الفكرة من السؤال: الأسباب الشائعة لقصور القلب عند البالغين تشمل الداء الإقفاري وارتفاع الضغط المزمن واعتلال العضلة القلبية والداء السكري؛ التشوهات الخلقية أشيع كسبب عند الأطفال.

---

32. واحد مما يلي يسبب فرط حمل ضغطي على البطين الأيمن:

حزيران 2020

A. قصور مثلث الشرف.
B. قصور رئوي.
C. تضيق أبهري.
D. ارتفاع التوتر الجهازي.
E. ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي.

الإجابة الصحيحة: E – ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي.

التعليل السريري: ارتفاع المقاومة الوعائية الرئوية يفرض على البطين الأيمن ضخ الدم ضد ضغط أعلى بشكل مزمن، فيحدث فرط حمل ضغطي (تلوي) على البطين الأيمن يؤدي لضخامته ثم قصوره.

الخيارات الأخرى: **A)** قصور مثلث الشرف يسبب فرط حمل حجمي لا ضغطي - **B)** القصور الرئوي فرط حمل حجمي - **C)** تضيق الأبهري فرط حمل ضغطي على البطين الأيسر - **D)** ارتفاع التوتر الجهازي يحمّل البطين الأيسر.

الفكرة من السؤال: فرط الضغط الشرياني الرئوي وتضيق الصمام الرئوي يسببان فرط حمل ضغطي على البطين الأيمن؛ بينما ارتفاع التوتر الجهازي وتضيق الأبهر يسببان ذلك على البطين الأيسر.

---

33. كل مما يلي صحيح فيما يخص ACEI ما عدا: حزيران 2020

A. تسبب نقص بوتاسيوم.
B. لا تستخدم في قصور القلب غير المعاوض.
C. تقطع الحلقة المفرغة للتفعيل العصبي الهرموني.
D. تحسن من تحمل الجهد.
E. تستخدم في علاج ارتفاع الضغط الشرياني.

الإجابة الصحيحة: A – تسبب نقص بوتاسيوم.

التعليل السريري: تثبيط الأنجيوتنسين II يقلل إفراز الألدوستيرون فيقل إطراح البوتاسيوم الكلوي، مما يؤدي لفرط بوتاسيوم المصل وليس نقصه، خاصة عند مشاركتها مع السبيرونولاكتون أو وجود قصور كلوي.

الخيارات الأخرى: **B)** صحيح أنها لا تستخدم في القصور الحاد غير المعاوض بسبب خطر هبوط الضغط - **C)** صحيح أنها تقطع الحلقة العصبية الهرمونية المفرغة - **D)** صحيح أنها تحسن تحمل الجهد والبقيا - **E)** صحيح أنها من علاجات ارتفاع الضغط الشرياني الأساسية.

الفكرة من السؤال: ACEI تسبب فرط بوتاسيوم (وليس نقصاً) بسبب تثبيط الألدوستيرون، وتقطع الحلقة العصبية الهرمونية المفرغة في قصور القلب المزمن، وتحسّن البقيا وتحمل الجهد.

34. يصادف كل مما يلي في قصور القلب المتقدم عدا: تشرين 2019

A. فرط الصوديوم المصلي.
B. فرط البوتاسيوم المصلي.
C. نقص البوتاسيوم المصلي.
D. القصور الكلوي.
E. نقص المغنزيوم.

الإجابة الصحيحة: A – فرط الصوديوم المصلي.

التعليل السريري: الاحتباس غير المتناسب للماء الناجم عن فرط إفراز الهرمون المضاد للإدرار والعلاج المدر يؤدي لنقص الصوديوم المصلي وليس فرطه، وهو ما يجعل "فرط الصوديوم" العبارة الخاطئة والاستثناء الصحيح في السؤال.

الخيارات الأخرى: **B)** فرط البوتاسيوم يصادف بسبب ACEI والسبيرونولاكتون والقصور الكلوي - **C)** نقص البوتاسيوم يصادف بسبب المدرات - **D)** القصور الكلوي شائع بسبب سوء التروية والعلاج الدوائي - **E)** نقص المغنزيوم شائع مع العلاج المدر المزمن.

الفكرة من السؤال: قصور القلب المتقدم يترافق نموذجياً مع نقص الصوديوم (سوء إنذار)، اضطرابات البوتاسيوم (نقصاً بالمدرات أو فرطاً بـACEI/سبيرونولاكتون)، القصور الكلوي، ونقص المغنزيوم.

35. مريض لديه منذ ساعات زلة مع تعرق بارد وهياج وسعال منتج القشع زهري رغوي، ما التشخيص: تشرين 2019

A. قصور قلب أيمن حاد.
B. قصور قلب أيسر حاد.
C. ريح صدرية.
D. احتشاء رئوي.
E. ذات رئة.

الإجابة الصحيحة: B — قصور قلب أيسر حاد.

التعليل السريري: الارتفاع الحاد في ضغط الأذينة اليسرى يرفع الضغط الشعري الرئوي محدثاً وذمة رئة سنخية تتظاهر بزلة مفاجئة، هياج وشحوب، تعرق بارد، وقشع زهري رغوي مميز، مع خراخر منتشرة عند الإصغاء.

الخيارات الأخرى: **A)** قصور القلب الأيمن الحاد يعطي احتقاناً وريدياً محيطياً لا وذمة رئة - **C)** الريح الصدرية تعطي ألماً وزلة مفاجئة دون قشع زهري - **D)** الاحتشاء الرئوي يترافق عادة بألم جنبي ونفث دم لا قشعاً رغوياً زهرياً - **E)** ذات الرئة تترافق بحمى وقشع صديدي لا زهري رغوي نموذجي.

الفكرة من السؤال: زلة حادة، تعرق بارد، هياج، وقشع زهري رغوي هي الرباعية الكلاسيكية لوذمة الرئة الحادة الناجمة عن قصور القلب الأيسر الحاد.

---

36. أي الأدوية التالية يحسن الأعراض دون تحسين البقيا في قصور القلب:

شباط 2019

A. حاصر بيتا.
B. مثبطات ACE.
C. مدرات العروة.
D. الهيدرالازين والنيترات.
E. سبيرونولاكتون.

الإجابة الصحيحة: C — مدرات العروة.

التعليل السريري: تعمل مدرات العروة على إنقاص حجم البلازما وبالتالي الحمل القبلي، مما يحسن الأعراض الاحتقانية (الزلة التنفسية والوذمات) بشكل سريع وفعال، إلا أن تأثيرها يقتصر على الأعراض دون أن يقطع الحلقة العصبية الهرمونية المرضية المسؤولة عن تطور المرض والوفاة.

الخيارات الأخرى: **A)** حاصر بيتا يحسن الأعراض ويقلل الوفيات إذا استخدم بشكل ملائم؛ **B)** مثبطات ACE تقطع الحلقة العصبية الهرمونية وتحسن البقيا؛ **D)** الهيدرالازين والنيترات مفيدة هيموديناميكياً وقد تحسن البقيا كبديل عند مضاد استطباب ACE/ARB؛ **E)** السبيرونولاكتون يحسّن النتائج بعيدة المدى في قصور القلب الشديد.

الفكرة من السؤال: مدرات العروة (مثل الفوروسيميد) تنقص الحمل القبلي وتخفف الاحتقان الرئوي والجهازي بسرعة، لكن لا يوجد دليل على أنها تحسن الوفيات في قصور القلب المزمن، بعكس مثبطات ACE وحاصرات بيتا والسبيرونولاكتون.

الداء الإكليلي

40 سؤال

1. مريض 55 سنة لديه ألم صدري عند الجهد يزول بالراحة خلال 5 دقائق، التشخيص الأرجح:

أيار 2026

A. خناق صدر مستقر.
B. التهاب التامور.
C. تسلخ الأبهر.
D. احتشاء عضلة قلبية حاد دون ارتفاع ST.
E. احتشاء عضلة قلبية حاد مع ارتفاع ST.

الإجابة الصحيحة: A — خناق صدر مستقر.

التعليل السريري: الألم المرتبط بالجهد والذي يزول سريعاً بالراحة يعكس نقص تروية عابر ناجم عن عدم توازن بين العرض والطلب الأكسجيني للعضلة القلبية بسبب تضيق إكليلي ثابت، دون حدوث نخر عضلي.

الخيارات الأخرى: **B)** التهاب التامور ألم يتغير بالوضعية والتنفس ولا يرتبط بالجهد بهذا النمط؛ **C)** تسلخ الأبهر ألم مزق شديد مفاجئ؛ **D)** و**E)** الاحتشاء واحتشاء NSTEMI يكون الألم أطول وأشد ولا يزول بالراحة بهذه السرعة.

الفكرة من السؤال: الذبحة المستقرة: ألم صدري مركزي يتحرض بالجهد أو الكرب ويخف فوراً عند الراحة (عادة خلال دقائق)، ولا يترافق بأذية عضلة قلبية.

2. ارتفاع التروبونين يدل على واحد مما يلي: أيار 2026

A. نقص أكسجة.
B. أذية عضلة القلب.
C. التهاب التامور.
D. فشل كلوي.
E. ارتفاع ضغط الدم.

الإجابة الصحيحة: B — أذية عضلة القلب.

التعليل السريري: التروبونين بروتين تنظيمي داخل الخلية العضلية القلبية، وتحرره إلى الدوران يدل على تخرب الغشاء الخلوي ونخر أو أذية الخلايا العضلية القلبية بغض النظر عن السبب المباشر.

الخيارات الأخرى: **A)** نقص الأكسجة قد يسبب أذية قلبية ثانوية لكنه ليس التفسير المباشر لارتفاع التروبونين بحد ذاته؛ **C)** التهاب التامور لا يرفع التروبونين إلا إذا ترافق بإصابة عضلية (التهاب عضلة وتامور)؛ **D)** القصور الكلوي قد يسبب ارتفاعاً مزمناً خفيفاً بسبب نقص الطرح، لكنه ليس التفسير الأساسي المقصود؛ **E)** ارتفاع ضغط الدم ليس سبباً مباشراً لارتفاع التروبونين.

الفكرة من السؤال: التروبونينات القلبية T و I تتحرر من الخلايا العضلية القلبية المتأذية، وترتفع خلال ٤-٦ ساعات وتبقى مرتفعة حتى أسبوعين، وهي واسم نوعي لأذية العضلة القلبية.

3. أي مما يلي هو العامل الأكثر خطورة لإحداث تصلب الشرايين: أيار 2026

A. مرتفع HDL.
B. منخفض LDL.
C. التدخين.
D. نقص الصوديوم.
E. فرط الكالسيوم.

الإجابة الصحيحة: C — التدخين.

التعليل السريري: يسبب التدخين أذية بطانية مباشرة وحالة التهابية وفرط تخثر تسرّع تشكل العصيدة وتزيد احتمال تمزق اللويحة والخثار، مما يجعله من أقوى عوامل الخطورة القابلة للتعديل المرتبطة بالجرعة.

الخيارات الأخرى: **A)** ارتفاع HDL عامل وقائي وليس خطورة؛ **B)** انخفاض LDL عامل وقائي؛ **D)** نقص الصوديوم ليس من عوامل خطورة التصلب العصيدي المعروفة؛ **E)** فرط الكالسيوم ليس عامل خطورة رئيسياً موثقاً لتصلب الشرايين.

الفكرة من السؤال: يوجد علاقة قوية مرتبطة بالجرعة بين تدخين السجائر وداء الشريان الإكليلي؛ الإقلاع عن التدخين هو أهم تعديل لنمط الحياة في الوقاية من التصلب العصيدي.

4. مريض عمره 58 عاماً يشكو منذ أسبوع من ألم في منتصف الصدر ضاغط خلف القص يحدث عند المشي ويخف بعد حوالي دقيقتين من الراحة، التشخيص الأكثر احتمالاً: كانون 2025

A. خناق صدر مستقر.
B. خناق صدر غير مستقر.
C. التهاب تامور حاد.
D. ألم عضلي هيكلي جداري.
E. احتشاء عضلة قلبية حاد.

الإجابة الصحيحة: A — خناق صدر مستقر.

التعليل السريري: الاستقرار الزمني للنمط (نفس المحرض، نفس مدة الزوال بالراحة) يعكس تضيقاً إكليلياً ثابتاً يسبب نقص تروية عابر عند زيادة الطلب الأكسجيني بالجهد، دون تطور نحو تمزق لويحة أو خثار حاد.

الخيارات الأخرى: **B)** الذبحة غير المستقرة تكون حديثة العهد أو متفاقمة أو تحدث على الراحة؛ **C)** التهاب التامور ألم يتأثر بالوضعية والتنفس؛ **D)** الألم الجداري يتحرض بالحركة أو الجس؛ **E)** الاحتشاء الحاد يكون الألم أشد وأطول ولا يزول بالراحة.

الفكرة من السؤال: ألم ضاغط خلف القص يتحرض بالمشي ويخف خلال دقائق قليلة من الراحة، مستمر منذ أيام إلى أسابيع دون تغير في الشدة أو التواتر = ذبحة مستقرة.

---

5. مريض لديه ألم صدري خناقي حاد حديث الصفات ظهر أثناء الراحة، وبمعايرة التروبونين تبين وجود ارتفاع مصلّي دون وجود تزحل ST للأعلى على تخطيط القلب، التشخيص الأرجح هو: كانون 2025

A. Non-STEMI.

B. STEMI.

C. خناق صدر مستقر.

D. خناق برنز ميتال التشنجي.

E. التهاب تامور حاد.

الإجابة الصحيحة: A — Non-STEMI.

التعليل السريري: وجود واسم أذية عضلية إيجابي (التروبونين) يميز NSTEMI عن الذبحة غير المستقرة (حيث لا ترتفع الواسمات)، بينما غياب تزحل ST للأعلى يميزه عن STEMI الذي يتطلب إعادة تروية فورية.

الخيارات الأخرى: **B)** STEMI يترافق بتزحل ST للأعلى؛ **C)** الذبحة المستقرة لا تحدث على الراحة ولا ترفع التروبونين؛ **D)** خناق برنزميتال تشنجي عابر مع تزحل ST مؤقت للأعلى وليس ارتفاعاً ثابتاً بالتروبونين بهذا النمط؛ **E)** التهاب التامور لا يعطي هذه الصورة النموذجية دون تغيرات ST المميزة له.

الفكرة من السؤال: ألم خناقي حاد على الراحة + ارتفاع التروبونين + غياب تزحل ST للأعلى = NSTEMI (أذية عضلية فعلية دون احتشاء عابر لكامل سماكة الجدار).

---

6. يشير وجود ارتفاع حاد في قطعة ST (تزحل للأعلى) على المساري التخطيطية الصدرية من V1 إلى V4 في تخطيط القلب إلى وجود: كانون 2025

A. احتشاء عضلة قلبية أمامي حاد.

B. احتشاء عضلة قلبية سفلي حاد.

C. احتشاء عضلة قلبية جانبي حاد.

D. احتشاء عضلة قلبية خلفي حاد.

E. احتشاء معزول في البطين الأيمن.

الإجابة الصحيحة: A — احتشاء عضلة قلبية أمامي حاد.

التعليل السريري: كل مسرى تخطيطي يعكس النشاط الكهربائي لمنطقة تشريحية محددة من العضلة القلبية؛ المساري الصدرية V1-V4 تواجه الجدار الأمامي الحاجزي الذي يرويه الشريان الإكليلي الأيسر الأمامي النازل، فيظهر فيها تزحل ST للأعلى عند احتشاء هذه المنطقة.

الخيارات الأخرى: **B)** الاحتشاء السفلي تظهر تغيراته في II وIII وaVF؛ **C)** الاحتشاء الجانبي في V4-V6 وaVL وI؛ **D)** الاحتشاء الخلفي لا يعطي ارتفاع ST في المساري المعيارية بل تغيرات غير مباشرة في V1-V4؛ **E)** احتشاء البطين الأيمن المعزول له مساري خاصة (V4R) وليس V1-V4 القياسية.

الفكرة من السؤال: تزحل ST للأعلى في V1-V4 يدل على احتشاء أمامي حاجزي (أمامي)؛ V4-V6 وaVL وI للاحتشاء الأمامي الجانبي؛ II وIII وaVF للاحتشاء السفلي.

---

7. كل ما يلي صحيح فيما يخص نقص التروية القلبية ماعدا:

تموز 2025

A. يحصل الألم الصدري في الخناق المستقر على الجهد ويخف بالراحة.
B. قد يفيد النتروغليسرين في تخفيف الألم الصدري الخناقي.
C. الألم الصدري الناخز الذي يمكن الإشارة إليه بأصبع واحدة يوجه نحو نفي التشخيص عادة.
D. يرتفع عيار التروبونين في احتشاء العضلة القلبية.
E. يستطب إجراء اختبار الجهد لتأكيد التشخيص في خناق الصدر غير المستقر.

الإجابة الصحيحة: E — يستطب إجراء اختبار الجهد لتأكيد التشخيص في خناق الصدر غير المستقر.

التعليل السريري: في خناق الصدر غير المستقر توجد لويحة عصيدية غير مستقرة مع خطر تطور فوري نحو احتشاء أو موت مفاجئ، فإجراء اختبار جهد (الذي يزيد الطلب الأكسجيني القلبي) في هذه المرحلة الحادة غير آمن وغير مستطب؛ التشخيص يعتمد على القصة والتخطيط والواسمات الحيوية.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح أن ألم الخناق المستقر يحدث بالجهد ويخف بالراحة؛ **B)** النتروغليسرين يخفف الألم الخناقي فعلاً؛ **C)** الألم الناخز الموضع بإصبع واحد يوجه لنفي المنشأ القلبي؛ **D)** التروبونين يرتفع فعلاً في احتشاء العضلة القلبية.

الفكرة من السؤال: اختبار الجهد يستخدم في تقييم الذبحة المستقرة، أما في خناق الصدر غير المستقر فالمريض يُقبل بالمستشفى للمراقبة والتدبير الدوائي/التداخلي، وليس لإجراء اختبار جهد لتأكيد التشخيص.

---

8. الألم الصدري الذي يأتي على الجهد ويخف على الراحة وبتناول النتروغليسرين هو:

تشرين 2024

A. خناق صدر مستقر.
B. خناق صدر غير مستقر.
C. احتشاء عضلة قلبية.
D. صمة رئوية ناكسة.
E. تشنج كولون.

الإجابة الصحيحة: A — خناق صدر مستقر.

التعليل السريري: زيادة الطلب الأكسجيني أثناء الجهد يتجاوز قدرة الشريان المتضيق على التروية فيحدث نقص تروية عابر مؤلم، ويعود التوازن عند تخفيف الجهد (الراحة) أو عند توسيع الأوعية بالنترات، فيزول الألم سريعاً.

الخيارات الأخرى: **B)** الذبحة غير المستقرة تحدث على الراحة أو بجهد أقل تدريجياً دون ارتباط ثابت بالجهد فقط؛ **C)** احتشاء العضلة القلبية لا يزول بالنتروغليسرين عادة؛ **D)** الصمة الرئوية الناكسة لا علاقة لها بالجهد بهذا النمط ولا تستجيب للنترات؛ **E)** تشنج القولون له طابع ألم مختلف تماماً وغير مرتبط بالجهد أو النترات.

الفكرة من السؤال: الألم الذي يتحرض بالجهد ويخف بالراحة أو بالنتروغليسرين تحت اللسان خلال ٢-٣ دقائق هو السمة المميزة للذبحة المستقرة.

9. يزول الألم الصدري الخناقي المستقر عند تناول واحدة من المجموعات التالية: تشرين 2024

A. حاصرات بيتا.
B. حاصرات ألفا.
C. النتروغليسرين.
D. مثبطات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.
E. حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين.

الإجابة الصحيحة: C – النتروغليسرين.

التعليل السريري: تعمل النترات على تحرير أكسيد النتريك مما يسبب توسعاً وريدياً بشكل رئيسي (إنقاص الحمل القبلي وحاجة العضلة القلبية للأكسجين) وتوسعاً في الشرايين الإكليلية أيضاً، فيتحسن التوازن بين العرض والطلب الأكسجيني بسرعة ويزول الألم.

الخيارات الأخرى: **A)** حاصرات بيتا وقائية طويلة الأمد وليست لعلاج النوبة الحادة الفورية؛ **B)** حاصرات ألفا ليست من الأدوية المضادة للذبحة القياسية؛ **D)** و**E)** مثبطات ACE وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين تفيد في الوقاية الثانوية وليس في تخفيف نوبة الألم الحادة.

الفكرة من السؤال: النتروغليسرين تحت اللسان (مضغوطات أو بخاخ) يخفف نوبة الذبحة خلال ٢-٣ دقائق عبر توسيع الأوردة (إنقاص الحمل القبلي) والشرايين الإكليلية.

10. كل ما يلي يعد من أسباب الألم الصدري الحاد عدا: تشرين 2024

A. الريح الصدرية.
B. الصمة الرئوية.
C. التهاب البنكرياس الحاد.
D. تسلخ الأبهر.
E. احتشاء العضلة القلبية الحاد.

الإجابة الصحيحة: C – التهاب البنكرياس الحاد.

التعليل السريري: التهاب البنكرياس الحاد آفة بطنية تسبب ألماً شرسوفياً ينتشر نحو الظهر عادة، وليس من الأسباب النموذجية المصنفة ضمن الألم الصدري الحاد رغم إمكانية الالتباس التشخيصي أحياناً.

الخيارات الأخرى: **A)** الريح الصدرية سبب مباشر لألم صدري حاد مع زلة تنفسية؛ **B)** الصمة الرئوية سبب شائع ومهم للألم الصدري الحاد؛ **D)** تسلخ الأبهر يسبب ألماً صدرياً مزقياً شديداً؛ **E)** احتشاء العضلة القلبية سبب أساسي كلاسيكي للألم الصدري الحاد.

الفكرة من السؤال: أسباب الألم الصدري الحاد الشائعة: احتشاء العضلة القلبية، الصمة الرئوية، تسلخ الأبهر، الريح الصدرية؛ التهاب البنكرياس الحاد يسبب عادة ألماً بطنياً علوياً وليس صدرياً نموذجياً.

11. كل ما يلي صحيح في خناق الصدر غير المستقر ماعدا: أيار 2024

A. يجب قبول المريض في المستشفى لمراقبة خطورة الاحتشاء.
B. يعطى المريض معالجات مضادة للتخثر ومضادات الصفيحات.
C. يعطى المريض حاصرات بيتا لتقليل استهلاك الأكسجين والوفيات.
D. تؤمن مشتقات النترات الاستقرار الهيموديناميكي والسريري بشكل حتمي.
E. يستطب إعادة تروية العضلة القلبية بالقثطرة أو الجراحة عند استمرار الأعراض.

الإجابة الصحيحة: D — تؤمن مشتقات النترات الاستقرار الهيموديناميكي والسريري بشكل حتمي.

التعليل السريري: النترات موسعة وريدية بشكل رئيسي تخفف الألم وتنقص الحمل القبلي، لكنها علاج عرضي ولا تعالج السبب الأساسي (اللويحة غير المستقرة والخثرة)، وقد يستمر المريض بعدم الاستقرار أو يتطور نحو الاحتشاء رغم استخدامها، لذا فإن ضمان الاستقرار "بشكل حتمي" غير صحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح، يجب قبول المريض لمراقبة خطورة الاحتشاء؛ **B)** صحيح، تعطى مضادات التخثر والصفيحات؛ **C)** صحيح، حاصرات بيتا تقلل استهلاك الأكسجين وتخفض الوفيات؛ **E)** صحيح، تستطب إعادة التروية عند استمرار الأعراض.

الفكرة من السؤال: خناق الصدر غير المستقر يتطلب قبولاً استشفائياً ومراقبة، مضادات صفيحات وتخثر، وحاصرات بيتا؛ النترات تخفف الأعراض لكنها لا تؤمّن استقراراً هيموديناميكياً وسريرياً "حتمياً" في جميع الحالات.

---

12. كل ما يلي يعد من اختلاطات احتشاء العضلة القلبية مع تزحل ST نحو الأعلى ماعدا:

أيار 2024

A. الموت المفاجئ.
B. قصور القلب والصدمة القلبية.
C. قصور في الصمام الأبهري.
D. حدوث اللانظميات القلبية.
E. خثار في البطين الأيسر.

الإجابة الصحيحة: C — قصور في الصمام الأبهري.

التعليل السريري: القصور الأبهري ليس من الاختلاطات الميكانيكية النموذجية لاحتشاء العضلة القلبية؛ الصمام المتأذى ميكانيكياً بعد الاحتشاء هو الصمام التاجي عبر تمزق العضلة الحليمية، وليس الصمام الأبهري.

الخيارات الأخرى: **A)** الموت المفاجئ اختلاط شائع باضطرابات النظم الخطيرة. **B)** قصور القلب والصدمة القلبية يعكسان أذية واسعة للعضلة القلبية. **D)** اضطرابات النظم تحدث عند تقريباً جميع مرضى الاحتشاء الحاد. **E)** خثار البطين الأيسر اختلاط معروف يهدد بالانصمام الجهازي.

الفكرة من السؤال: مضاعفات احتشاء STEMI تشمل: الموت المفاجئ، اضطرابات النظم، قصور القلب والصدمة القلبية، تمزق العضلة الحليمية (يسبب قصور تاجي حاد لا أبهري)، تمزق الحاجز البطيني، تمزق جدار البطين، الخثرة الجدارية وأم الدم البطينية، التهاب التأمور ومتلازمة دريسلر.

---

13. في الاحتشاء الحاد دون ارتفاع وصلة ST (NSTEMI)، كل ما يلي صحيح ماعدا:

أيار 2024

A. يتشابه في الآلية مع خناق الصدر غير المستقر.
B. يمكن أن تشاهد تزحل ST للأسفل أو انقلاب T في تخطيط القلب الكهربائي.
C. ترتفع الخمائر القلبية.
D. تستطب فيه حالات الخثرة.
E. بقية المعالجة تماثل معالجة خناق الصدر غير المستقر.

الإجابة الصحيحة: D — تستطب فيه حالات الخثرة.

التعليل السريري: في NSTEMI لا توجد انسداد تام للشريان الإكليلي بخثرة مستمرة كما في STEMI، لذلك فإن إعادة التروية الفورية بحالات الخثرة ليس لها فائدة ملحوظة وقد تحمل خطورة نزفية دون مبرر علاجي.

الخيارات الأخرى: **A)** يتشابه NSTEMI آلياً مع خناق الصدر غير المستقر (تشقق لويحة وخثار غير كامل). **B)** يمكن مشاهدة تزحل ST للأسفل أو انقلاب T. **C)** ترتفع الخمائر القلبية (تروبونين) بسبب النخر. **E)** بقية المعالجة (مضادات صفيحات، مضادات تخثر، ستاتين، حاصرات بيتا) تماثل خناق الصدر غير المستقر.

الفكرة من السؤال: لا تستطب حالات الخثرة (fibrinolytics) في NSTEMI لأنها قد تكون خطيرة دون فائدة مثبتة؛ التدبير يعتمد على تصوير الأوعية وإعادة التوعية حسب الخطورة (GRACE score) وليس على الحل الدوائي للخثرة.

14. كل من الموجودات التخطيطية التالية قد ترافق مع تشخيص الداء الإقفاري القلبي ما عدا: تشرين 2023

A. زحول القطعة ST نحو الأسفل.

B. التخطيط الطبيعي.

C. اللانظميات البطينية الخطيرة.

D. زحول القطعة ST نحو الأعلى.

E. زحول القطعة PR نحو الأسفل.

الإجابة الصحيحة: E – زحول القطعة PR نحو الأسفل.

التعليل السريري: انزياح القطعة PR للأسفل ينجم عن التهاب الطبقة النخابية المجاورة للأذينة في التهاب التأمور، وهو آلية مختلفة تماماً عن الإقفار العضلي القلبي، لذلك لا يعد من علامات الداء الإقفاري.

الخيارات الأخرى: **A)** تزحل ST للأسفل يشير لنقص تروية تحت شغاف. **B)** قد يكون التخطيط طبيعياً حتى مع داء إكليلي شديد. **C)** اللانظميات البطينية الخطيرة قد تحدث أثناء نوب الإقفار الحاد. **D)** تزحل ST للأعلى يشير لإقفار عابر للجدار أو احتشاء حاد.

الفكرة من السؤال: انزياح PR للأسفل هو علامة مميزة لالتهاب التأمور الحاد، وليس للإقفار القلبي؛ بينما تزحل ST (للأعلى أو الأسفل)، التخطيط الطبيعي، واللانظميات البطينية الخطيرة كلها قد ترافق الداء الإقفاري.

15. لا يفيد تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو) لدى مرضى الاحتشاء في تشخيص: تشرين 2023

A. انصباب التامور.

B. قلس التاجي.

C. التضيق الإكليلي الحرج.

D. أم الدم البطينية.

E. الخثرة الجدارية.

الإجابة الصحيحة: C – التضيق الإكليلي الحرج.

التعليل السريري: الإيكو يصور البنى والوظيفة القلبية (الجدران، الصمامات، التامور) عبر الأمواج فوق الصوتية، لكنه لا يستطيع تقييم لمعة الشرايين الإكليلية بدقة كافية لتحديد شدة التضيق، وهذا يتطلب تصوير الأوعية الظليل الغازي.

الخيارات الأخرى: **A)** يكشف الإيكو انصباب التامور بسهولة. **B)** يقيّم شدة القلس التاجي الحاد الناجم عن تمزق العضلة الحليمية. **D)** يكشف أم الدم البطينية كمضاعفة متأخرة. **E)** يكشف الخثرة الجدارية داخل تجويف البطين.

الفكرة من السؤال: الإيكو يقيّم الوظيفة والمضاعفات البنيوية بعد الاحتشاء (خثرة جدارية، قلس تاجي، انصباب تامور، أم دم بطينية) لكنه لا يحدد شدة تضيق الشرايين الإكليلية نفسها، وهذا يحتاج تصوير الشرايين الإكليلية الظليل.

16. واحد مما يلي من صفات الألم الصدري الخناقي: تشرين 2023

A. يزول بمضادات الحموضة.

B. ضاغط خلف القص.

C. يزداد بالاستلقاء.

D. يحرض بجس المنطقة أمام القص.

E. يخف بالجلوس والانحناء للأمام.

الإجابة الصحيحة: B — ضاغط خلف القص.

التعليل السريري: يحدث الألم الخناقي بسبب نقص التروية القلبية العابر الناجم عن اختلال التوازن بين حاجة العضلة القلبية للأكسجين وإمدادها، ويتظاهر نموذجياً كضغط أو عسرة خلف القص تخف عند الراحة.

الخيارات الأخرى: **A)** الزوال بمضادات الحموضة يميز الألم المريئي. **C)** الازدياد بالاستلقاء يميز الألم المريئي (الجزر). **D)** التحرض بالجس أمام القص يميز الألم الهيكلي الجداري. **E)** الخفة بالجلوس والانحناء أمامياً تميز ألم التهاب التامور.

الفكرة من السؤال: الذبحة النموذجية: ألم ضاغط أو ثقل خلف القص يتحرض بالجهد ويخف بالراحة أو النتروغليسرين خلال دقائق؛ عكس ذلك تماماً هو الألم المريئي الذي يزول بمضادات الحموضة أو يزداد بالاستلقاء.

---

17. الواسم القلبي النوعي الذي يجب معايرته في المتلازمة الإكليلية الحادة هو: آذار 2023

A. CPK.
B. Ck-MB.
C. AST.
D. Troponin.
E. LDH.

الإجابة الصحيحة: D — Troponin.

التعليل السريري: التروبونين بروتين نوعي للعضلة القلبية يتحرر عند حدوث النخر الخلوي، ويمتاز بارتفاع مبكر واستمرار طويل نسبياً مما يجعله الواسم الأنسب للتشخيص وتحديد الإنذار في المتلازمات الإكليلية الحادة.

الخيارات الأخرى: **A)** CPK غير نوعي للقلب (يرتفع بأذيات عضلية هيكلية أيضاً). **B)** CK-MB أكثر نوعية من CPK لكنه أقل حساسية ونوعية من التروبونين. **C)** AST واسم قديم غير نوعي. **E)** LDH واسم متأخر وغير نوعي.

الفكرة من السؤال: التروبونينات القلبية T/I هي الواسم المعياري حالياً للمتلازمة الإكليلية الحادة، تُتحرر خلال 4-6 ساعات وتبقى مرتفعة حتى أسبوعين، متفوقة على CK-MB بالنوعية والحساسية.

---

18. يعد التالي من أسباب الألم الصدري الذي يمكن أن يأتي في الراحة ما عدا: آذار 2023

A. الريح الصدرية.
B. الصمة الرئوية الحادة.
C. خناق الصدر المستقر.
D. احتشاء العضلة القلبية الحاد.
E. تسلخ الأبهر.

الإجابة الصحيحة: C — خناق الصدر المستقر.

التعليل السريري: خناق الصدر المستقر ينجم عن نقص تروية عابر يتحرض عند ازدياد الطلب الأكسجيني أثناء الجهد بسبب تضيق إكليلي ثابت، ويزول سريعاً بالراحة، لذلك لا يُعد من أسباب ألم الصدر الذي يحدث أساساً في الراحة.

الخيارات الأخرى: **A)** الريح الصدرية قد تسبب ألماً مفاجئاً في الراحة. **B)** الصمة الرئوية الحادة تسبب ألماً وضيق تنفس مفاجئين في الراحة. **D)** احتشاء العضلة القلبية الحاد يتظاهر بألم في الراحة أساساً. **E)** تسلخ الأبهر يسبب ألماً حاداً مفاجئاً بغض النظر عن الجهد.

الفكرة من السؤال: خناق الصدر المستقر يتحرض نموذجياً بالجهد ويخف بالراحة، بعكس الاحتشاء الحاد، الذبحة غير المستقرة، الصمة الرئوية، تسلخ الأبهر، والريح الصدرية التي قد تحدث جميعها في الراحة.

آذار 2023

19. يفيد إيكو القلب في التالي ما عدا:

A. تحديد شدة التضيقات الصمامية.
B. دراسة الفتحات القلبية.
C. تحديد شدة تضيقات الشرايين الإكليلية.
D. تحديد شدة القصورات الصمامية.
E. دراسة الكتل القلبية.

الإجابة الصحيحة: C – تحديد شدة تضيقات الشرايين الإكليلية.

التعليل السريري: إيكو القلب أداة تصويرية بنيوية ووظيفية للقلب لا تصور لمعة الشرايين الإكليلية مباشرة، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه لتحديد شدة تضيقات الشرايين الإكليلية.

الخيارات الأخرى: A) يحدد شدة التضيقات الصمامية بدقة عبر الدوبلر. B) يدرس الفتحات القلبية (كالعيوب الخلقية). D) يحدد شدة القصورات الصمامية. E) يكشف الكتل والخثرات داخل القلب.

الفكرة من السؤال: يفيد الإيكو في تقييم الصمامات، الفتحات والكتل القلبية، لكنه لا يحدد شدة تضيقات الشرايين الإكليلية نفسها، والتي تتطلب تصوير الأوعية الظليل أو دراسات نوعية أخرى (اختبار جهد، إيكو الجهد، ومضان العضلة القلبية).

آذار 2023

20. في احتشاء العضلة القلبية كل ما يلي صحيح ما عدا:

A. ارتفاع ST في الاتجاه II,III,aVF يتماشى مع احتشاء أمامي حاد.
B. ارتفاع ST في الاتجاه V5,V6,aVL يتماشى مع احتشاء جانبي.
C. حصار الغصن الأيسر حديث الظهور من علامات احتشاء العضلة القلبية الحاد.
D. انخفاض ST مع R طويلة في V1-V4 يشير إلى وجود احتشاء جدار خلفي.
E. يحتاج مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع وصلة الـ ST إلى إعادة تروية فورية.

الإجابة الصحيحة: A – ارتفاع ST في الاتجاه II,III,aVF يتماشى مع احتشاء أمامي حاد.

التعليل السريري: المساري II, III, aVF تعكس كهربائياً الجدار السفلي للبطين الأيسر المروى عادة من الشريان الإكليلي الأيمن أو المنعطف، وليس الجدار الأمامي، لذلك فإن ربط ارتفاع ST فيها بالاحتشاء الأمامي الحاد خطأ.

الخيارات الأخرى: B) صحيح: V5,V6,aVL يتوافق مع الاحتشاء الجانبي. C) صحيح: LBBB حديث من علامات الاحتشاء الحاد. D) صحيح: انخفاض ST مع R طويلة في V1-V4 علامة غير مباشرة على احتشاء الجدار الخلفي. E) صحيح: STEMI يحتاج إعادة تروية فورية.

الفكرة من السؤال: ارتفاع ST في II, III, aVF يشير للاحتشاء السفلي وليس الأمامي؛ الاحتشاء الأمامي الحاجزي يظهر في V1-V4، والجانبي في I, aVL, V4-V6.

أيلول 2022

21. يعد كل ما يلي تعريفاً لخناق الصدر غير المستقر ما عدا:

A. البدء الحديث.
B. الخناق المتسارع.
C. خناق الراحة.
D. خناق ما بعد احتشاء العضلة القلبية.
E. الخناق الجهدي.

الإجابة الصحيحة: E — الخناق الجهدي.

التعليل السريري: الخناق الجهدي الذي يحافظ على نمط ثابت من حيث شدة التحريض والزوال بالراحة يندرج ضمن تعريف الذبحة المستقرة، بينما خناق الصدر غير المستقر يتميز بتغير حديث في النمط (بدء حديث، تسارع، حدوث بالراحة، أو بعد احتشاء) دون أذية عضلية دائمة.

الخيارات الأخرى: **A)** البدء الحديث de novo من معايير عدم الاستقرار. **B)** الخناق المتسارع (ازدياد الشدة/التكرار) من معايير عدم الاستقرار. **C)** خناق الراحة علامة مميزة لعدم الاستقرار. **D)** خناق ما بعد الاحتشاء يصنف كغير مستقر بحكم إنذاره.

الفكرة من السؤال: خناق الصدر غير المستقر يشمل: البدء الحديث، التسارع (تفاقم النمط المعتاد)، خناق الراحة، وخناق ما بعد الاحتشاء؛ أما الخناق الجهدي الثابت النمط فهو تعريف خناق الصدر المستقر.

22. الدواء البديل للاسبرين في حال عدم التحمل الهضمي هو:

أيلول 2022

A. الوارفارين.
B. الهيبارين.
C. الريفاروكسابان.
D. الكلوبيدوغريل.
E. الديبيريدامول.

الإجابة الصحيحة: D — الكلوبيدوغريل.

التعليل السريري: يثبط الكلوبيدوغريل تفعيل الصفيحات عبر حصر مستقبلات ADP (P2Y12)، بآلية مختلفة عن تثبيط الأسبرين لإنزيم COX، مما يجعله بديلاً فعالاً ومتحملاً هضمياً بشكل أفضل عند من لا يتحملون الأسبرين.

الخيارات الأخرى: **A)** الوارفارين مضاد فيتامين K مضاد تخثر لا مضاد صفيحات. **B)** الهيبارين مضاد تخثر حقني وليس بديلاً فموياً للوقاية طويلة الأمد. **C)** الريفاروكسابان مضاد تخثر فموي مباشر. **E)** الديبيريدامول أقل فعالية ويستخدم غالباً مع الأسبرين لا كبديل وحيد قياسي.

الفكرة من السؤال: الكلوبيدوغريل مضاد صفيحات (مثبط مستقبل P2Y12) بديل مماثل الفعالية للأسبرين عند المرضى غير المتحملين له هضمياً، ويستخدم أيضاً بالمشاركة مع الأسبرين في المتلازمات الإكليلية الحادة.

23. كل ما يلي من عوامل خطر حدوث الداء القلبي الإكليلي ما عدا:

أيلول 2022

A. التدخين.
B. انخفاض LDL-C.
C. الداء السكري.
D. انخفاض HDL-C.
E. فرط ضغط الدم الشرياني.

الإجابة الصحيحة: B — انخفاض LDL-C.

التعليل السريري: يرتبط ارتفاع البروتين الشحمي منخفض الكثافة (LDL-C) بزيادة الترسب العصيدي وتفاقم التصلب الشرياني، بينما انخفاضه يقلل من هذه الخطورة، لذلك يُعد انخفاض LDL-C عاملاً وقائياً وليس عامل خطورة.

الخيارات الأخرى: **A)** التدخين عامل خطورة مستقل قوي ومرتبط بالجرعة. **C)** الداء السكري عامل خطورة قوي لكل أشكال التصلب العصيدي. **D)** انخفاض HDL-C (الكوليسترول الحامي) عامل خطورة معروف. **E)** فرط ضغط الدم يزيد خطورة التصلب العصيدي.

الفكرة من السؤال: عوامل خطورة الداء الإكليلي الرئيسية: التدخين، الداء السكري، فرط ضغط الدم، ارتفاع LDL-C وانخفاض HDL-C؛ أما انخفاض LDL-C فهو عامل وقائي وليس عامل خطورة.

24. مضاد التصاق الصفيحات هو:

أيلول 2022

A. هيبارين.
B. كلوبيدوغريل.
C. ريفاروكسابان.
D. اينوكسيبارين.
E. الوارفارين.

الإجابة الصحيحة: B – كلوبيدوغريل.

التعليل السريري: يثبط كلوبيدوغريل مستقبل ADP (P2Y12) على سطح الصفيحة فيمنع تفعيلها والتصاقها وتجمعها، وهي الآلية الأساسية في تشكل الخثرة الشريانية فوق اللويحة العصيدية المتصدعة.

الخيارات الأخرى: A) الهيبارين مضاد تخثر يثبط الثرومبين والعامل Xa عبر الأنتيثرومبين III. C) ريفاروكسابان مضاد تخثر فموي مباشر لمثبطات العامل Xa. D) إينوكسبارين هيبارين منخفض الوزن الجزيئي، مضاد تخثر. E) الوارفارين مضاد فيتامين K، مضاد تخثر فموي.

الفكرة من السؤال: كلوبيدوغريل (وتيكاغريلور) من مضادات مستقبلات P2Y12 التي تمنع التصاق وتفعيل الصفيحات؛ يُستخدم وحيداً عند عدم تحمل الأسبرين أو مشاركاً معه في المتلازمة الإكليلية الحادة.

25. ما هي العلامة الدالة في تخطيط القلب على الاحتشاء القلبي الحاد:

آذار 2022

A. عرض QRS.
B. موجة P ذروية (P pulmonale).
C. قصر PR.
D. تزحل ST للأعلى.
E. ظهور موجة U.

الإجابة الصحيحة: D – تزحل ST للأعلى.

التعليل السريري: يعكس انسداد الشريان الإكليلي الحاد نقص تروية عابر لكامل سماكة الجدار، مما يظهر تخطيطياً كتزحل حاد للقطعة ST نحو الأعلى في المساري المواجهة للمنطقة المحتشية، ويستطب لدى وجوده إعادة تروية فورية.

الخيارات الأخرى: A) عرض QRS يتأثر بحصارات التوصيل وليس علامة نوعية للاحتشاء. B) الموجة P الذروية تشير لتضخم أذيني أيمن (P pulmonale) لا للاحتشاء. C) قصر PR يشاهد في متلازمات الاستثارة المبكرة كـ WPW. E) موجة U البارزة ترتبط بنقص بوتاسيوم الدم أو بعض الأدوية.

الفكرة من السؤال: تزحل ST للأعلى هو أول وأهم علامة تخطيطية في الاحتشاء الحاد الشامل للسماكة، يليه تناقص الموجة R وظهور موجة Q ثم انقلاب الموجة T.

26. يستطب الأسبرين Aspirin في الحالات التالية : (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. مريض خناق صدر مستقر.
B. مريض خناق صدر غير مستقر.
C. مريض احتشاء عضلة قلبية.
D. مريض أجري له تداخل إكليلي PCI.
E. مريض عمره 35 سنة لديه ارتفاع توتر شرياني بدورة أخرى ذكر العمر 50 عام).

الإجابة الصحيحة: E – مريض عمره 35 سنة لديه ارتفاع توتر شرياني بدورة أخرى ذكر العمر 50 عام).

التعليل السريري: يخفف الأسبرين من الحوادث القلبية الوعائية عبر تثبيط الصفيحات، وهذا مثبت في الوقاية الثانوية عند مرضى الداء الإكليلي المشخص (ذبحة مستقرة وغير مستقرة، احتشاء، بعد PCI)، بينما في شخص بدون داء إكليلي مثبت ولديه فقط عامل خطورة واحد (ارتفاع ضغط)، ترجح المخاطر النزفية على الفائدة فلا يستطب.

الخيارات الأخرى: A) خناق الصدر المستقر استطباب ثابت للأسبرين للوقاية الثانوية. B) خناق الصدر غير المستقر جزء من المتلازمة الإكليلية الحادة ويستطب فيه الأسبرين. C) احتشاء العضلة القلبية استطباب أساسي للأسبرين. D) بعد PCI يستطب الأسبرين لتحسين نفوذية التداخل.

الفكرة من السؤال: يستطب الأسبرين في كل مرضى داء الشريان الإكليلي (مستقر، غير مستقر، احتشاء، بعد PCI) للوقاية الثانوية؛ أما في الوقاية الأولية لدى شخص ليس لديه داء إكليلي مثبت، فلا يوصى به روتينياً حتى مع وجود ارتفاع ضغط فقط.

27. تتضمن المتلازمة الاكليلية الحادة ما عدا:

تشرين 2021

A. ألم صدري يتحرض بالجهد ويتحسن بالنتروغليسرين.
B. احتشاء مع تزحل ST للأسفل مع تروبونين سلبي.
C. احتشاء مع تزحل ST للأسفل مع تروبونين إيجابي.
D. احتشاء مع تزحل ST للأعلى.
E. ألم صدري مع LBBB حديث.

الإجابة الصحيحة: A – ألم صدري يتحرض بالجهد ويتحسن بالنتروغليسرين.

التعليل السريري: تنتج الذبحة المستقرة عن تضيق ثابت في الشريان الإكليلي يسبب عدم توازن بين العرض والطلب الأكسجيني أثناء الجهد فقط، دون تمزق لويحة أو تشكل خثرة حادة، لذلك لا تندرج ضمن المتلازمات الإكليلية الحادة التي أساسها الفيزيولوجي المرضي تصدع اللويحة العصيدية وتشكل خثرة داخل اللمعة.

الخيارات الأخرى: B) احتشاء دون تزحل ST مع تروبونين سلبي يعبر عن ذبحة غير مستقرة، وهي من المتلازمة الإكليلية الحادة. C) احتشاء دون تزحل ST مع تروبونين إيجابي هو NSTEMI، من المتلازمة الإكليلية الحادة. D) الاحتشاء مع تزحل ST للأعلى (STEMI) هو الشكل الأشد من المتلازمة الإكليلية الحادة. E) الألم مع LBBB حديث يعامل معاملة STEMI ويستطب إعادة تروية فورية.

الفكرة من السؤال: الذبحة المستقرة: ألم يتحرض بالجهد ويخف فوراً بالراحة أو النتروغليسرين، وليست جزءاً من المتلازمة الإكليلية الحادة؛ بينما المتلازمة الإكليلية الحادة تشمل الذبحة غير المستقرة واحتشاء NSTEMI وSTEMI.

28. كل ما يلي من عوامل الخطر بالمتلازمة الاكليلية الحادة ما عدا:

تشرين 2021

A. عمر فوق الـ 60.
B. سكري.
C. قصور قلب عند التظاهر الأول.
D. قصور تاجي إقفاري حاد.
E. سوابق احتشاء.

الإجابة الصحيحة: D – قصور تاجي إقفاري حاد.

التعليل السريري: القصور التاجي الإقفاري الحاد ينتج عادة عن تمزق أو خلل وظيفي بالعضلة الحليمية بعد حدوث الاحتشاء، أي أنه نتيجة لاحقة (اختلاط) للمتلازمة الإكليلية الحادة وليس عاملاً مؤهباً يسبقها.

الخيارات الأخرى: **A)** العمر فوق 60 عامل خطورة مستقل قوي للتصلب العصيدي. **B)** السكري عامل خطورة رئيسي للداء الإكليلي المنتشر. **C)** قصور القلب عند التظاهر الأول علامة خطورة ترافق الاحتشاء الواسع. **E)** سوابق الاحتشاء تزيد خطر النكس والحوادث اللاحقة.

الفكرة من السؤال: عوامل الخطورة التقليدية: العمر، التدخين، فرط ضغط الدم، فرط شحوم الدم، السكري، القصة العائلية، وسوابق الاحتشاء أو قصور القلب عند التظاهر الأول تنذر بإنذار أسوأ؛ أما القصور التاجي الإقفاري الحاد فهو اختلاط للاحتشاء وليس عامل خطورة سابق له.

29. التهاب التامور التالي للاحتشاء كل مما يلي صح ما عدا:

حزيران 2021

A. يعالج بمضادات الالتهاب اللاسيتروئيدية.
B. يظهر بعد عدة أيام من احتشاء القلب.
C. يوجد احتكاكات تامورية.
D. يسوء بالاستلقاء.
E. تفضل فيه المسكنات الأفيونية على مضادات الالتهاب.

الإجابة الصحيحة: A – يعالج بمضادات الالتهاب اللاسيتروئيدية.

التعليل السريري: تزيد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية من خطر تمزق العضلة القلبية وتشكل أم الدم البطينية عبر تأثيرها على شفاء النسيج المحتشي، لذلك تُتجنب وتُستبدل بالمسكنات الأفيونية في التهاب التامور بعد الاحتشاء، خلافاً لالتهاب التامور الحاد النموذجي حيث تُستخدم مضادات الالتهاب اللاستيرويدية بأمان.

الخيارات الأخرى: **B)** يظهر فعلاً بعد عدة أيام (اليوم 2-3) من الاحتشاء. **C)** الاحتكاكات التامورية علامة سريرية مميزة له. **D)** يتفاقم الألم فعلاً بالاستلقاء ويتحسن بالجلوس للأمام. **E)** تفضيل الأفيونيات على مضادات الالتهاب عبارة صحيحة.

الفكرة من السؤال: يشيع التهاب التامور في اليوم 2-3 بعد الاحتشاء مع ألم يسوء بالاستلقاء والشهيق واحتكاكات تامورية؛ تفضل المسكنات الأفيونية على مضادات الالتهاب اللاستيرويدية/الستيرويدية لأنها تزيد خطر تشكل أمهات الدم وتمزق العضلة القلبية.

30. كل مما يلي من اختلاطات احتشاء العضلة القلبية ما عدا:

حزيران 2021

A. تمزق العضلات الحليمية.
B. فتحة بين البطينين.
C. أم دم أبهرية.
D. التهاب التامور.
E. قصور التاجي.

الإجابة الصحيحة: C — أم دم أبهرية.

التعليل السريري: تنتج الاختلاطات الميكانيكية للاحتشاء عن نخر وضعف موضعي في نسيج العضلة القلبية أو أوتارها وعضلاتها الحليمية، بينما أم الدم الأبهرية تنشأ من تنكس أو ضعف في جدار الأبهر نفسه بآلية مختلفة تماماً (تصلب عصيدي، ارتفاع ضغط مزمن، أمراض النسيج الضام) ولا علاقة فيزيولوجية مرضية مباشرة لها بالاحتشاء العضلي.

الخيارات الأخرى: **A)** تمزق العضلة الحليمية اختلاط ميكانيكي معروف يسبب قصور تاجي حاد. **B)** الفتحة بين البطينين (تمزق الحاجز) اختلاط ميكانيكي كلاسيكي للاحتشاء. **D)** التهاب التامور اختلاط شائع خلال الأيام الأولى بعد الاحتشاء. **E)** القصور التاجي ينتج عن خلل أو تمزق العضلة الحليمية بعد الاحتشاء.

الفكرة من السؤال: اختلاطات الاحتشاء الميكانيكية: تمزق العضلة الحليمية، تمزق الحاجز بين البطينين، تمزق جدار البطين، بالإضافة لالتهاب التامور والقصور التاجي؛ أما أم الدم الأبهرية فمرض وعائي مستقل غير مرتبط بالاحتشاء.

---

31. عوامل خطورة داء الشريان الإكليلي، كل مما يلي صحيح ما عدا:

حزيران 2021

A. انخفاض LDL.
B. انخفاض HDL.
C. السكري.
D. ارتفاع التوتر الشرياني.
E. ارتفاع LDL.

الإجابة الصحيحة: A — انخفاض LDL.

التعليل السريري: يرتبط ارتفاع LDL بترسب الكوليسترول ضمن جدار الشريان وتشكل اللويحة العصيدية، وبالتالي فإن خفض تركيز LDL (سواء طبيعياً أو دوائياً بالستاتين) يقلل خطر الحوادث القلبية الوعائية بدلاً من زيادته، فهو عامل وقائي لا عامل خطورة.

الخيارات الأخرى: **B)** انخفاض HDL يفقد الجسم دوره الوقائي في نقل الكوليسترول العكسي فيرفع الخطورة. **C)** السكري عامل خطورة قوي مستقل للتصلب العصيدي المنتشر. **D)** ارتفاع التوتر الشرياني يزيد الإجهاد على جدار الشريان ويسرع التصلب العصيدي. **E)** ارتفاع LDL هو العامل الرئيسي المسبب لترسب العصيدة.

الفكرة من السؤال: عوامل خطورة التصلب العصيدي الرئيسية: ارتفاع LDL، انخفاض HDL، السكري، فرط ضغط الدم، التدخين، العمر والقصة العائلية؛ بينما انخفاض LDL عامل وقائي وليس عامل خطورة.

---

32. الألم النموذجي بخناق الصدر، كل مما يلي صحيح ما عدا:

حزيران 2021

A. ألم شرسوفي.
B. ينتشر للعنق.
C. قد يترافق مع غثيان.
D. يسوء بالجهد.
E. ينتشر للفك السفلي.

الإجابة الصحيحة: A — ألم شرسوفي.

التعليل السريري: ينتج ألم الذبحة عن انتشار الإحساس الحشوي القلبي عبر الجهاز العصبي الودي المشترك مع الجذور الشوكية العلوية (C8-T4)، مما يفسر انتشاره النموذجي للعنق والفك والذراع، بينما الألم الشرسوفي المعزول غير نمطي ويصعب تمييزه عن الأسباب الهضمية إلا في سياقات خاصة (احتشاء سفلي، سكري، كبار السن).

الخيارات الأخرى: **B)** الانتشار للعنق من الانتشارات النموذجية لألم الذبحة. **C)** الغثيان عرض مرافق شائع خاصة في الاحتشاء السفلي بسبب تحرض المبهم. **D)** التفاقم بالجهد هو الصفة الأساسية المميزة لخناق الصدر. **E)** الانتشار للفك السفلي من الانتشارات النموذجية المعروفة.

الفكرة من السؤال: ألم الذبحة النموذجي: ضاغط خلف القص، يتحرض بالجهد ويخف بالراحة/النتروغليسرين، ينتشر للعنق والفك السفلي والذراع، وقد يترافق بغثيان وتعرق؛ الألم الشرسوفي المعزول ليس نمطياً ويشير لتظاهر غير نموذجي أو سبب هضمي.

---

33. كل مما يلي يترافق مع خناق صدر مستقر ما عدا: تشرين 2020

A. نفخة وعائية سباتية.
B. نفخة انقباضية في الورب الثاني تنتشر للعنق.
C. سماع صوت قلبي رابع S4.
D. نفخة منتصف انبساطية في القمة.
E. نفخة انقباضية في القمة.

الإجابة الصحيحة: D — نفخة منتصف انبساطية في القمة.

التعليل السريري: يذكر الفحص السريري للذبحة المستقرة إمكانية وجود تضيق أبهري (نفخة انقباضية تنتشر للعنق) كسبب عارض للذبحة، وضخامة البطين الأيسر (S4)، وأمراض شريانية مرافقة كاللغط السباتي؛ أما النفخة متوسطة الانبساط في القمة فهي العلامة السمعية النموذجية للتضيق التاجي، وهو مرض صمامي منفصل لا يندرج ضمن موجودات الذبحة المستقرة الفيزيولوجية المرضية.

الخيارات الأخرى: **A)** اللغط السباتي علامة على داء وعائي عصيدي منتشر يرافق داء الشريان الإكليلي. **B)** النفخة الانقباضية في الورب الثاني المنتشرة للعنق تشير لتضيق أبهري، سبب معروف للذبحة. **C)** صوت S4 يعكس نقص مطاوعة البطين الأيسر الشائع في الإقفار المزمن. **E)** النفخة الانقباضية في القمة قد تعكس قصور تاجي وظيفي ثانوي لخلل العضلة الحليمية الإقفاري.

الفكرة من السؤال: يترافق خناق الصدر المستقر مع علامات التضيق الأبهري (نفخة انقباضية بؤرة الأبهر تنتشر للعنق) وعلامات ضخامة/خلل وظيفة البطين الأيسر (S4)، بينما النفخة متوسطة الانبساط في القمة تشير لتضيق تاجي وليست من موجودات الذبحة المستقرة.

---

34. راجعك مريض بقصة ألم صدري ضاغط منذ ساعة، تخطيط القلب الكهربائي لم يبد تبدلات تخطيطية، وبمعايرة التروبونين تبين أنه طبيعي، التشخيص الأرجح: حزيران 2020

A. خناق صدر مستقر.
B. خناق صدر غير مستقر.
C. احتشاء عضلة قلبية.
D. خناق برينز ميتال.
E. متلازمة إكليلية حادة.

الإجابة الصحيحة: B — خناق صدر غير مستقر.

التعليل السريري: يعكس الألم على الراحة دون تبدلات تخطيطية ومع تروبونين طبيعي وجود نقص تروية عابر دون نخر فعلي في العضلة القلبية، وهذا هو التعريف الدقيق لخناق الصدر غير المستقر ضمن طيف المتلازمة الإكليلية الحادة.

الخيارات الأخرى: **A)** خناق الصدر المستقر يتحرض بالجهد ويخف بالراحة، لا يحدث على الراحة كما في هذه الحالة. **C)** احتشاء العضلة القلبية يستلزم ارتفاع التروبونين وهو هنا طبيعي. **D)** خناق برينزميتال ينجم عن تشنج إكليلي ويترافق عادة بتزحل ST عابر أثناء النوبة. **E)** المتلازمة الإكليلية الحادة مصطلح شامل، والتشخيص الأدق هنا هو خناق الصدر غير المستقر تحديداً.

الفكرة من السؤال: خناق الصدر غير المستقر: ألم حديث/متفاقم أو على الراحة دون أذية عضلة قلبية (تروبونين سلبي)، بعكس NSTEMI حيث يكون التروبونين إيجابياً رغم غياب تزحل ST.

---

35. مريض عمره 50 سنة يشكو منذ ساعتين من ألم صدري ضاغط خلف القص مع تعرق بارد كل مما يلي يجب إجراؤه ما عدا: تشرين 2019

A. معايرة تربونين المصل.
B. تسكين الألم.
C. تخطيط كهربائية القلب.
D. قثطرة قلبية.
E. فحص سريري موجه.

الإجابة الصحيحة: D — قثطرة قلبية.

التعليل السريري: يعتمد قرار إجراء القثطرة القلبية (تصوير إكليلي/PCI إسعافي) على نتيجة تخطيط القلب (وجود تزحل ST للأعلى أو LBBB حديث) وتقدير الخطورة، وهذه المعطيات تحتاج أولاً لتخطيط قلب وتروبونين وفحص سريري؛ لذلك فهي ليست إجراءً واجباً بشكل مباشر عند كل مريض دون تقييم مسبق.

الخيارات الأخرى: **A)** معايرة التروبونين ضرورية لتصنيف المتلازمة (STEMI/NSTEMI/خناق غير مستقر). **B)** تسكين الألم خطوة أساسية أولى (مورفين + مضاد إقياء) لتخفيف القلق والفعالية الأدرينالينية. **C)** تخطيط كهربائية القلب هو أهم استقصاء أولي يوجه المعالجة. **E)** الفحص السريري الموجه ضروري للكشف عن علامات القصور الدوراني أو الاختلاطات.

الفكرة من السؤال: التقييم الأولي للمتلازمة الإكليلية الحادة يشمل: تخطيط قلب، تروبونين، تسكين الألم، وفحص سريري موجه؛ أما القثطرة القلبية (تصوير الشرايين الإكليلية أو PCI) فتقرر لاحقاً بناءً على نتائج هذا التقييم الأولي (وجود تزحل ST أو تقييم الخطورة GRACE) وليست خطوة أولى تلقائية.

---

36. كل مما يلي في حاصرات بيتا وخناق الصدر المستقر ما عدا: تشرين 2019

A. تخفف من عبء العمل البطيني.
B. تنقص من أعراض الخناق عندما توصف للحفاظ على سرعة القلب 60/د.
C. من التأثيرات الجانبية حدوث الوذمات المحيطية.
D. مضاد استطباب في قصور القلب منكسر المعاوضة.
E. مضاد استطباب في الربو منكسر المعاوضة.

الإجابة الصحيحة: C — من التأثيرات الجانبية حدوث الوذمات المحيطية.

التعليل السريري: حاصرات بيتا تعمل عبر إنقاص سرعة القلب والقلوصية وضغط الدم، مما يخفف الحاجة الأكسجينية للعضلة القلبية دون أن تسبب احتباس سوائل محيطي؛ الوذمات المحيطية تنجم عادة عن توسع شرياني محيطي كما في حاصرات الكالسيوم الديهيدروبيريدينية، وليست أثراً معروفاً لحاصرات بيتا.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيحة، إنقاص سرعة القلب والقلوصية يخفف عبء العمل البطيني وحاجته للأكسجين. **B)** صحيحة، الحفاظ على سرعة قلب حول 60/د يخفف أعراض الخناق فعلياً. **D)** صحيحة، قصور القلب منكسر المعاوضة الحاد مضاد استطباب نسبي/مطلق لحاصرات بيتا. **E)** صحيحة، الربو منكسر المعاوضة مضاد استطباب بسبب خطر التشنج القصبي.

الفكرة من السؤال: حاصرات بيتا تخفف عبء العمل البطيني وتنقص استهلاك الأكسجين عبر إنقاص سرعة القلب والقلوصية؛ الوذمات المحيطية ليست من آثارها الجانبية بل هي أكثر ارتباطاً بحاصرات قنوات الكالسيوم من زمرة الديهيدروبيريدين.

---

37. يفيد الايكو في تشخيص ما يلي عدا:

شباط 2019

A. تضيق التاجي.
B. تضيق الشرايين الاكليلية.
C. انصباب التامور.
D. الخثرات والكتل القلبية.
E. الفتحة بين البطينين.

الإجابة الصحيحة: B — تضيق الشرايين الاكليلية.

التعليل السريري: الإيكو يعطي معلومات بنيوية ووظيفية (حركة الجدران، الصمامات، التامور، الكتل) لكنه لا يصور لمعة الشرايين الإكليلية مباشرة، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه لتشخيص تضيق الشرايين الإكليلية؛ هذا يتطلب تصوير الأوعية الإكليلية الظليل (القثطرة) أو دراسات الإرواء/الإيكو أثناء الجهد كدلالة غير مباشرة على نقص التروية.

الخيارات الأخرى: **A)** الإيكو يشخص تضيق التاجي بدقة عبر الدوبلر ومساحة الصمام. **C)** الإيكو الاستقصاء المفضل لكشف انصباب التامور. **D)** الإيكو يكشف الخثرات الجدارية والكتل داخل القلب بوضوح. **E)** الإيكو مع الدوبلر يكشف الفتحات بين البطينين (VSD) بسهولة.

الفكرة من السؤال: الإيكو ممتاز لتقييم الصمامات والحجرات والتامور والكتل داخل القلب، لكنه لا يشخص تضيق الشرايين الإكليلية نفسها؛ يتطلب ذلك تصوير الشرايين الإكليلية الظليل أو اختبارات الإرواء.

---

38. أبكر علامة تخطيطية في الاحتشاء الحاد العابر للجدار:

تشرين 2018

A. تزحل ST نحو الأعلى.
B. تطاول PR.
C. انقلاب الموجة T.
D. ظهور الموجة Q.
E. نقص سعة R.

الإجابة الصحيحة: A – تزحل ST نحو الأعلى.

التعليل السريري: عند انسداد الشريان الإكليلي الحاد يحدث إقفار شامل للسماكة فوراً، وأول ما يترجم كهربائياً هو تزحل حاد لقطعة ST نحو الأعلى، بينما تتطور باقي التغيرات (نقص R، موجة Q، انقلاب T) خلال ساعات إلى أيام لاحقة.

الخيارات الأخرى: B) تطاول PR ليس من علامات الاحتشاء بل من حصار AV. C) انقلاب T يحدث لاحقاً بعد تراجع ST. D) ظهور Q علامة متأخرة تدل على نخر شامل السماكة. E) نقص سعة R يحدث بالتزامن مع تطور Q وليس أبكر علامة.

الفكرة من السؤال: أبكر تغير تخطيطي هو تزحل ST نحو الأعلى (خلال دقائق)، يليه لاحقاً نقص سعة R وظهور موجة Q وانقلاب T.

39. في المتلازمة الاكليلية الحادة كل ما يلي صحيح ما عدا:

تشرين 2018

A. غشي متكرر.
B. الموت المفاجئ.
C. إقياء.
D. وذمة رئة حادة.
E. ألم ضاغط يستجيب جيداً على النتروغليسرين.

الإجابة الصحيحة: E – ألم ضاغط يستجيب جيداً على النتروغليسرين.

التعليل السريري: في المتلازمة الإكليلية الحادة يوجد انسداد خثاري ثابت أو شبه كامل للشريان الإكليلي مع نخر عضلي فعلي أو وشيك، فلا يزول الألم بمجرد توسيع الأوعية بالنترات كما يحدث في نقص التروية العابر للذبحة المستقرة؛ لذلك عدم الاستجابة الجيدة للنترات هو ما يميز الحالة سريرياً وليس استجابة جيدة.

الخيارات الأخرى: A) الغشي المتكرر تظاهرة معروفة بسبب اضطرابات النظم المرافقة. B) الموت المفاجئ من مضاعفات الاحتشاء الشائعة. C) الإقياء تحرض مبهمي شائع خاصة بالاحتشاء السفلي. D) وذمة الرئة الحادة تظاهرة معروفة لقصور البطين الأيسر الحاد.

الفكرة من السؤال: على عكس الذبحة المستقرة، ألم المتلازمة الإكليلية الحادة أشد وأطول ولا يستجيب بشكل كامل أو سريع على النتروغليسرين تحت اللسان.

40. مضادات استطباب حالات الخثرة كل مما يلي صحيح ما عدا:

تشرين 2018

A. الحمل.
B. الاحتشاء الدماغي منذ سنة.
C. النزف الدماغي منذ سنة.
D. الإنعاش القلبي الرئوي الرضّي.
E. عمل جراحي كبير منذ أسبوعين.

الإجابة الصحيحة: B – الاحتشاء الدماغي منذ سنة.

التعليل السريري: مضادات استطباب حالات الخثرة المذكورة في المرجع تخص بشكل خاص النزف الدماغي (تحت العنكبوتية أو داخل الدماغ) أياً كان توقيته، بينما الاحتشاء الدماغي الإقفاري (وليس النزفي) الذي مضى عليه سنة كاملة لا يشكل خطراً مماثلاً لإعادة النزف ولا يندرج ضمن قائمة مضادات الاستطباب النسبية المذكورة.

الخيارات الأخرى: A) الحمل مذكورة صراحة كمضاد استطباب نسبي. C) النزف الدماغي (حتى لو قديم) مضاد استطباب أساسي. D) الإنعاش الراض يزيد خطر النزف الداخلي فهو مضاد استطباب. E) الجراحة الكبرى ضمن أقل من شهر مضاد استطباب معروف.

الفكرة من السؤال: مضادات استطباب حالات الخثرة تشمل النزف الفعال، سوابق نزف دماغي (أي وقت)، الرض/الجراحة/الإنعاش الراض الحديث (~شهر)، فرط ضغط غير مضبوط، والحمل؛ أما الاحتشاء الدماغي الإقفاري القديم (منذ أكثر من عام تقريباً) فليس مضاد استطباب مطلق.

أمراض الشغاف والصمامات

42 سؤال

1. أكثر عامل مؤهب لحصول التهاب الشغاف الجرثومي هو: أيار 2026

A. السكري.
B. البدانة.
C. الأمراض الصمامية.
D. قلة الحركة.
E. التدخين.

الإجابة الصحيحة: C — الأمراض الصمامية.

التعليل السريري: التنبتات الجرثومية تنمو غالباً في أماكن أذية شغافية سابقة، وخاصة تلك الناجمة عن تيار دم عالي الضغط (مثل قصور التاجي أو الأبهري أو VSD)، مما يجعل مرضى الأمراض الصمامية الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشغاف الخمجي مقارنة بعوامل الخطورة الاستقلابية أو نمط الحياة.

الخيارات الأخرى: **A)** السكري عامل خطورة عام للإنتانات لكنه ليس المؤهب الرئيسي للشغاف. **B)** البدانة ليست عامل خطورة مباشر معروف لالتهاب الشغاف. **D)** قلة الحركة غير مرتبطة بآلية التهاب الشغاف. **E)** التدخين عامل خطورة للتصلب العصيدي وليس لالتهاب الشغاف.

الفكرة من السؤال: وجود أذية شغافية سابقة (صمامية خلقية أو مكتسبة) هو العامل المؤهب الرئيسي لالتصاق الجراثيم وتشكل التنبتات في التهاب الشغاف الخمجي.

---

2. النفخة الانقباضية في الورب الثاني أيمن القص تشير إلى: أيار 2026

A. قصور الصمام التاجي.
B. تضيق الصمام الأبهري.
C. تضيق الصمام التاجي.
D. قصور الصمام الأبهري.
E. قصور الصمام مثلث الشرف.

الإجابة الصحيحة: B — تضيق الصمام الأبهري.

التعليل السريري: تضيق الصمام الأبهري يسبب اضطراب جريان دموي عبر فوهة ضيقة أثناء القذف الانقباضي للبطين الأيسر باتجاه الأبهر الصاعد، وموقع سماع هذا الاضطراب الجرياني بأعلى وضوح هو الورب الثاني أيمن القص (البؤرة الأبهرية) مع انتشار مميز نحو الشرايين السباتية.

الخيارات الأخرى: **A)** قصور التاجي نفخة انقباضية شاملة تسمع في القمة تنتشر للإبط. **C)** تضيق التاجي نفخة انبساطية وليست انقباضية وتسمع في القمة. **D)** قصور الأبهري نفخة انبساطية باكرة أيسر القص. **E)** قصور مثلث الشرف نفخة انقباضية على الحافة اليسرى السفلى للقص.

الفكرة من السؤال: النفخة الانقباضية القذفية الخشنة في الورب الثاني أيمن القص المنتشرة للعنق هي العلامة الإصغائية المميزة لتضيق الصمام الأبهري.

---

3. واحدة مما يلي من العلامات الكلاسيكية لالتهاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد: أيار 2026

A. بقع جانواي Janeway lesions.
B. تساقط الأشعار.
C. رجفان الأطراف.
D. اليرقان.
E. الوذمات.

الإجابة الصحيحة: A — بقع جانواي Janeway lesions.

التعليل السريري: التهاب الشغاف تحت الحاد يترافق مع تظاهرات صمية ومناعية جلدية مميزة، وبقع جانواي هي بقع حمامية أو نزفية غير مؤلمة تنجم عن صمات دقيقة جرثومية في الأوعية الجلدية الطرفية، وهي علامة كلاسيكية موصوفة ضمن التظاهرات خارج القلبية للحالة.

الخيارات الأخرى: **B)** تساقط الأشعار ليس من العلامات الكلاسيكية لالتهاب الشغاف. **C)** رجفان الأطراف غير مرتبط بالحالة. **D)** اليرقان ليس علامة نموذجية مباشرة لالتهاب الشغاف تحت الحاد. **E)** الوذمات ترتبط بقصور القلب وليست علامة نوعية للشغاف.

الفكرة من السؤال: بقع جانواي (غير مؤلمة، راحة اليدين والقدمين) وعقيدات أوسلر (مؤلمة برؤوس الأصابع) والنزوف الشظوية من الموجودات الجلدية الكلاسيكية لالتهاب الشغاف تحت الحاد.

---

4. أي من صفات النبض الشرياني المحيطي التالية تتوافق سريرياً مع تشخيص تضيق الصمام الأبهري الشديد: دكتوراه 2025

A. نبض قافز متسع.
B. نبض خيطي.
C. نبض مشطور.
D. نبض متناوب.
E. نبض متناقض.

الإجابة الصحيحة: B — نبض خيطي.

التعليل السريري: انسداد مخرج البطين الأيسر الشديد في تضيق الأبهر يمنع الارتفاع السريع لحجم الضربة القلبية عبر الفوهة الضيقة، فينتج نبض ضعيف الحجم (خيطي) بطيء الصعود مقارنة بالنبض الطبيعي، ويكون ضغط النبض ضيقاً بسبب محدودية القذف البطيني.

الخيارات الأخرى: **A)** النبض القافز المتسع يشاهد في قصور الأبهر وليس تضيقه. **C)** النبض المشطور يشير لتضيق مترافق مع قصور أبهري. **D)** النبض المتناوب يشاهد في قصور البطين الأيسر الشديد. **E)** النبض المتناقض يشاهد في الدكاك القلبي والتهاب التامور العاصر.

الفكرة من السؤال: النبض السباتي بطيء الارتفاع وضعيف الحجم (Parvus et Tardus) مع ضغط نبض ضيق هو العلامة النبضية الكلاسيكية لتضيق الأبهر الشديد.

---

5. ما هي الخصائص الإصغائية الوصفية للنفخة القلبية النموذجية المرافقة لقصور الصمام الأبهري المعزول: دكتوراه 2025

A. نفخة انقباضية شاملة في القمة تنتشر للإبط.
B. نفخة منتصف انبساطية قمية ذات لحن منخفض.
C. نفخة انقباضية قذفية خشنة في الورب الثاني الأيمن.
D. نفخة انبساطية أيسر القص متناقصة.
E. نفخة مستمرة تحت الترقوة اليسرى.

الإجابة الصحيحة: D — نفخة انبساطية أيسر القص متناقصة.

التعليل السريري: في قصور الصمام الأبهري يعود الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر خلال الانبساط عبر الصمام غير المتماسك، مما يولد نفخة انبساطية باكرة عالية التردد متناقصة الشدة تسمع بأفضل وضوح على الحافة اليسرى للقص، وتشتد بمناورات تزيد عود الدم الوريدي والضغط الأبهري الانبساطي (كالجلوس مع الانحناء للأمام وحبس الزفير).

الخيارات الأخرى: **A)** نفخة انقباضية شاملة قمية منتشرة للإبط تصف قصور التاجي. **B)** نفخة منتصف انبساطية منخفضة اللحن قمية تصف تضيق التاجي. **C)** نفخة انقباضية قذفية خشنة بالورب الثاني الأيمن تصف تضيق الأبهر. **E)** نفخة مستمرة تحت الترقوة اليسرى توحي بالقناة الشريانية السالكة.

الفكرة من السؤال: النفخة الانبساطية الباكرة الناعمة المتناقصة أيسر القص، تسمع بشكل أفضل والمريض جالس منحنٍ للأمام مع حبس النفس بنهاية الزفير، هي الوصف الكلاسيكي لقصور الأبهري.

---

6. مريض عانى بعد جراحة قلبية صمامية من ترفع حروري متواصل ووذمة رئة حادة مع ظهور نفخة قلبية جديدة لم تكن موجودة، التشخيص الأرجح: كانون 2025

A. التهاب تامور حاد ارتكاسي.

B. صمة رئوية حادة.

C. التهاب شغاف جُرثومي (إنتاني) على صمام صنعي.

D. نقص تروية قلبية حاد محرض بالجراحة.

E. حساسية دوائية شديدة للصادات.

الإجابة الصحيحة: C — التهاب شغاف جُرثومي (إنتاني) على صمام صنعي.

التعليل السريري: زرع صمام صنعي يشكل سطحاً غريباً معرضاً بشدة لالتصاق الجراثيم وتشكل التنبتات، فحدوث حمى غير مفسرة بعد الجراحة الصمامية يجب أن يثير الشك الفوري بالتهاب الشغاف على الصمام الصنعي؛ ظهور نفخة جديدة يعكس خللاً صمامياً حديثاً (انثقاب/تسرب حول الصمام) وقد يتطور لقصور قلب حاد ووذمة رئة بسرعة.

الخيارات الأخرى: **A)** التهاب التامور الارتكاسي لا يفسر النفخة الجديدة وقصور القلب الحاد. **B)** الصمة الرئوية لا تفسر ظهور نفخة قلبية جديدة. **D)** نقص التروية القلبية الحاد لا يفسر الحرارة المستمرة والنفخة الجديدة معاً. **E)** الحساسية الدوائية لا تفسر النفخة القلبية الجديدة وقصور القلب.

الفكرة من السؤال: حمى مستمرة بعد جراحة صمامية مع نفخة قلبية جديدة وقصور قلب حاد توجه بقوة نحو التهاب شغاف إنتاني على صمام صنعي، ويستوجب زروع دم متعددة وتخطيط صدى عبر المريء.

---

7. يمكن سماع الصوت القلبي الرابع (S4) بالإصغاء في نهاية طور الانبساط في كل من الحالات التالية عدا: كانون 2025

A. تضيق الصمام الأبهري الشديد.

B. تضيق الصمام التاجي الشديد.

C. نقص التروية القلبية الحاد (الإقفار).

D. اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد.

E. اعتلال العضلة القلبية الضخامي المترافق مع فرط الضغط.

الإجابة الصحيحة: B — تضيق الصمام التاجي الشديد.

التعليل السريري: S4 يحدث بسبب انقباض الأذين الأيسر في نهاية الانبساط ضد بطين أيسر متصلب أو ضخامي، وهذا يميز الحالات التي تسبب ضخامة أو تصلب بطيني (تضيق أبهري شديد، اعتلال عضلة ضخامي، إقفار حاد، فرط ضغط مع تضخم)؛ أما تضيق التاجي فيسبب انسداداً بمستوى الصمام التاجي نفسه دون إصابة أولية لصلابة البطين الأيسر، لذلك لا يترافق نموذجياً مع S4.

الخيارات الأخرى: A) تضيق الأبهر الشديد يسبب ضخامة بطينية شديدة وS4 نموذجي. C) الإقفار الحاد يصلب العضلة القلبية مؤقتاً فيولد S4. D) الاعتلال الضخامي الساد يترافق دوماً تقريباً مع S4 بسبب صلابة الجدار. E) الاعتلال الضخامي المرافق لفرط الضغط يشارك نفس آلية الضخامة والصلابة البطينية.

الفكرة من السؤال: S4 ينجم عن انقباض أذيني ضد بطين متصلب/ضخامي (كما في AS الشديد، الاعتلال الضخامي، فرط الضغط، الإقفار الحاد)، بينما لا يُسمع في تضيق التاجي لأن الخلل هناك بمستوى الصمام والأذينة وليس بصلابة البطين الأيسر.

---

8. مريض عمره 30 سنة لديه حرارة منذ شهر، وإصغاء القلب يبدي وجود نفخة انقباضية شاملة في القمة مع ضخامة طحالية وعقد مؤلمة على الأصابع، ما هو التشخيص الأكثر احتمالاً: تموز 2025

A. ابيضاض نقوي حاد.
B. لمفوما لاهودجكين.
C. التهاب شغاف تحت حاد.
D. ذئاب حمامي جهازي.
E. داء وحيدات النوى الخمجي.

الإجابة الصحيحة: C — التهاب شغاف تحت حاد.

التعليل السريري: الحمى المديدة (أكثر من شهر) مع نفخة انقباضية شاملة في القمة (قصور تاجي مكتسب) وضخامة طحالية وعقد أوسلر المؤلمة تمثل المعايير الصغرى والكبرى لالتهاب الشغاف تحت الحاد وفق معايير ديوك، الناجم غالباً عن جراثيم قليلة الفوعة كالعقديات المخضرة تصيب صماماً متأذياً سابقاً.

الخيارات الأخرى: A) الابيضاض النقوي الحاد لا يفسر النفخة القلبية المستمرة. B) اللمفوما لاهودجكين لا ترافق عادة نفخة انقباضية ولا عقد أوسلر. D) الذئاب الحمامية قد تسبب حمى وضخامة طحالية لكن لا تفسر عقد أوسلر النموذجية. E) داء وحيدات النوى أقصر أمداً ولا يترافق مع نفخة قلبية أو عقد أوسلر.

الفكرة من السؤال: الحمى المزمنة + نفخة انقباضية جديدة/متغيرة + ضخامة طحالية + مظاهر صمية جلدية (عقيدات أوسلر، نزوف شظوية) توجه بقوة نحو التهاب الشغاف تحت الحاد.

---

9. كل من الحالات القلبية التالية تعتبر عوامل خطر لحدوث التهاب شغاف القلب ماعدا: تموز 2025

A. سوابق التهاب شغاف قلب إنتاني.
B. رباعي فالو غير مصحح.
C. وجود صمام قلبي صنعي.
D. وجود متلازمة وولف باركنسون وايت WPW.
E. وجود قصور صمام أبهري ثنائي الشرف.

الإجابة الصحيحة: D — وجود متلازمة وولف باركنسون وايت WPW.

التعليل السريري: التهاب الشغاف الخمجي يستهدف مواقع الأذية الشغافية الناجمة عن جريان دموي شاذ عالي الضغط أو سابق تخريب، بينما متلازمة WPW هي حزمة توصيل كهربائية إضافية لا تسبب أي أذية تشريحية للشغاف أو الصمامات، لذا لا تشكل عامل خطر لالتهاب الشغاف.

الخيارات الأخرى: **A)** سوابق التهاب شغاف تترك أذية شغافية دائمة. **B)** رباعي فالو غير المصحح يسبب جريان مضطرب عبر العيب الحاجزي. **C)** الصمام الصنعي سطح غريب معرض للاستعمار الجرثومي. **E)** الصمام الأبهري ثنائي الوريقات مع القصور يسبب جريان اندفاعي عالي الضغط مؤذٍ للشغاف.

الفكرة من السؤال: أي آفة قلبية تسبب جريان دم مضطرب أو مرتفع الضغط (صمام صنعي، سوابق التهاب شغاف، آفات خلقية زرقاء، قصور صمامي) تزيد خطر التهاب الشغاف؛ أما WPW فهو اضطراب توصيل كهربائي بحت دون أذية شغافية.

---

10. أبدى إصغاء قلب عند شاب في العشرين من العمر وجود نفخة انقباضية أيسر القص تنتشر انتشار أشعة الدولاب، التشخيص الأكثر احتمالاً هو: تموز 2025

A. فتحة بين الأذينتين.
B. فتحة بين البطينين.
C. بقاء قناة شريانية.
D. قصور صمام تاجي.
E. تضيق صمام رئوي.

الإجابة الصحيحة: B — فتحة بين البطينين.

التعليل السريري: الجريان الدموي عبر العيب من البطين الأيسر عالي الضغط إلى البطين الأيمن منخفض الضغط طوال فترة الانقباض يولد نفخة انقباضية شاملة عالية الشدة تنتشر بشكل واسع عبر جدار الصدر في جميع الاتجاهات، وهذا ما يفسر وصف الانتشار "كأشعة الدولاب".

الخيارات الأخرى: **ASD (A)** يعطي نفخة جريان انقباضية ناعمة فوق الصمام الرئوي مع انقسام ثابت للصوت الثاني وليس نفخة شاملة منتشرة. **PDA (C)** يعطي نفخة مستمرة "آلية" تحت الترقوة اليسرى. **D)** قصور التاجي نفخته تنتشر نحو الإبط لا بشكل شعاعي واسع. **E)** تضيق الرئوي يعطي نفخة قذفية تنتشر نحو الكتف الأيسر.

الفكرة من السؤال: نفخة انقباضية شاملة أفضل ما تسمع على الحافة اليسرى للقص مع انتشار واسع (كأشعة الدولاب) نحو كامل مقدم الصدر هي العلامة المميزة لـ VSD.

---

11. العرض الصمامي الأكثر حدوثاً كنتيجة متأخرة للإصابة بالحمى الرثوية هو: تموز 2025

A. تضيق صمام تاجي.
B. تضيق صمام أبهري.
C. تضيق صمام رئوي.
D. تضيق صمام مثلث الشرف.
E. قصور صمام أبهري.

الإجابة الصحيحة: A — تضيق صمام تاجي.

التعليل السريري: الالتهاب الرثوي المتكرر أو المزمن يسبب تليفاً وتكلساً وتحاماً تدريجياً في وريقات الصمام التاجي والجهاز تحت الصمامي، مما يضيق فتحة الصمام تدريجياً على مدى سنوات وينتج تضيقاً تاجياً هو الأشيع بين الآفات الصمامية الرثوية المتأخرة.

الخيارات الأخرى: **B)** تضيق الأبهري الرثوي يترافق عادة مع إصابة تاجية لكنه أقل شيوعاً كآفة معزولة. **C)** تضيق الرئوي نادراً ما ينجم عن الحمى الرثوية. **D)** تضيق مثلث الشرف نادر ويترافق دوماً تقريباً مع إصابة تاجية وأبهرية. **E)** قصور الأبهري أقل شيوعاً من إصابة التاجي كنتيجة رثوية متأخرة.

الفكرة من السؤال: الصمام التاجي يُصاب في أكثر من 90% من حالات الداء الرثوي القلبي المزمن، وتضيق التاجي هو الآفة المتأخرة الأشيع.

12. تسمع النفخة الانقباضية الشاملة في واحدة مما يلي:

تشرين 2024

A. تضيق أبهري.
B. قصور أبهري.
C. فتحة بين البطينين.
D. تضيق تاجي.
E. تضيق رئوي.

الإجابة الصحيحة: C — فتحة بين البطينين.

التعليل السريري: في VSD يبقى فرق الضغط بين البطينين مرتفعاً طوال الانقباض، فيستمر الجريان عبر العيب من بداية الانقباض إلى نهايته منتجاً نفخة شاملة موحدة الشدة، خلافاً للآفات الانسدادية التي تعطي نفخات قذفية متصاعدة ثم متناقصة.

الخيارات الأخرى: **A)** تضيق الأبهري يعطي نفخة قذفية معينية الشكل. **B)** قصور الأبهري يعطي نفخة انبساطية باكرة لا انقباضية. **D)** تضيق التاجي نفخته انبساطية وسطى. **E)** تضيق الرئوي يعطي نفخة قذفية وليست شاملة.

الفكرة من السؤال: النفخة الانقباضية الشاملة تشير إلى جريان مستمر طوال الانقباض بين حجرتين ذواتي فرق ضغط ثابت، كما في VSD أو القصور التاجي أو قصور مثلث الشرف.

13. أي مما يلي يعد من أسباب قصور الصمام الأبهري الحاد:

تشرين 2024

A. تسلخ الأبهر نمط B.
B. احتشاء العضلة القلبية.
C. ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي.
D. التهاب شغاف القلب الإنتاني.
E. التهاب التامور.

الإجابة الصحيحة: D — التهاب شغاف القلب الإنتاني.

التعليل السريري: يسبب التهاب الشغاف الخمجي تخرباً سريعاً وانثقاباً أو تمزقاً في وريقات الصمام الأبهري، فيحدث قصور حاد شديد يرتفع فيه ضغط نهاية الانبساط في البطين الأيسر بسرعة قبل أن يتمكن البطين من التوسع التعويضي، مما يؤدي لظهور مظاهر قصور القلب الحاد.

الخيارات الأخرى: **A)** تسلخ الأبهر النمط B لا يصيب عادة الأبهر الصاعد أو الصمام الأبهري (النمط A هو المرتبط بالقصور الأبهري الحاد). **B)** احتشاء العضلة القلبية يسبب قصوراً تاجياً وليس أبهرياً عادة. **C)** فرط الضغط الرئوي يصيب الجانب الأيمن من القلب. **E)** التهاب التامور لا يصيب الصمام الأبهري.

الفكرة من السؤال: القصور الأبهري الحاد ينجم غالباً عن التهاب الشغاف الخمجي (انثقاب الوريقات) أو تسلخ الأبهر النمط A، وهو حالة إسعافية تسبب وذمة رئة حادة دون وقت كافٍ لتوسع البطين الأيسر المعاوض.

تشرين 2024

14. كل ما يلي يعد من اختلاطات التهاب الشغاف عدا:

A. قصورات صمامية.
B. قصور قلبي.
C. الصمات الجهازية.
D. أمهات الدم الفطرية.
E. النزف الهضمي العلوي.

الإجابة الصحيحة: E — النزف الهضمي العلوي.

التعليل السريري: تخرب النسج الصمامية والصمات الإنتانية المتطايرة من التنبتات تفسر القصور الصمامي وقصور القلب والصمات الجهازية وأمهات الدم الفطرية الناجمة عن استقرار جراثيم في جدار الأوعية، أما النزف الهضمي العلوي فليس آلية مرضية مرتبطة مباشرة بالتهاب الشغاف.

الخيارات الأخرى: **A)** القصور الصمامي ينجم عن انثقاب أو تمزق الوريقات أو الحبال. **B)** قصور القلب ينجم عن الأذية الصمامية الحادة. **C)** الصمات الجهازية تنتج عن انفصال أجزاء من التنبتات. **D)** أمهات الدم الفطرية تنجم عن استقرار جرثومي في جدار الأوعية أثناء تجرثم الدم.

الفكرة من السؤال: اختلاطات التهاب الشغاف تشمل تخرب الصمامات وقصور القلب والصمات الجهازية وأمهات الدم الفطرية (المتعفنة)؛ النزف الهضمي العلوي ليس من الاختلاطات المباشرة النموذجية.

تشرين 2024

15. كل ما يلي يوجه إلى تشخيص التهاب الشغاف عدا:

A. نفخة انقباضية حديثة.
B. تغير في صفات نفخة انقباضية موجودة سابقاً.
C. حمى مجهولة السبب.
D. وولف باركنسون وايت على تخطيط القلب.
E. عقيدات أوسلر.

الإجابة الصحيحة: D — وولف باركنسون وايت على تخطيط القلب.

التعليل السريري: التهاب الشغاف يترافق مع علامات أذية شغافية مكتسبة (نفخة جديدة أو متغيرة، حمى، مظاهر صمية جلدية كعقد أوسلر)، بينما WPW ناجم عن حزمة توصيل شاذة خلقية (حزمة كنت) دون أي علاقة بالخمج أو أذية الشغاف، فوجوده على التخطيط لا يوجه لتشخيص التهاب الشغاف.

الخيارات الأخرى: **A)** النفخة الانقباضية الحديثة توحي بأذية صمامية حادة. **B)** تغير نفخة موجودة سابقاً يوحي بتطور الأذية. **C)** الحمى مجهولة السبب من محكات الشك الأساسية. **E)** عقيدات أوسلر من المظاهر المناعية/الصمية المميزة.

الفكرة من السؤال: النفخة الانقباضية الجديدة أو المتغيرة، الحمى مجهولة السبب، وعقيدات أوسلر معايير توجه نحو التهاب الشغاف؛ أما WPW فهو شذوذ توصيل كهربائي خلقي لا علاقة له بالتهاب الشغاف.

تشرين 2024

16. كل ما يلي قد يكون من اختلاطات القصور التاجي المزمن الشديد عدا:

A. تدني الوظيفة الانقباضية للبطين الأيسر.
B. رجفان أذيني.
C. ارتفاع توتر شرياني جهازي.
D. صمات جهازية.
E. قصور كلية.

الإجابة الصحيحة: C — ارتفاع توتر شرياني جهازي.

التعليل السريري: فرط الحمل الحجمي المزمن الناجم عن القصور التاجي يسبب توسع الأذينة والبطين الأيسرين وتدهوراً تدريجياً في الوظيفة الانقباضية، مع خطر الرجفان الأذيني والصمات والقصور الكلوي الاحتقاني الثانوي لانخفاض النتاج القلبي، دون أن يكون ارتفاع الضغط الشرياني الجهازي نتيجة فيزيولوجية مباشرة لهذه الآفة.

الخيارات الأخرى: **A)** تدني الوظيفة الانقباضية نتيجة فرط الحمل الحجمي المزمن. **B)** الرجفان الأذيني ينجم عن توسع الأذينة اليسرى. **D)** الصمات الجهازية تنجم عن ركودة الدم في الأذينة الموسعة والرجفان الأذيني. **E)** قصور الكلية ينجم عن انخفاض النتاج القلبي المزمن.

الفكرة من السؤال: القصور التاجي المزمن الشديد يؤدي لتوسع الأذينة والبطين الأيسرين، رجفان أذيني، صمات جهازية، وقصور قلب وكلوي ثانوي؛ ارتفاع التوتر الشرياني الجهازي ليس من اختلاطاته المباشرة.

17. في قصور الصمام التاجي كل ما يلي صحيح ماعدا:

أيار 2024

A. يسبب توسع الأذينة اليسرى.
B. يسبب توسع البطين الأيسر.
C. يتسم بالنفخة الانقباضية في القمة التي تنتشر للإبط وأيسر القص.
D. لا يؤثر على الضغط الرئوي عادة.
E. من العلاجات الدوائية المستعملة فيه حاصرات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.

الإجابة الصحيحة: D — لا يؤثر على الضغط الرئوي عادة.

التعليل السريري: ارتجاع الدم المزمن إلى الأذينة اليسرى يرفع ضغطها تدريجياً مما ينتقل بشكل رجعي إلى الأوعية الرئوية مسبباً احتقاناً وريدياً رئوياً وقد يتطور لفرط ضغط رئوي مع تقدم المرض، لذا فإن القول بعدم تأثر الضغط الرئوي غير صحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** فرط الحمل الحجمي يسبب توسع الأذينة اليسرى. **B)** يسبب أيضاً توسع البطين الأيسر بفرط الحمل الحجمي المزمن. **C)** النفخة الانقباضية في القمة المنتشرة للإبط وأيسر القص وصف نموذجي صحيح. **E)** مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين تُستعمل لخفض الحمل التلوي.

الفكرة من السؤال: القصور التاجي المزمن يرفع تدريجياً ضغط الأذينة اليسرى وينتهي بارتفاع الضغط الرئوي، خلافاً لما يُعتقد من عدم تأثره.

18. واحد مما يلي صحيح في علاج التهاب الشغاف الخمجي بالصادات:

أيار 2024

A. المعالجة التجريبية بصاد واحد كافية عادة.
B. تعطى الصادات بجرعات عالية ولفترة أقصاها أسبوعان.
C. يمكن البدء بالمعالجة بالصادات الفموية.
D. تشرك الصادات التي تعمل بآليات مختلفة ومتآزرة.
E. نختار الصاد الموقف لنمو الجراثيم.

الإجابة الصحيحة: D — تشرك الصادات التي تعمل بآليات مختلفة ومتآزرة.

التعليل السريري: التنبتات الشغافية تحوي كثافة جرثومية عالية محاطة بالفبرين والصفيحات مما يصعّب نفاذ الصاد الواحد، لذا يُلجأ لمشاركة صادين بآليتي عمل مختلفتين ومتآزرتين (كبنسلين وأمينوغليكوزيد) لتحقيق فعالية جرثومية قاتلة كافية ولفترة علاج طويلة.

الخيارات الأخرى: **A)** المعالجة بصاد واحد غير كافية عادة نظراً لكثافة الجراثيم داخل التنبتة. **B)** مدة العلاج لا تقل عادة عن 4 أسابيع وليس أسبوعين. **C)** يجب البدء بالصادات الوريدية وليس الفموية. **E)** يُختار الصاد القاتل للجراثيم (Bactericidal) وليس الموقف لنموها فقط (Bacteriostatic).

الفكرة من السؤال: يعتمد علاج التهاب الشغاف على مشاركة صادين وريديين بآليات عمل تآزرية (مثل بيتالاكتام + أمينوغليكوزيد) لفترة طويلة (٤ أسابيع فأكثر) لضمان القضاء على الجراثيم داخل التنبتات كثيفة الكثافة الجرثومية.

19. كل ما يلي من المعايير الصغرى في تشخيص الحمى الرثوية ماعدا:

أيار 2024

A. الترفع الحروري.
B. التهاب المفاصل المتنقل.
C. ارتفاع سرعة التثفل.
D. تطاول PR على تخطيط القلب الكهربائي.
E. ارتفاع البروتين الارتكاسي C.

الإجابة الصحيحة: B — التهاب المفاصل المتنقل.

التعليل السريري: صُنّف التهاب المفاصل العديد الحاد المتنقل ضمن المعايير الكبرى الخمسة لمعايير جونز المعدلة نظراً لخصوصيته وشيوعه العاليين كتظاهرة رئيسية للحمى الرثوية، بينما تضم المعايير الصغرى المظاهر الأقل نوعية كالحمى وارتفاع الواسمات الالتهابية وتطاول PR.

الخيارات الأخرى: **A)** الترفع الحروري معيار صغير غير نوعي. **C)** ارتفاع سرعة التثفل معيار صغير يعكس الالتهاب الجهازي. **D)** تطاول PR على تخطيط القلب معيار صغير. **E)** ارتفاع CRP معيار صغير آخر للاستجابة الالتهابية.

الفكرة من السؤال: التهاب المفاصل العديد المتنقل هو أحد المعايير الكبرى الخمسة (وليس الصغرى) في معايير جونز، إلى جانب التهاب القلب وداء الرقص والحمامى الهامشية والعقيدات تحت الجلد.

20. كل ما يلي صحيح في قصور الصمام التاجي المزمن ماعدا:

تشرين 2023

A. يسبب توسع الأذينة اليسرى.
B. يسبب توسع البطين الأيسر.
C. يتسم بالنفخة الانقباضية في القمة التي تنتشر إلى الإبط وأيسر القص.
D. لا يؤثر على الضغط الرئوي عادة.
E. من العلاجات الدوائية إعطاء مثبطات إنزيم تحويل الأنجيوتنسين (ACEI).

الإجابة الصحيحة: D — لا يؤثر على الضغط الرئوي عادة.

التعليل السريري: القصور التاجي المزمن يمكن أن يؤدي مع تطوره إلى فرط ضغط رئوي نتيجة الاحتقان الوريدي الرئوي المزمن الناجم عن ارتفاع ضغط الأذينة اليسرى، لذا فإن القول بعدم تأثره على الضغط الرئوي غير صحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح، القصور التاجي يسبب توسع الأذينة اليسرى بشكل مباشر. **B)** صحيح، يحدث توسع مترقٍ بالبطين الأيسر نتيجة فرط الحمل الحجمي المزمن. **C)** صحيح، النفخة الانقباضية في القمة المنتشرة للإبط هي الموجودة الإصغائية المميزة. **E)** صحيح، مثبطات ACE تستخدم لتخفيف الحمل البعدي دوائياً.

الفكرة من السؤال: القصور التاجي المزمن يسبب توسعاً تدريجياً بالأذينة اليسرى والبطين الأيسر بسبب فرط الحمل الحجمي، وقد يرتفع الضغط الرئوي مع تطور الحالة وحدوث الاحتقان الوريدي الرئوي.

آذار 2023

21. فيما يتعلق بالتهاب شغاف القلب الخمجي تحت الحاد:

A. يصيب القلب السليم على الأغلب.
B. العقديات المخضرة من أشيع الأسباب بعد الجراحة.
C. زرع الدم هو الاستقصاء الأكثر أهمية.
D. لا يفيد العلاج الجراحي في الحالات التي يفشل فيها العلاج الدوائي.
E. يعتبر الإيكو عبر المري مضاد استطباب في التهاب الشغاف الخمجي.

الإجابة الصحيحة: C – زرع الدم هو الاستقصاء الأكثر أهمية.

التعليل السريري: زرع الدم يكشف الجرثوم المسبب ويوجه اختيار العلاج الصادي المناسب، وهو من المعايير الكبرى في معايير ديوك المعدلة لتشخيص التهاب الشغاف الخمجي.

الخيارات الأخرى: A) خاطئ، التهاب الشغاف تحت الحاد يصيب عادة صمامات متضررة سابقاً وليس القلب السليم. B) خاطئ، العنقوديات البشروية هي الأشيع بعد الجراحة وليست العقديات المخضرة. D) خاطئ، الجراحة مفيدة وتستطب عند فشل العلاج الدوائي. E) خاطئ، الإيكو عبر المري مفيد وأكثر حساسية وليس مضاد استطباب.

الفكرة من السؤال: زرع الدم (3-6 زروعات بتقنية عقيمة قبل بدء الصادات) هو حجر الأساس في التشخيص ويدخل ضمن معايير ديوك الكبرى.

آذار 2023

22. يعد التالي من التظاهرات الكبرى للحمى الرثوية ما عدا:

A. التهاب قلب شامل.
B. الحمى.
C. رقص سيدنهام.
D. التهاب مفاصل عديد.
E. حمامي هامشية.

الإجابة الصحيحة: B – الحمى.

التعليل السريري: الحمى من التظاهرات الصغرى في معايير جونز المعدلة، وليست تظاهرة كبرى، لذا فهي الإجابة الشاذة بين الخيارات المطروحة.

الخيارات الأخرى: A) صحيح، التهاب القلب الشامل تظاهرة كبرى. C) صحيح، رقص سيدنهام تظاهرة كبرى عصبية متأخرة. D) صحيح، التهاب المفاصل العديد المهاجر هو أشيع تظاهرة كبرى. E) صحيح، الحمامى الهامشية تظاهرة كبرى جلدية مميزة.

الفكرة من السؤال: التظاهرات الكبرى: التهاب قلب، التهاب مفاصل عديد، رقص سيدنهام، حمامى هامشية، عقيدات تحت جلدية. الحمى تعتبر من التظاهرات الصغرى فقط.

آذار 2023

23. يتعلق التالي بالتضيق الأبهري ما عدا:

A. نفخة انبساطية باكرة.
B. نبض بطيء الارتفاع.
C. زلة تنفسية جهدية.
D. ضغط نبض ضيق.
E. قد يسمع الصوت القلبي الرابع.

الإجابة الصحيحة: A — نفخة انبساطية باكرة.

التعليل السريري: النفخة المميزة لتضيق الأبهر هي نفخة انقباضية قذفية وليست انبساطية باكرة، والنفخة الانبساطية الباكرة الناعمة تشاهد في قصور الصمام الأبهري بسبب ارتداد الدم في الانبساط.

الخيارات الأخرى: **B)** صحيح، النبض بطيء الارتفاع (pulsus parvus et tardus) موجودة مميزة لتضيق الأبهر. **C)** صحيح، الزلة الجهدية من الأعراض الأساسية الثلاثة. **D)** صحيح، ضغط النبض الضيق يعكس انسداد المخرج. **E)** صحيح، قد يسمع الصوت الرابع نتيجة تضخم البطين الأيسر وضعف امتطاطه.

الفكرة من السؤال: تضيق الأبهر يعطي نفخة انقباضية قذفية خشنة تنتشر للعنق، بينما النفخة الانبساطية الباكرة تميز قصور الصمام الأبهري لا تضيقه.

---

24. كل ما يلي من الموجودات الاصغائية بالقصور التاجي ما عدا:

أيلول 2022

A. نفخة انقباضية في القمة.

B. خفوت الصوت الأول.

C. سماع صوت ثالث.

D. ضربة قمة مفرطة الحركية.

E. نفخة متواصلة تحت الترقوة اليسرى.

الإجابة الصحيحة: E — نفخة متواصلة تحت الترقوة اليسرى.

التعليل السريري: النفخة المتواصلة تحت الترقوة اليسرى مميزة للقناة الشريانية السالكة وليست من موجودات القصور التاجي، الذي يعطي نفخة انقباضية شاملة في القمة تنتشر نحو الإبط.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح، النفخة الانقباضية في القمة موجودة نموذجية. **B)** صحيح، خفوت الصوت الأول يحدث نتيجة سوء استمساك الوريقات. **C)** صحيح، الصوت الثالث يسمع بسبب فرط الجريان الانبساطي. **D)** صحيح، ضربة القمة مفرطة الحركية تعكس توسع البطين الأيسر.

الفكرة من السؤال: القصور التاجي يعطي نفخة انقباضية شاملة في القمة تنتشر للإبط مع خفوت S1 وقد يسمع S3؛ النفخات المتواصلة ليست من موجوداته.

---

25. يعد كل مما يلي من أسباب قصور الصمام التاجي (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. تدلي الصمام التاجي.

B. توسع بطين أيسر في سياق اعتلال توسعي.

C. التهاب شغاف.

D. قصور الصمام التاجي رثوي المنشأ.

E. وذمة رئة حادة.

الإجابة الصحيحة: E — وذمة رئة حادة.

التعليل السريري: وذمة الرئة الحادة هي نتيجة أو تظاهرة سريرية للقصور التاجي الحاد الشديد وليست سبباً له، بينما بقية الخيارات هي أسباب مباشرة موثقة لقصور الصمام التاجي.

الخيارات الأخرى: **A)** سبب حقيقي، تدلي الصمام يسبب قصوراً خفيفاً شائعاً. **B)** سبب حقيقي، توسع البطين الأيسر في الاعتلال التوسعي يوسع الحلقة التاجية. **C)** سبب حقيقي، التهاب الشغاف يخرب الوريقات والحبال الوترية. **D)** سبب حقيقي، الإصابة الرثوية من الأسباب الكلاسيكية لقصور التاجي.

الفكرة من السؤال: أسباب قصور التاجي: تدلي الصمام، توسع البطين الأيسر وحلقة الصمام، أذية الوريقات والحبال الوترية (رثوي/التهاب شغاف)، نقص تروية أو احتشاء العضلات الحليمية.

تشرين 2021

26. نفخة تضيق الأبهر تنتشر إلى:

A. السباتي.
B. الإبط.
C. الظهر.
D. الشرسوف.
E. أسفل القص.

الإجابة الصحيحة: A – السباتي.

التعليل السريري: يتجه تيار الدم المتسارع عبر الصمام المتضيق باتجاه قوس الأبهر ثم الشرايين السباتية، مما يفسر انتشار النفخة نحو الرقبة والسباتي.

الخيارات الأخرى: B) خاطئ، الانتشار للإبط مميز لنفخة القصور التاجي. C) خاطئ، الانتشار للظهر أكثر ما يميز تضيق برزخ الأبهر. D) خاطئ، الانتشار للشرسوف غير نموذجي لهذه النفخة. E) خاطئ، أسفل القص أكثر ما يميز نفخات الجانب الأيمن كقصور مثلث الشرف.

الفكرة من السؤال: نفخة تضيق الأبهر انقباضية قذفية خشنة، أفضل ما تسمع في البؤرة الأبهرية وتنتشر نحو الشرايين السباتية مع هرير ممكن.

تشرين 2021

27. كل ما يلي صحيح عن تضيق التاجي ما عدا:

A. احتداد الصوت الأول والمركبة الرئوية للصوت الثاني.
B. تتناسب المسافة بين المركبة الأبهرية للصوت الثاني وصكة الانفتاح عكساً مع شدة تضيق الصمام التاجي.
C. نفخة غراهام ستيل نادراً ما تسمع.
D. أفضل ما تسمع صكة الانفتاح في القمة أثناء الشهيق.
E. قد يوجد اشتداد قبيل انقباضي في الدحرجة الانبساطية.

الإجابة الصحيحة: D – أفضل ما تسمع صكة الانفتاح في القمة أثناء الشهيق.

التعليل السريري: صكة الانفتاح لا تتأثر بشكل مميز بالشهيق كما هو الحال في نفخات الصمامات اليمنى (كقصور مثلث الشرف)، وهي علامة يسارية القلب تسمع في القمة بشكل مستقل عن دورة التنفس، لذا فإن ربطها بالشهيق تحديداً غير صحيح.

الخيارات الأخرى: A) صحيح، احتداد S1 و P2 من العلامات المميزة لتضيق التاجي. B) صحيح، هذه العلاقة العكسية موثقة تشخيصياً. C) صحيح، نفخة غراهام ستيل (قصور رئوي ثانوي لفرط الضغط الرئوي) نادرة نسبياً. E) صحيح، الاشتداد قبيل الانقباضي يحدث بسبب تقلص الأذينة في النظم الجيبي.

الفكرة من السؤال: صكة الانفتاح في التضيق التاجي تسمع أفضل ما يكون في القمة، والمسافة بينها وبين S2 تتناسب عكساً مع شدة التضيق؛ لا ترتبط بالشهيق كما في نفخات الجانب الأيمن.

تشرين 2021

28. نفخة قصور التاجي:

A. انقباضية شاملة.
B. انقباضية شاملة لبؤرة رئوي.
C. انقباضية قذفية لبؤرة تاجي.
D. نفخة أوستن فلنت.
E. نفخة انقباضية دفعية.

الإجابة الصحيحة: A — انقباضية شاملة.

التعليل السريري: نظراً لاستمرار فرق الضغط بين البطين الأيسر والأذينة اليسرى طوال فترة الانقباض بأكملها، تكون نفخة القصور التاجي شاملة للانقباض بدلاً من كونها قذفية أو محدودة الزمن.

الخيارات الأخرى: **B)** خاطئ، النفخة الشاملة للانقباض في البؤرة الرئوية توحي بعيب حاجز بطيني أو قصور مثلث الشرف. **C)** خاطئ، النفخة القذفية في البؤرة التاجية غير نموذجية للقصور التاجي. **D)** خاطئ، نفخة أوستن فلنت انبساطية وتشاهد في القصور الأبهري الشديد. **E)** خاطئ، "دفعية" ليست الوصف المعتمد لنفخة القصور التاجي.

الفكرة من السؤال: نفخة القصور التاجي انقباضية شاملة (holosystolic) في القمة تنتشر للإبط، ناجمة عن ارتداد الدم المستمر طوال الانقباض للأذينة اليسرى.

---

29. واحد مما يلي من استطباب الوقاية من التهاب الشغاف الخمجي قبل الجراحة:

تشرين 2021

A. قصور قلب.
B. احتشاء.
C. رباعي فالو.
D. ارتفاع ضغط.
E. خوارج انقباض.

الإجابة الصحيحة: C — رباعي فالو.

التعليل السريري: رباعي فالو هو آفة قلبية خلقية مزرقة معقدة تصنف ضمن الفئة عالية الخطورة لالتهاب الشغاف الخمجي، وبالتالي تستطب الوقاية الصادية قبل الإجراءات الجراحية أو السنية المؤهبة.

الخيارات الأخرى: **A)** خاطئ، قصور القلب وحده ليس استطباباً نوعياً للوقاية. **B)** خاطئ، الاحتشاء لا علاقة له بالوقاية من التهاب الشغاف. **D)** خاطئ، ارتفاع الضغط الشرياني ليس عامل خطورة لالتهاب الشغاف. **E)** خاطئ، الخوارج الانقباضية اضطراب نظم حميد لا علاقة له بالوقاية.

الفكرة من السؤال: الآفات القلبية الخلقية المزرقة (كرباعي فالو) والصمامات الصنعية وسوابق التهاب الشغاف من أعلى فئات الخطورة المستطبة للوقاية الصادية قبل الإجراءات المؤهبة لتجرثم الدم.

---

30. من التظاهرات القلبية في الحمى الرثوية كل ما يلي صحيح ما عدا:

تشرين 2021

A. قصر PR.
B. التهاب الشغاف.
C. التهاب التامور.
D. التهاب العضلة القلبية.
E. قصور قلب.

الإجابة الصحيحة: A — قصر PR.

التعليل السريري: المعيار الصغير المرافق للحمى الرثوية هو إطالة الفاصلة PR (حصار أذيني بطيني درجة أولى) وليس قصرها، لذا يعد "قصر PR" معلومة خاطئة وغير موثقة كتظاهرة قلبية للحمى الرثوية.

الخيارات الأخرى: **B)** صحيح، التهاب الشغاف من مكونات التهاب القلب الرثوي الشامل. **C)** صحيح، التهاب التأمور قد يتظاهر بألم صدري أو انصباب. **D)** صحيح، التهاب العضلة القلبية قد يسبب قصور قلب. **E)** صحيح، قصور القلب قد ينجم عن التهاب القلب الرثوي الشديد.

الفكرة من السؤال: التهاب القلب الرثوي قد يصيب الشغاف والعضلة والتأمور معاً (pancarditis) ويتظاهر بنفخات جديدة وقصور قلب والتهاب تأمور؛ قصر PR ليس من التظاهرات القلبية بل حصار الدرجة الأولى (إطالة PR) هو المعيار الصغير المرتبط بالحمى الرثوية.

تشرين 2020

31. كل مما يلي من أسباب التهاب الشغاف ما عدا:

A. التحال الدموي.
B. احتشاء العضلة القلبية.
C. معالجة سنية غير عقيمة.
D. الأدوية والمخدرات الوريدية.
E. نقص المناعة المكتسب.

الإجابة الصحيحة: B – احتشاء العضلة القلبية.

التعليل السريري: احتشاء العضلة القلبية آفة نقص تروية وليس عاملاً مؤهباً لدخول الجراثيم للدم أو لأذية الشغاف كما هو الحال في بقية الخيارات، لذا فهو الاستثناء الصحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** سبب حقيقي، التحال الدموي يشكل بوابة دخول جرثومية متكررة. **C)** سبب حقيقي، المعالجة السنية غير العقيمة تسبب تجرثم دم عابر. **D)** سبب حقيقي، الحقن الوريدي غير العقيم لدى مدمني المخدرات من الأسباب الشائعة. **E)** سبب حقيقي، نقص المناعة المكتسب يزيد قابلية الخمج بجراثيم وفطور انتهازية.

الفكرة من السؤال: عوامل خطورة التهاب الشغاف الخمجي: التحال الدموي، المعالجة السنية غير العقيمة، المخدرات الوريدية، نقص المناعة المكتسب؛ احتشاء العضلة القلبية ليس عامل خطورة معروفاً.

تشرين 2020

32. الجواب الصحيح في إصغائيات القصور الأبهري:

A. نفخة انبساطية باكرة.
B. نفخة انقباضية شاملة.
C. نفخة انقباضية متأخرة.
D. احتداد الصوت الأول.
E. نفخة وسط انبساطية.

الإجابة الصحيحة: A – نفخة انبساطية باكرة.

التعليل السريري: القصور الأبهري ينجم عن ارتداد الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر خلال الانبساط عبر صمام غير ملتحم بشكل كافٍ، مما يولد نفخة انبساطية باكرة عالية التردد تبدأ فوراً بعد الصوت الثاني وتتناقص شدتها تدريجياً (decrescendo).

الخيارات الأخرى: **B)** النفخة الانقباضية الشاملة تميز قصور التاجي وليس الأبهري - **C)** النفخة الانقباضية المتأخرة تميز انسدال التاجي - **D)** احتداد الصوت الأول يميز تضيق التاجي - **E)** النفخة وسط الانبساطية تشاهد في تضيق التاجي أو نفخة كاري كومبس.

الفكرة من السؤال: القصور الأبهري: نفخة انبساطية باكرة ناعمة تُسمع أفضل أيسر القص، بوضعية الجلوس مع الانحناء للأمام وحبس النفس بنهاية الزفير؛ يترافق غالباً بنفخة انقباضية ناتجة عن زيادة حجم الضربة.

تشرين 2020

33. في النفخات البريئة كل ما يلي صحيح ما عدا:

A. انبساطية.
B. لا تنتشر.
C. ناعمة.
D. أسفل وأيسر القص.
E. لا ترافق مع هرير.

الإجابة الصحيحة: A — انبساطية.

التعليل السريري: أي نفخة انبساطية تُعد عضوية بالتعريف وتستوجب استقصاء بنيوي دائماً، لأن النفخات البريئة تنجم عن جريان دم طبيعي متسارع عبر مسالك طبيعية وتحدث حصراً أثناء الانقباض.

الخيارات الأخرى: **B)** صحيحة، النفخة البريئة لا تنتشر - **C)** صحيحة، تكون ناعمة اللحن - **D)** صحيحة، موقعها النموذجي أسفل وأيسر القص - **E)** صحيحة، لا تترافق مع هرير.

الفكرة من السؤال: النفخة البريئة انقباضية دوماً (لا تكون انبساطية أبداً)، ناعمة، لا تنتشر، لا تترافق مع هرير أو أعراض، وتُسمع عادة أسفل وأيسر القص.

34. تشاهد النزوف الشظوية في:

تشرين 2020

A. التهاب الشغاف الخمجي.
B. الصداف.
C. الحزاز.
D. الرض.
E. داء رينو.

الإجابة الصحيحة: A — التهاب الشغاف الخمجي.

التعليل السريري: تنجم النزوف الشظوية عن صمات دقيقة أو ترسب معقدات مناعية في الأوعية الشعرية تحت الأظافر عند مرضى التهاب الشغاف الخمجي، وتُشاهد إلى جانب العلامات الجهازية الأخرى كالحمى المستمرة والتعب.

الخيارات الأخرى: **B)** الصداف لا يترافق نموذجياً بالنزوف الشظوية - **C)** الحزاز غير مرتبط بها - **D)** الرض سبب ممكن لنزف شظوي منعزل لكنه ليس السياق السريري المقصود هنا - **E)** داء رينو يصيب الدوران الطرفي بنقص تروية نوبي وليس بنزوف شظوية.

الفكرة من السؤال: النزوف الشظوية (splinter hemorrhages) من التظاهرات المحيطية الكلاسيكية لالتهاب الشغاف الخمجي تحت الحاد، إلى جانب العقيدات، الطفح الحبري، وضخامة الطحال.

35. كل مما يلي صحيح في قصور الأبهري ما عدا:

حزيران 2020

A. التهاب الفقار اللاصق من العوامل المؤهبة.
B. الحمى الرثوية من العوامل المؤهبة.
C. نفخة انبساطية باكرة.
D. يشعر بحجم الضربة قوية في القصور المتوسط والخفيف.
E. نبض مرتفع متأخر القمة.

الإجابة الصحيحة: E — نبض مرتفع متأخر القمة.

التعليل السريري: في القصور الأبهري يزداد حجم الضربة بشكل كبير بسبب الحجم الانبساطي المرتد فيرتفع النبض بسرعة وينخمص بسرعة أيضاً بسبب هروب الدم للخلف؛ النبض "المرتفع متأخر القمة" يعكس عائقاً مخرجياً ثابتاً كما في التضيق الأبهري، وهذا يجعله الخيار غير الصحيح هنا.

الخيارات الأخرى: **A)** التهاب الفقار اللاصق سبب معروف لتوسع جذر الأبهر والقصور - **B)** الحمى الرثوية من الأسباب الشائعة لتخرب وريقات الصمام - **C)** النفخة الانبساطية الباكرة هي العلامة الإصغائية المميزة - **D)** في القصور الخفيف والمتوسط يُشعر بحجم الضربة القوي بسبب زيادة حجم الضربة.

الفكرة من السؤال: نبض القصور الأبهري هو نبض كبير الحجم سريع الانخماض (نبض كوينكة/water-hammer)؛ أما النبض البطيء الارتفاع متأخر القمة (parvus et tardus) فيميز التضيق الأبهري وليس القصور.

36. يستطب إعطاء الوارفارين لنصل إلى قيمة INR=3,5 في واحد مما يلي: حزيران 2020

A. تركيب صمام تاجي ميكانيكي.
B. خثرات جدارية متحركة تالية لاحتشاء العضلة القلبية.
C. اعتلال عضلة قلبية توسعي.
D. قلب نظم القلب بالصدمة الكهربائية.
E. تركيب صمام حيوي.

الإجابة الصحيحة: A – تركيب صمام تاجي ميكانيكي.

التعليل السريري: الهدف العلاجي لقيمة INR يختلف حسب موقع ونوع الصمام البديل؛ حيث يتطلب الصمام التاجي الميكانيكي تمييعاً أشد (INR بين 2.5 - 3.5 أو هدف 3.0) نظراً لانخفاض سرعة الجريان وارتفاع خطورة الخثار مقارنة بالصمام الأبهري الميكانيكي (INR بين 2.0 - 3.0 أو هدف 2.5).

الفكرة من السؤال: الهدف العلاجي لقيمة INR في الصمام التاجي الميكانيكي هو (2.5 - 3.5) لارتفاع خطورة الخثار، بينما الصمام الأبهري الميكانيكي (2.0 - 3.0).

37. يتميز القصور الأبهري بما يلي عدا: تشرين 2019

A. وجود نفخة انبساطية مبكرة.
B. وجود نفخة وسط الانبساط عضوية.
C. ضغط النبض الواسع.
D. توسع البطين الأيسر.
E. نبض كوينكة.

الإجابة الصحيحة: B – وجود نفخة وسط الانبساط عضوية.

التعليل السريري: تيار الارتداد الأبهري القوي يرفع الوريقة الأمامية للصمام التاجي أثناء الانبساط محدثاً شبه تضيق تاجي وظيفي وليس تضيقاً تشريحياً حقيقياً في الصمام، لذا فإن وصفها بأنها "عضوية" غير صحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيحة، النفخة الانبساطية الباكرة هي العلامة الأساسية - **C)** صحيحة، بسبب زيادة حجم الضربة - **D)** صحيح، يحدث توسع تعويضي للبطين الأيسر - **E)** صحيح، نبض كوينكة من العلامات المحيطية الكلاسيكية.

الفكرة من السؤال: تشمل علامات القصور الأبهري: نفخة انبساطية باكرة، ضغط نبض واسع، توسع البطين الأيسر، ونبض كوينكة؛ أما نفخة وسط الانبساط (أوستن فلينت) فهي نفخة وظيفية ناجمة عن اصطدام تيار القصور بالوريقة الأمامية للتاجي، وليست ناتجة عن آفة عضوية في الصمام التاجي.

38. كل ما يلي صحيح في الفيزيولوجيا المرضية للتضيق الأبهري عدا: تشرين 2019

A. توسع أذينة يسرى.
B. ضخامة بطينية متراكزة.
C. ارتفاع الضغط الانقباضي والانبساطي في البطين الأيسر.
D. سوء وظيفة انبساطية.
E. سوء وظيفة انقباضية مبكر.

الإجابة الصحيحة: E — سوء وظيفة انقباضية مبكر.

التعليل السريري: يستجيب البطين الأيسر لانسداد المخرج بضخامة متراكزة تعويضية تحافظ على النتاج القلبي لسنوات، لكن هذه الضخامة تُضعف الامتلاء الانبساطي مبكراً؛ أما فشل الانقباض فهو حدث متأخر يترافق مع تدهور سريري حاد عند حدوثه.

الخيارات الأخرى: **A)** توسع الأذينة اليسرى يحدث نتيجة ارتفاع الضغط الانبساطي المزمن في البطين - **B)** الضخامة المتراكزة هي الاستجابة التعويضية النموذجية - **C)** يرتفع الضغطان الانقباضي والانبساطي داخل البطين لمواجهة العائق - **D)** سوء الوظيفة الانبساطية يحدث باكراً وهو صحيح.

الفكرة من السؤال: التضيق الأبهري يسبب فرط حمل ضغطي مزمن ← ضخامة بطينية متراكزة ← سوء وظيفة انبساطية باكر، بينما تبقى الوظيفة الانقباضية محافَظة لفترة طويلة قبل أن تتدهور في المراحل المتأخرة من المرض.

---

39. التغيير المميز على تخطيط القلب في الحمى الرثوية (الروماتزمية):

تشرين 2019

A. حصار غصن أيسر.

B. حصار غصن أيمن.

C. حصار أذيني بطيني درجة أولى.

D. حصار أذيني بطيني تام.

E. حصار حزمة أمامية يسرى.

الإجابة الصحيحة: C — حصار أذيني بطيني درجة أولى.

التعليل السريري: الالتهاب الرثوي الحاد يصيب النسيج الناقل حول العقدة الأذينية البطينية إضافة لإصابته الشغاف والعضلة والتأمور، فيسبب تأخراً في النقل الأذيني البطيني يتظاهر بتطاول الفاصلة PR على التخطيط.

الخيارات الأخرى: **A)** حصار الغصن الأيسر ليس تظاهرة نموذجية للحمى الرثوية - **B)** حصار الغصن الأيمن كذلك غير مميز لها - **D)** الحصار التام نادر جداً في هذا السياق - **E)** حصار الحزمة الأمامية اليسرى غير مرتبط بالحمى الرثوية.

الفكرة من السؤال: حصار أذيني بطيني درجة أولى (تطاول PR) يُعد أحد المعايير الصغرى في معايير جونز المعدلة، وهو التغيير التخطيطي الأشيع في التهاب القلب الرثوي الحاد.

---

40. من عوامل الخطورة لالتهاب الشغاف كل مما يلي صحيح ما عدا:

شباط 2019

A. تبديل الصمام الأبهري بصمام صنعي.

B. تبديل الصمام الأبهري بصمام حيوي.

C. ASD.

D. VSD.

E. PDA.

الإجابة الصحيحة: C — ASD.

التعليل السريري: تنشأ الآفات الشغافية المؤهبة لالتهاب الشغاف في أماكن الأذية الناجمة عن تيار دم عالي السرعة والضغط يصطدم بالشغاف (كما في VSD وPDA)، بينما فارق الضغط الضئيل عبر ASD لا يولد أذية شغافية كافية لتوضع الجراثيم.

الخيارات الأخرى: **A)** الصمام الصنعي الميكانيكي من أعلى عوامل الخطورة - **B)** الصمام الحيوي أيضاً عامل خطورة معروف وإن كان أقل من الصنعي - **D)** VSD يترافق بتيار عالي الضغط مؤهب للخمج - **E)** PDA كذلك من الآفات عالية الخطورة لالتهاب الشغاف.

الفكرة من السؤال: تزداد خطورة التهاب الشغاف في الآفات ذات تيار الدم عالي الضغط أو الأسطح الصمامية غير الطبيعية (الصمامات الصنعية، PDA، VSD)؛ أما العيب الحاجزي الأذيني البسيط (ASD) فلا يترافق بارتفاع في هذه الخطورة لأن الفارق الضغطي بين الأذينتين منخفض.

---

41. مريضة بعمر 40 سنة لديها بالإصغاء دحرجة انبساطية في قمة القلب مع اشتداد قبيل انقباضي تشرين 2018

التشخيص الأرجح:

A. قصور الصمام التاجي.

B. تضيق الصمام التاجي.

C. قصور الصمام الأبهري.

D. تضيق الصمام الأبهري.

E. انسدال الصمام التاجي.

الإجابة الصحيحة: B – تضيق الصمام التاجي.

التعليل السريري: تليف وتكلس وريقات الصمام التاجي (غالباً رثوي المنشأ) يضيق فتحة الصمام فيولّد جريان دم مضطرب عبره أثناء الامتلاء الانبساطي البطيني، مع ازدياد السرعة قبيل الانقباض بفعل تقلص الأذينة اليسرى، مما يفسر الدحرجة الانبساطية والاشتداد قبيل الانقباضي.

الخيارات الأخرى: A) قصور التاجي يعطي نفخة انقباضية شاملة تنتشر للإبط وليس دحرجة انبساطية - **C)** قصور الأبهري يعطي نفخة انبساطية باكرة أفضل ما تسمع أيسر القص - **D)** تضيق الأبهري يعطي نفخة انقباضية قذفية تنتشر للعنق - **E)** انسدال التاجي يعطي تكة وسط انقباضية مع نفخة انقباضية متأخرة.

الفكرة من السؤال: تضيق التاجي: صوت أول محتد مع صكة انفتاح، نفخة وسط انبساطية منخفضة اللحن (دحرجة) في القمة مع اشتداد قبيل انقباضي ناتج عن التقلص الأذيني.

42. كل من الآفات التالية يمكن أن تسبب وذمة رئة حادة ما عدا: تشرين 2018

A. تضيق الصمام التاجي.

B. تضيق الصمام مثلث الشرف.

C. تضيق الصمام الأبهري.

D. قصور الصمام التاجي.

E. ارتفاع ضغط شرياني شديد.

الإجابة الصحيحة: B – تضيق الصمام مثلث الشرف.

التعليل السريري: يقع الصمام مثلث الشرف بين الأذينة اليمنى والبطين الأيمن، فتضيقه يحدد الجريان الوريدي الجهازي العائد ويرفع الضغط الوريدي المركزي دون أن يصل الدم أصلاً إلى الدوران الرئوي بكميات كافية لإحداث وذمة رئة، بعكس الآفات اليسرى التي ترفع الضغط الرئوي مباشرة.

الخيارات الأخرى: A) تضيق التاجي يرفع ضغط الأذينة اليسرى مباشرة مسبباً وذمة رئة - **C)** تضيق الأبهري يرفع الضغط الانبساطي بالبطين الأيسر فينعكس على الدوران الرئوي - **D)** قصور التاجي الحاد يسبب ارتفاعاً سريعاً بضغط الأذينة اليسرى ووذمة رئة حادة - **E)** ارتفاع الضغط الشرياني الشديد يرفع الحمل التلوي على البطين الأيسر مسبباً وذمة رئة.

الفكرة من السؤال: أي آفة ترفع الضغط في الدوران الرئوي (تضيق/قصور تاجي، تضيق/قصور أبهري، ارتفاع ضغط شرياني شديد) قد تسبب وذمة رئة حادة؛ أما تضيق مثلث الشرف فيعيق الجريان قبل الدوران الرئوي فيسبب احتقاناً وريدياً جهازياً (وذمات، ضخامة كبد) لا وذمة رئة.

اضطرابات النظم والنقل

29 سؤال

1. أخطر مضاعفات الرجفان الأذيني: أيار 2026

A. القصور الكلوي.
B. النزف.
C. السكتة الدماغية.
D. نقص الصوديوم.
E. الصدمة.

الإجابة الصحيحة: C — السكتة الدماغية.

التعليل السريري: غياب التقلص الأذيني المنظم في الرجفان الأذيني يؤدي لركودة الدم داخل الأذينة اليسرى (خاصة الأذين) وتشكل خثرات قد تنفصل وتسبب صمة دماغية، وهي المضاعفة الأخطر والأشيع من حيث العبء المرضي.

الخيارات الأخرى: B) القصور الكلوي ليس مضاعفة مباشرة نموذجية للرجفان الأذيني - C) النزف هو خطر مرتبط بعلاج مضادات التخثر وليس بالمرض نفسه - D) نقص الصوديوم غير مرتبط بالرجفان الأذيني - E) الصدمة نادرة الحدوث كمضاعفة مباشرة مقارنة بالسكتة.

الفكرة من السؤال: توسع الأذينة اليسرى وفقدان تقلصها الفعال في الرجفان الأذيني يسببان ركودة دموية وتشكل خثرات (خاصة بالأذينة)، مما يرفع خطر السكتة الدماغية والصمات الجهازية بشكل ملحوظ - أساس استطباب مضادات التخثر.

2. في الرجفان البطيني VF العلاج الأول: أيار 2026

A. الأدينوزين Adenosine.
B. قلب النظم الكهربائي Cardioversion.
C. الصدمة الكهربائية غير المتزامنة Defibrillation.
D. الأميودارون Amiodarone.
E. حاصرات بيتا Beta blockers.

الإجابة الصحيحة: C — الصدمة الكهربائية غير المتزامنة Defibrillation.

التعليل السريري: في الرجفان البطيني تكون الفعالية الكهربائية للبطينين فوضوية تماماً دون نتاج قلبي فعال، وبما أنه لا يوجد نظم منظم لمزامنة الصدمة معه، يجب توصيل صدمة كهربائية غير متزامنة عالية الطاقة فوراً لإيقاف كل الفعالية الكهربائية الفوضوية والسماح بعودة نظم منظم.

الخيارات الأخرى: A) الأدينوزين يُستخدم في التسرعات فوق البطينية وليس في الرجفان البطيني - B) قلب النظم المتزامن يُستخدم في تسرعات منظمة (كالرجفان الأذيني أو AVNRT) وليس في الرجفان البطيني الفوضوي - D) الأميودارون علاج مساعد لاحق بعد الصدمات وليس الخط الأول - E) حاصرات بيتا ليست علاجاً إسعافياً للحالة الحادة.

الفكرة من السؤال: الرجفان البطيني هو نظم قابل للصدم؛ العلاج الفوري هو Defibrillation غير المتزامن دون تأخير لإعادة تنظيم النشاط الكهربائي القلبي، ضمن بروتوكول ACLS.

3. أي من التالي يصف نوع النبض أو اضطراب النظم المتوقع سريرياً في حصار القلب من الدرجة الثانية نمط وينكباخ (موبيتز 1): دكتوراه 2025

A. مركب QRS عريض وثابت.
B. تطاول PR ثابت.
C. عدم انتظام غير منتظم.
D. عدم انتظام منتظم.
E. غياب كامل لموجات P.

الإجابة الصحيحة: D — عدم انتظام منتظم.

التعليل السريري: في ظاهرة وينكباخ يزداد تأخر النقل الأذيني البطيني تدريجياً مع كل ضربة حتى تفشل إحدى الإشارات بالكامل في الوصول للبطينين، فتسقط ضربة، ثم تعاد الدورة من جديد بشكل متكرر ومنتظم، مما يجعل النبض "غير منتظم بشكل منتظم" (عدم انتظام منتظم).

الخيارات الأخرى: **A)** العريض الثابت يميز حصار الغصن وليس وينكباخ - **B)** تطاول PR الثابت يميز موبيتز II - **C)** عدم الانتظام غير المنتظم يميز الرجفان الأذيني - **E)** غياب موجات P يشاهد في الرجفان الأذيني أو التوقف الجيبي.

الفكرة من السؤال: تطاول تدريجي في PR حتى سقوط ضربة ثم تتكرر الدورة، مما يعطي نمط "عدم انتظام منتظم"؛ شائع عند الرياضيين الشباب ذوي المقوية المبهمية العالية وغالباً لا عرضي.

---

4. ما هي العلامة السريرية المميزة التي يمكن مشاهدتها على النبضان الوريدي الوداجي عند مريض مصاب بحصار قلب تام: دكتوراه 2025

A. أمواج مدفعية (Cannon waves).

B. غياب الموجة A بالكامل.

C. موجة V عملاقة.

D. انخفاض شديد في JVP.

E. علامة كوسماول الإيجابية.

الإجابة الصحيحة: A — أمواج مدفعية (Cannon waves).

التعليل السريري: بسبب الافتراق الأذيني البطيني التام، قد تنقبض الأذينة اليمنى أحياناً في وقت يكون فيه الصمام ثلاثي الشرف مغلقاً (انقباض بطيني متزامن)، فيرتد الدم نحو الأوردة الوداجية محدثاً موجة مدفعية عملاقة غير منتظمة الظهور.

الخيارات الأخرى: **B)** الموجة A لا تغيب بل تكون متغيرة الشدة بسبب الافتراق - **C)** الموجة V العملاقة تشاهد في القلس ثلاثي الشرف - **D)** لا يحدث انخفاض شديد ثابت في JVP كعلامة مميزة - **E)** علامة كوسماول تخص التهاب التأمور العاصر وليست حصار القلب.

الفكرة من السؤال: في الحصار التام تنبض الأذينتان والبطينان باستقلالية (افتراق أذيني بطيني)؛ عند تزامن انقباض الأذينة مع إغلاق الصمام الأذيني البطيني تظهر أمواج مدفعية على النبضان الوداجي، مع تبدل شدة الصوت القلبي الأول.

---

5. كل ما يلي يعد من أسباب تسرع القلب الجيبي ماعدا: كانون 2025

A. فرط نشاط الغدة الدرقية.

B. فقر الدم الشديد.

C. الترفع الحروري والحمى.

D. تناول وتدبير الأدوية بحاصرات بيتا.

E. تناول المواد الحاوية على الكافيين.

الإجابة الصحيحة: D — تناول وتدبير الأدوية بحاصرات بيتا.

التعليل السريري: حاصرات بيتا تحصر مستقبلات بيتا الودية على العقدة الجيبية فتنقص من معدل زوال الاستقطاب التلقائي، مما يؤدي إلى بطء القلب الجيبي وليس تسرعه، لذا فهي ليست سبباً لتسرع القلب الجيبي.

الخيارات الأخرى: **A)** فرط نشاط الدرق يزيد الفعالية الودية القلبية - **B)** فقر الدم الشديد يحرض تسرعاً تعويضياً - **C)** الحمى تزيد الاستقلاب ومعدل القلب - **E)** الكافيين منبه ودي مباشر للعقدة الجيبية.

الفكرة من السؤال: تسرع القلب الجيبي ينجم عن زيادة الفعالية الودية: فقر دم، حمى، تسمم درقي، قصور قلب، صدمة، كافيين؛ بينما حاصرات بيتا تنقص الفعالية الودية وتسبب بطء القلب لا تسرعه.

6. كل ما يلي يرافق تسرع القلب الجيبي ماعدا: تموز 2025

A. فقر الدم.
B. الترفع الحروري.
C. الإفراط في تناول القهوة.
D. قصور الدرق.
E. الحمل.

الإجابة الصحيحة: D — قصور الدرق.

التعليل السريري: نقص هرمونات الدرق يخفض الحساسية القلبية للكاتيكولامينات ومعدل الاستقلاب الخلوي في العقدة الجيبية، فينتج عنه إبطاء في معدل زوال الاستقطاب التلقائي وبالتالي بطء قلب جيبي، خلافاً لبقية الحالات المدرجة التي تزيد الفعالية الودية.

الخيارات الأخرى: **A)** فقر الدم يرافقه تسرع تعويضي - **B)** الحمى ترفع معدل الاستقلاب فتسرّع القلب - **C)** القهوة منبه ودي مباشر - **E)** الحمل يزيد الحجم الدموي والفعالية الودية فيسرّع القلب.

الفكرة من السؤال: قصور الدرق ينقص الاستقلاب القاعدي والفعالية الودية القلبية فيسبب بطء قلب جيبي، بعكس فرط نشاط الدرق الذي يسبب تسرعاً.

7. كل ما يلي صحيح في الرجفان الأذيني ماعدا: تموز 2025

A. يتظاهر إصغائياً بعدم انتظام غير منتظم.
B. من أسبابه الآفات التي توسع الأذينة اليسرى كالتضيق التاجي.
C. تزول الموجة P على تخطيط كهربائية القلب.
D. يؤهب لحدوث صمة دماغية بسبب تشكل الخثار في الأذينة اليسرى أو لسينتها.
E. يزول احتمال تشكل الخثار بإعطاء الأسبرين.

الإجابة الصحيحة: E — يزول احتمال تشكل الخثار بإعطاء الأسبرين.

التعليل السريري: فعالية الأسبرين المضادة للصفيحات محدودة مقارنة بمضادات فيتامين K في الوقاية من الخثار داخل الأذينة اليسرى الراكدة الدم بسبب فقدان التقلص الأذيني الفعال، لذا لا يُلغى احتمال تشكل الخثار بإعطائه بل يُخفَّض جزئياً فقط.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح، الرجفان الأذيني يعطي عدم انتظام غير منتظم إصغائياً - **B)** صحيح، التضيق التاجي من أشيع أسباب توسع الأذينة اليسرى المؤهبة - **C)** صحيح، تختفي موجة P تخطيطياً - **D)** صحيح، ركود الدم الأذيني يؤهب للخثار والصمة الدماغية.

الفكرة من السؤال: الوارفارين بهدف INR 2-3 يخفض خطر السكتة بمقدار الثلثين، بينما الأسبرين يخفضه بمقدار الخمس فقط - أي أن خطر الخثار يبقى قائماً معه.

8. أي مما يلي لا يفيد في ضبط الاستجابة القلبية (المعدل البطيني) في الرجفان الأذيني: تشرين 2024

A. البروبرانولول.
B. الديجوكسين.
C. الأملوديبين.
D. الفيراباميل.
E. الديلتيازيم.

الإجابة الصحيحة: C — الأمْلوديبين.

التعليل السريري: الأمْلوديبين من زمرة ثنائي الهيدروبيريدين ويعمل بشكل انتقائي تقريباً على الأوعية المحيطية دون تأثير مباشر مهم على النقل عبر العقدة الأذينية البطينية، لذا لا يفيد في إبطاء الاستجابة البطينية في الرجفان الأذيني بخلاف فيراباميل والديلتيازيم.

الخيارات الأخرى: **A)** البروبرانولول يبطئ النقل عبر العقدة الأذينية البطينية - **B)** الديجوكسين يزيد التوتر المبهمي فيبطئ النقل العقدي - **D)** الفيراباميل يثبط قنوات الكالسيوم العقدية مباشرة - **E)** الديلتيازيم له فعالية مماثلة على العقدة الأذينية البطينية.

الفكرة من السؤال: ضبط معدل الرجفان الأذيني يتم بحاصرات بيتا، الديجوكسين، أو حاصرات الكالسيوم غير ثنائية الهيدروبيريدين (فيراباميل، ديلتيازيم)؛ الأمْلوديبين ليس له تأثير معتبر على العقدة الأذينية البطينية.

---

9. كل ما يلي يسبب تسرعاً في القلب عدا:

تشرين 2024

A. تناول المنبهات.

B. قصور الدرق.

C. الترفع الحروري.

D. التوتر النفسي.

E. فقر الدم.

الإجابة الصحيحة: B — قصور الدرق.

التعليل السريري: انخفاض هرمونات الدرق في قصور الدرق يقلل من حساسية مستقبلات القلب للكاتيكولامينات ومن الاستقلاب الخلوي في العقدة الجيبية، فينتج بطء قلب جيبي وليس تسرعاً، على عكس بقية الخيارات التي تفعّل الجهاز الودي أو تزيد الطلب الاستقلابي.

الخيارات الأخرى: **A)** المنبهات تحرض الجهاز الودي مباشرة - **C)** الحمى تزيد الاستقلاب القاعدي والحاجة لتسرع القلب - **D)** التوتر النفسي يفعّل الجملة الودية - **E)** فقر الدم يحرض تسرعاً تعويضياً لتعويض نقص حمل الأكسجين.

الفكرة من السؤال: قصور الدرق يسبب بطء قلب جيبي بسبب نقص الفعالية الاستقلابية والودية، بعكس المنبهات والحمى والتوتر النفسي وفقر الدم التي تسرّع القلب.

---

10. واحد مما يلي صحيح في الرجفان الأذيني:

أيار 2024

A. يزداد ارتفاع موجة A على مخطط النبضان الوداجي.

B. يزداد عمق الموجة X على مخطط النبضان الوداجي.

C. يسمع الصوت الرابع.

D. بالإصغاء عدم انتظام غير منتظم.

E. تزداد شدة النفخة قبيل الانقباضية في تضيق الصمام التاجي.

الإجابة الصحيحة: D — بالإصغاء عدم انتظام غير منتظم.

التعليل السريري: تنبض الأذينتان بسرعة وفوضى تامة دون تقلص فعال، وتُنقل الإشارات إلى البطينين بشكل عشوائي عبر العقدة الأذينية البطينية تبعاً لفترة العصيان المتغيرة لحظياً، مما ينتج عنه فواصل RR غير منتظمة بلا أي نمط متكرر يمكن التنبؤ به.

الخيارات الأخرى: **A)** لا توجد موجة A أصلاً لغياب التقلص الأذيني الفعال - **B)** لا توجد موجة X مميزة بنفس السبب - **C)** الصوت الرابع يستلزم انقباضاً أذينياً منسقاً وهو غائب في الرجفان - **E)** النفخة قبيل الانقباضية في التضيق التاجي تتطلب انقباضاً أذينياً فعالاً فتزول لا تشتد مع الرجفان.

الفكرة من السؤال: الرجفان الأذيني يسبب نبضاً محيطياً وقلبياً "غير منتظم بشكل غير منتظم" لغياب أي نمط دوري متكرر في تفعيل البطينين عبر العقدة الأذينية البطينية.

آذار 2023

11. يحدث عدم الانتظام غير المنتظم في:

A. التسرع الجيبي.
B. التسرع الاشتدادي فوق البطيني.
C. الرجفان الأذيني.
D. بطء القلب الجيبي.
E. التسرع البطيني.

الإجابة الصحيحة: C – الرجفان الأذيني.

التعليل السريري: غياب التقلص الأذيني المنظم في الرجفان الأذيني يؤدي لنقل عشوائي غير متوقع للإشارات عبر العقدة الأذينية البطينية، فتنتج فواصل RR متفاوتة بلا أي نمط دوري يمكن التنبؤ به، وهذا ما يميزه عن باقي اللانظميات.

الخيارات الأخرى: A) التسرع الجيبي منتظم النظم - B) التسرع فوق البطيني الاشتدادي منتظم تماماً - D) بطء القلب الجيبي منتظم - E) التسرع البطيني منتظم عادةً رغم اتساع QRS.

الفكرة من السؤال: عدم الانتظام غير المنتظم (بلا نمط متكرر) هو السمة الإصغائية والنبضية المميزة للرجفان الأذيني، بخلاف اللانظميات الأخرى ذات النبض المنتظم أو المنتظم-اللامنتظم الدوري.

أيلول 2022

12. كل ما يلي صحيح في خوارج الانقباض البطينية ما عدا:

A. مركب QRS عريض وباكر.
B. عادة غير عرضية.
C. شائعة عند الاصحاء.
D. توجد عند مرضى قصور القلب.
E. يجب ان تعالج دائماً.

الإجابة الصحيحة: E – يجب ان تعالج دائماً.

التعليل السريري: خوارج الانقباض البطينية شائعة عند الأصحاء وعادة لا عرضية، والعلاج (بحاصرات بيتا) يُقتصر على الحالات العرضية الشديدة أو عند وجود مرض قلبي كامن كقصور القلب، وليس كقاعدة إلزامية لكل المرضى، لذا فإن "يجب أن تعالج دائماً" غير صحيح.

الخيارات الأخرى: A) صحيح، مركب QRS باكر وعريض بشكل شاذ سمة تخطيطية أساسية - B) صحيح، غالباً لا عرضية - C) صحيح، شائعة عند الأصحاء تماماً - D) صحيح، تترافق مع إنذار سيء عند مرضى قصور القلب أو ما بعد الاحتشاء.

الفكرة من السؤال: تُعالج خوارج الانقباض البطينية فقط عند العرضية الشديدة أو المرافقة لقصور القلب أو الاحتشاء الحاد، وليس بشكل دائم أو روتيني عند جميع المرضى.

أيلول 2022

13. كل ما يلي صحيح في الرجفان الأذيني ما عدا:

A. غير عرضي احيانا.
B. عدم انتظام منتظم.
C. يمكن ان يكون نوبياً.
D. من أسبابه فرط نشاط الدرق.
E. من مضاعفاته الانصمام الجهازي.

الإجابة الصحيحة: B – عدم انتظام منتظم.

التعليل السريري: النقل الأذيني البطيني في الرجفان الأذيني عشوائي تماماً وغير قابل للتنبؤ لغياب أي انقباض أذيني منظم، فتنتج فواصل RR متغيرة بلا نمط متكرر (عدم انتظام غير منتظم)، وليس "عدم انتظام منتظم" كما ورد في هذا الخيار.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح، قد يكون لا عرضياً أحياناً - **C)** صحيح، يمكن أن يكون نوبياً (انتيابياً) - **D)** صحيح، فرط نشاط الدرق سبب معروف - **E)** صحيح، الانصمام الجهازي مضاعفة رئيسية معروفة.

الفكرة من السؤال: الرجفان الأذيني يتميز بعدم انتظام غير منتظم (بلا نمط دوري)، أما عدم الانتظام المنتظم فهو سمة حصار وينكباخ (موبيتز I) وليس الرجفان الأذيني.

14. يؤدي كل مما يلي لبطء قلب جيبي (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. قصور درق.
B. ارتفاع حرارة.
C. ارتفاع توتر داخل القحف.
D. اليرقان الركودي.
E. حاصرات بيتا.

الإجابة الصحيحة: B – ارتفاع حرارة.

التعليل السريري: ارتفاع الحرارة يزيد من معدل الاستقلاب الخلوي والحاجة الأكسجينية للأنسجة، مما يحرض زيادة تعويضية في معدل ضربات القلب (تسرع جيبي)، على عكس بقية الخيارات التي تنقص الفعالية الودية أو تنبه المبهم فتسبب بطء القلب.

الخيارات الأخرى: **A)** قصور الدرق ينقص الاستقلاب والفعالية الودية فيبطئ القلب - **C)** ارتفاع التوتر داخل القحف ينبه المبهم (منعكس كوشينغ) - **D)** اليرقان الركودي يترافق ببطء قلب بآلية غير كاملة الوضوح مرتبطة بالأملاح الصفراوية - **E)** حاصرات بيتا تثبط تأثير الكاتيكولامينات على العقدة الجيبية مباشرة.

الفكرة من السؤال: بطء القلب الجيبي ينجم عن قصور الدرق، ارتفاع التوتر داخل القحف، اليرقان الركودي، وحاصرات بيتا، بينما الحمى ترفع الاستقلاب وتسبب تسرع القلب لا بطأه.

15. كل مما يلي صحيح في الرجفان الأذيني (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. قد يكون غير عرضي.
B. قد يسبب خفقان وزلة.
C. قد يحرض نقص تروية إكليلية.
D. قد يثير هجمة قصور قلب.
E. لا يزيد من خطر حدوث السكتات الدماغية والانسمام الجهازي.

الإجابة الصحيحة: E – لا يزيد من خطر حدوث السكتات الدماغية والانسمام الجهازي.

التعليل السريري: في الرجفان الأذيني تفقد الأذينة تقلصها المنسق فيركد الدم فيها (خاصة الأذينة اليسرى)، مما يهيئ لتشكل خثرات قد تنصمم للدوران الجهازي أو الدماغي، لذا فإن العبارة النافية لزيادة الخطر خاطئة.

الخيارات الأخرى: **A:** صحيح، غالباً ما يكون غير عرضي. **B:** صحيح، من أعراضه الخفقان والزلة. **C:** صحيح، قد يحرض نقص تروية عند مرضى الداء الإكليلي. **D:** صحيح، قد يثير قصور قلب عند ضعف الوظيفة البطينية.

الفكرة من السؤال: توسع الأذينة اليسرى وفقدان تقلصها الفعال يؤديان لركودة الدم وتشكل الخثرات؛ يخفض الوارفارين خطر السكتة بمقدار الثلثين مقارنة بخُمس فقط مع الأسبرين.

16. الأدوية التالية يبطئ من سرعة القلب إجابة خاطئة وحيدة): آذار 2022

A. الميتوبرولول.
B. البروبرانولول.
C. الديلتيازم.
D. الفير باميل.
E. النفيدبين.

الإجابة الصحيحة: E – النفيدبين.

التعليل السريري: النيفيديبين حاصر قنوات كالسيوم من زمرة الديهدروبيريدين، له تأثير انتقائي على الأوعية المحيطية دون تأثير يُذكر على العقدة الجيبية أو الأذينية البطينية، وقد يسبب تسرع قلب منعكس بسبب توسع وعائي مفاجئ بدلاً من إبطاء القلب.

الخيارات الأخرى: A وB: حاصرات بيتا تبطئ القلب عبر تثبيط التأثير الودي على العقدة الجيبية. C وD: الديلتيازم والفيراباميل يبطئان النقل عبر العقدة الأذينية البطينية والجيبية.

الفكرة من السؤال: حاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم غير الديهدروبيريدينية (فيراباميل، ديلتيازم) تبطئ معدل القلب، أما ثنائيات الهيدروبيريدين (نيفيديبين) فتوسع الأوعية بشكل انتقائي وقد تسبب تسرعاً منعكساً.

17. كل ما يلي يسبب انحراف محور القلب للأيمن ما عدا: تشرين 2021

A. رباعي فالو.
B. رتق مثلث الشرف.
C. تضيق رئوي.
D. الـ ASD ثانوية.
E. بطين أيمن ثنائي المخرج مع تضيق صمام رئوي.

الإجابة الصحيحة: B – رتق مثلث الشرف.

التعليل السريري: انحراف المحور نحو اليمين ينتج عادة عن ضخامة أو فرط عبء ضغطي/حجمي على البطين الأيمن. في رتق مثلث الشرف يغيب مدخل البطين الأيمن فيبقى ناقص التصنع، فيسيطر البطين الأيسر كهربائياً مسبباً انحرافاً يسارياً للمحور.

الخيارات الأخرى: A: رباعي فالو يسبب ضخامة بطين أيمن وانحراف يميني. C: التضيق الرئوي يرفع ضغط البطين الأيمن. D: الـASD الثانوية تسبب فرط حمل حجمي للبطين الأيمن. E: بطين أيمن ثنائي المخرج مع تضيق رئوي يضخم البطين الأيمن.

الفكرة من السؤال: رتق مثلث الشرف يترافق مع نقص تصنع البطين الأيمن وسيطرة البطين الأيسر، لذا يسبب انحرافاً للمحور نحو اليسار وليس اليمين، خلافاً لمعظم آفات ضخامة البطين الأيمن.

18. كل ما يلي يسبب بطء قلب جيبي ما عدا: تشرين 2021

A. حاصرات بيتا.
B. سالبوتامول.
C. ارتفاع التوتر داخل القحف.
D. قصور درق.
E. الغثيان والإقياء.

الإجابة الصحيحة: B – سالبوتامول.

التعليل السريري: السالبوتامول منبه لمستقبلات بيتا الأدرينالية، فيرفع معدل تفريغ العقدة الجيبية ويسبب تسرعاً جيبياً كأثر جانبي شائع، وليس بطء قلب.

الخيارات الأخرى: A: حاصرات بيتا تثبط التنبيه الودي فتبطئ العقدة الجيبية. C: ارتفاع الضغط داخل القحف يحرض منعكس كوشينغ المسبب لبطء القلب. D: قصور الدرق ينقص الاستقلاب والفعالية الودية فيبطئ القلب. E: الغثيان والإقياء يحرضان تنبيهاً مبهمياً مسبباً بطء القلب.

الفكرة من السؤال: السالبوتامول ناهض بيتا-2 يسبب تسرع قلب جيبي (وليس بطئاً) عبر التنبيه الودي، بعكس حاصرات بيتا التي تبطئ القلب.

---

19. شاب عانى من تسرع فوق بطيني، تم التسريب الوريدي للأدينوزين ولم يتحسن وضغطه 60/90 الخطوة التالية: تشرين 2021

A. الاستمرار بالتسريب مع زيادة الجرعة.

B. صدمة كهربائية.

C. ديجوكسين.

D. حاصر بيتا.

E. الليدوكائين.

الإجابة الصحيحة: B – صدمة كهربائية.

التعليل السريري: عدم استجابة النظم للأدينوزين مع وجود انخفاض ضغط شرياني يعني عدم استقرار ديناميكي دموي، وهذا يستوجب إنهاء التسرع فوراً عبر قلب النظم الكهربائي المتزامن بدلاً من الاستمرار بالمحاولات الدوائية التي تستغرق وقتاً وقد لا تنجح.

الخيارات الأخرى: A: زيادة جرعة الأدينوزين لا تفيد بعد الفشل وتضيع وقتاً ثميناً في حالة عدم استقرار. C: الديجوكسين بطيء المفعول ولا يناسب الحالات الإسعافية غير المستقرة. D: حاصرات بيتا قد تزيد سوءاً في المريض غير المستقر ديناميكياً. E: الليدوكائين مخصص لاضطرابات النظم البطينية وليس فوق البطينية.

الفكرة من السؤال: عند وجود اضطراب ديناميكي شديد (توتر شرياني منخفض) مرافق للتسرع فوق البطيني، تكون الصدمة الكهربائية المتزامنة الإسعافية هي الخطوة التالية بغض النظر عن استجابة الأدينوزين.

---

20. كل ما يلي من استطبابات علاج خوارج الانقباض ما عدا: تشرين 2021

A. اللاعرضية.

B. وجود R/T.

C. أكثر من 5/د.

D. خوارج الانقباض بعد احتشاء العضلة القلبية.

E. أدت إلى تسرع.

الإجابة الصحيحة: A — اللاعرضية.

التعليل السريري: خوارج الانقباض اللاعرضية عند شخص سليم القلب حميدة ولا تستلزم علاجاً؛ الاستطباب يكون فقط عند وجود أعراض شديدة أو علامات خطورة كوجود مؤشرات لاضطراب نظم خبيث أو ترافقها مع مرض قلبي عضوي (كاحتشاء حديث).

الخيارات الأخرى: B: ظاهرة R/T تنذر بخطر تحريض تسرع أو رجفان بطيني فتستدعي العلاج. C: تواتر مرتفع (أكثر من 5/د) قد يترافق بإنذار سيئ عند مرضى القلب العضوي. D: بعد الاحتشاء تترافق مع خطورة اضطراب نظم مهدد للحياة. E: إذا أدت إلى تسرع قلب تصبح عرضية ومستطبة للعلاج.

الفكرة من السؤال: خوارج الانقباض البطينية شائعة عند الأصحاء ولا تحتاج علاجاً إلا إذا كانت عرضية بشدة، أو مترافقة مع علامات إنذارية سيئة كوجود ظاهرة R على T أو كثرة التواتر أو حدوثها بعد احتشاء العضلة القلبية.

---

21. الاضطراب الأساسي في تخطيط القلب عند اضطراب نقص البوتاسيوم هو:

حزيران 2021

A. موجة U.
B. تأنف الموجة T.
C. مركب QRS عريض.
D. غياب P.
E. تزحل ST.

الإجابة الصحيحة: A — موجة U.

التعليل السريري: انخفاض البوتاسيوم خارج الخلية يبطئ إعادة الاستقطاب البطيني في الطور الأخير، مما يبرز الموجة U (تالية للموجة T) كتعبير عن تأخر إعادة استقطاب ألياف بوركنجي، وهي العلامة الأساسية والأكثر نوعية لنقص البوتاسيوم.

الخيارات الأخرى: B: تأنف الموجة T يشاهد ولكنه أقل نوعية من الموجة U. C: توسع QRS أكثر ارتباطاً بفرط البوتاسيوم لا نقصه. D: غياب P يشاهد في الرجفان الأذيني وليس نقص البوتاسيوم. E: تزحل ST علامة مرافقة ثانوية وليست الاضطراب الأساسي.

الفكرة من السؤال: نقص البوتاسيوم يظهر تخطيطياً بموجة U بارزة، تسطح الموجة T، وتطاول الفاصلة QU؛ عند الشدة يحدث تزحل ST وقد يستعد لاضطرابات نظم خطيرة.

---

22. اضطراب النظم الأشيع في التسمم الدرقي:

حزيران 2021

A. الرجفان الأذيني.
B. تسرع القلب الجيبي.
C. رفرفة أذينية.
D. التسرع البطيني.
E. الرجفان البطيني.

الإجابة الصحيحة: B — تسرع القلب الجيبي.

التعليل السريري: زيادة هرمونات الدرق ترفع الحساسية للكاتيكولامينات وتزيد الاستقلاب القاعدي، فترفع معدل تفريغ العقدة الجيبية بشكل مستمر مسببة تسرعاً جيبياً وهو الأشيع بين اضطرابات النظم في هذه الحالة، بينما الرجفان الأذيني أشيع نوعياً كارتباط لكنه أقل حدوثاً إجمالاً.

الخيارات الأخرى: A: الرجفان الأذيني معروف الارتباط بالتسمم الدرقي لكنه أقل شيوعاً من التسرع الجيبي. C: الرفرفة الأذينية أقل شيوعاً بكثير. D وEg: اضطرابات النظم البطينية نادرة نسبياً في هذا السياق.

الفكرة من السؤال: تسرع القلب الجيبي يوجد عند غالبية مرضى التسمم الدرقي بسبب فرط الفعالية الودية والاستقلاب، بينما يحدث الرجفان الأذيني في نسبة أقل من المرضى (خصوصاً كبار السن).

حزيران 2021

23. كل ما يلي صحيح عن الرجفان الأذيني ما عدا:

A. شائع في آفات الصمام التاجي.
B. نستخدم الأميودارون للوقاية من النوب.
C. النوبي عبارة عن نوب متتقعة تنتهي لوحدها.
D. في الرجفان الأذيني النوبي تنهي الهجمات دائماً بالعلاج الدوائي.
E. لا يمكن بالرجفان الأذيني سماع الصوت الرابع.

الإجابة الصحيحة: D – في الرجفان الأذيني النوبي تنهي الهجمات دائماً بالعلاج الدوائي.

التعليل السريري: بحسب التصنيف القياسي، الشكل النوبي من الرجفان الأذيني يتميز تحديداً بانتهاء النوب ذاتياً دون تدخل علاجي، لذا فإن القول بأنها "تنتهي دائماً بالعلاج الدوائي" مناقض للتعريف الأساسي لهذا الشكل.

الخيارات الأخرى: A: صحيح، شائع في الداء التاجي الرثوي. B: صحيح، الأميودارون يستخدم للوقاية من النوب. C: صحيح، هذا هو تعريف الشكل النوبي بالضبط. E: صحيح، غياب التقلص الأذيني الفعال يمنع سماع الصوت الرابع.

الفكرة من السؤال: الرجفان الأذيني النوبي = نوب متقطعة تنتهي لوحدها عفوياً؛ المستمر يحتاج تدخلاً لإنهائه (دوائياً أو كهربائياً)؛ الدائم لا يُحاول فيه استعادة النظم الجيبي.

تشرين 2020

24. في دعم الحياة المتقدم لا يجوز صدم المريض في واحد مما يلي:

A. تسرع بطيني.
B. رجفان بطيني.
C. لا انقباض.
D. رفرفة أذينية مع استجابة 1/1.
E. رجفان أذيني مع استجابة بطينية 2/250.

الإجابة الصحيحة: C – لا انقباض.

التعليل السريري: اللاانقباض (Asystole) هو غياب تام للفعالية الكهربائية القلبية، ولا يوجد نظم كهربائي منظم يمكن أن تعيد الصدمة الكهربائية تصفيته أو مزامنته، لذا فإن الصدم غير مفيد بل يضيع وقتاً ثميناً عن الإنعاش القلبي الرئوي الفعال والأدرينالين.

الخيارات الأخرى: A وB: رجفان وتسرع بطيني بدون نبض قابلان للصدم مباشرة. D: رفرفة أذينية باستجابة 1/1 تعطي تسرعاً بطينياً خطيراً قد يستدعي قلب نظم كهربائي إسعافي. E: استجابة بطينية سريعة جداً في الرجفان الأذيني قد تستدعي قلب نظم كهربائي عاجل لعدم الاستقرار الديناميكي.

الفكرة من السؤال: القابل للصدم: رجفان بطيني وتسرع بطيني بدون نبض. غير القابل للصدم: لا انقباض والنشاط الكهربائي بدون نبض؛ يُدار الأخيران بالإنعاش القلبي الرئوي المستمر والأدرينالين.

تشرين 2020

25. تغيب الموجة P في:

A. التسرع الجيبي.
B. التسرع البطيني.
C. التسرع فوق البطيني.
D. الرجفان الأذيني.
E. الرفرفة الأذينية.

الإجابة الصحيحة: D — الرجفان الأذيني.

التعليل السريري: في الرجفان الأذيني تفقد الأذينة تفعيلها المنظم من العقدة الجيبية وتستبدل بتفعيل فوضوي متعدد البؤر لا ينتج عنه موجة P واضحة، بل خط أساس مضطرب، مع نقل عشوائي عبر العقدة الأذينية البطينية يعطي مركبات QRS غير منتظمة.

الخيارات الأخرى: A: التسرع الجيبي يحافظ على موجة P طبيعية الشكل والمصدر. B: التسرع البطيني له فعالية أذينية منفصلة (تفكك أذيني بطيني) وليس غيابها التام. C: التسرع فوق البطيني يظهر موجات P (قد تكون شاذة الشكل). E: الرفرفة الأذينية تظهر موجات رفرفة منتظمة بشكل أسنان المنشار وليس غياباً تاماً.

الفكرة من السؤال: الرجفان الأذيني: غياب موجات P واستبدالها بخط أساس متموج غير منتظم مع مركبات QRS غير منتظمة زمنياً (اضطراب نظم غير منتظم بشكل غير منتظم).

---

26. في الرجفان الأذيني كل ما يلي صحيح ما عدا:

حزيران 2020

A. قد يكون غير عرضي.
B. قد يكون نوبي.
C. اضطراب نظم منتظم.
D. من أعراضه الخفقان والزلة التنفسية.
E. يرفع من خطر حدوث الحوادث الوعائية الدماغية.

الإجابة الصحيحة: C — اضطراب نظم منتظم.

التعليل السريري: النشاط الأذيني الفوضوي وغير المنسق في الرجفان الأذيني ينقل بشكل متقطع وعشوائي عبر العقدة الأذينية البطينية إلى البطينين، مما ينتج فواصل RR متغيرة بلا أي نمط متكرر، أي أنه اضطراب نظم غير منتظم أساساً وليس منتظماً.

الخيارات الأخرى: A: صحيح، غالباً غير عرضي. B: صحيح، قد يكون نوبياً حسب التصنيف. D: صحيح، من أعراضه الخفقان والزلة. E: صحيح، يرفع خطر السكتات والحوادث الوعائية الدماغية.

الفكرة من السؤال: الرجفان الأذيني = اضطراب نظم "غير منتظم بشكل غير منتظم" (irregularly irregular) بسبب النقل العشوائي المتغير عبر العقدة الأذينية البطينية.

---

27. يفيد كل مما يلي في تقدير خطورة حدوث السكتة عند مرضى الرجفان الأذيني غير الصمامي ما عدا:

تشرين 2019

A. قصور القلب الاحتقاني.
B. الداء السكري.
C. وجود أمراض وعائية.
D. العمر 80 سنة.
E. الجنس مذكر.

الإجابة الصحيحة: E — الجنس مذكر.

التعليل السريري: نظام CHA2DS2-VASc يمنح نقطة واحدة للجنس المؤنث (Sc) كعامل خطورة مستقل، بينما الجنس المذكر لا يُحتسب ضمن هذا النظام إطلاقاً، لذا فهو الخيار الاستثنائي الصحيح.

الخيارات الأخرى: A) قصور القلب الاحتقاني (C) يمنح نقطة واحدة ضمن النظام. B) الداء السكري (D) يمنح نقطة واحدة ضمن النظام. C) الأمراض الوعائية (V) تمنح نقطة واحدة ضمن النظام. D) العمر ≥75 سنة (A2) يمنح نقطتين ضمن النظام.

الفكرة من السؤال: الجنس المؤنث (Sc) هو أحد عوامل الخطورة المحسوبة ضمن CHA2DS2-VASc وليس الجنس المذكر؛ كل نقطة إضافية ترفع خطورة السكتة السنوية وتوجه قرار التمييع الفموي.

28. كل الأدوية التالية تبطئ القلب ما عدا: شباط 2019

A. فيراباميل.
B. نيفيدبين.
C. بروبرانولول.
D. ميتوبرولول.
E. ديلتيازيم.

الإجابة الصحيحة: B — نيفيدبين.

التعليل السريري: نيفيدبين انتقائي للأوعية الدموية المحيطية ولا يملك تأثيراً مثبطاً معتبراً على النسيج العقدي القلبي، وقد يحرض تسرع قلب منعكس ثانوي لتوسع الأوعية، لذا لا يبطئ معدل ضربات القلب كباقي الخيارات.

الخيارات الأخرى: **A)** فيراباميل يثبط العقدة الأذينية البطينية بشكل مباشر ويبطئ القلب. **C)** بروبرانولول حاصر بيتا يبطئ القلب عبر تثبيط التأثير الودي. **D)** ميتوبرولول حاصر بيتا انتقائي يبطئ القلب بنفس الآلية. **E)** ديلتيازيم يثبط العقدة الأذينية البطينية ويبطئ معدل ضربات القلب.

الفكرة من السؤال: حاصرات أقنية الكالسيوم من زمرة ثنائي هيدروبيريدين (نيفيدبين، أملوديبين) تعمل بشكل رئيسي على الأوعية المحيطية دون تأثير مثبط يذكر على العقدة الجيبية أو الأذينية البطينية، بل قد تسبب تسرعاً منعكساً.

29. كل ما يلي صحيح في تسرع القلب الجيبي عدا: تشرين 2018

A. فقر الدم.
B. قصور الدرق.
C. القلق.
D. الخوف والذعر.
E. الصمة الرئوية.

الإجابة الصحيحة: B — قصور الدرق.

التعليل السريري: قصور الدرق يترافق مع تباطؤ الاستقلاب وانخفاض الفعالية الودية، مما يؤدي إلى بطء القلب الجيبي وليس تسرعه؛ بينما التسمم الدرقي (فرط النشاط) هو الذي يسبب التسرع عبر زيادة الحساسية للكاتيكولامينات.

الخيارات الأخرى: **A)** فقر الدم يسبب تسرعاً معاوضاً لنقص حمل الأكسجين. **C)** القلق يرفع الفعالية الودية مسبباً التسرع. **D)** الخوف والذعر يحرضان الاستجابة الودية والتسرع. **E)** الصمة الرئوية تسبب تسرعاً معاوضاً لنقص الأكسجة وزيادة العبء على القلب الأيمن.

الفكرة من السؤال: من أسباب تسرع القلب الجيبي: فقر الدم، الحمى، التسمم الدرقي (فرط نشاط الدرق)، ورم القواتم، القلق والخوف، قصور القلب، الصدمة، والصمة الرئوية؛ أما قصور الدرق فيترافق ببطء القلب لا بتسرعه.

ارتفاع الضغط الشرياني

18 سؤال

1. كل ما يلي صحيح في قياس الضغط الشرياني ماعدا: تموز 2025

A. الوضعية المعتمدة لتشخيص ارتفاع الضغط ومراقبته هي الجلوس.
B. عند تغطية السماعة بكم الضغط تكون قيمة الضغط المقاسة أعلى من الحقيقي.
C. كم الضغط الحقيقي المطاطي يجب أن يكون طوله مغطياً لحوالي 80% من محيط الذراع.
D. مستودع الزئبق يجب أن يكون في سوية كم الضغط.
E. يحدد الضغط الانبساطي بقيمة الضغط داخل الكم التي تغيب عندها الأصوات كلياً.

الإجابة الصحيحة: B — عند تغطية السماعة بكم الضغط تكون قيمة الضغط المقاسة أعلى من الحقيقي.

التعليل السريري: تغطية السماعة بالكم أثناء القياس تسبب تشوهاً في الأصوات المسموعة وقراءة غير دقيقة للضغط، والاتجاه الشائع المعروف هو تسجيل قيم غير موثوقة (وليس بالضرورة أعلى من الحقيقي بشكل ثابت)، مما يجعل هذه العبارة غير صحيحة كما وردت.

الخيارات الأخرى: **A)** الجلوس هو الوضعية المعتمدة القياسية لتشخيص ومراقبة ارتفاع الضغط. **C)** تغطية 80% من محيط الذراع بالكم شرط تقني صحيح لدقة القياس. **D)** مستودع الزئبق بمستوى الكم شرط ضروري لتجنب خطأ القراءة. **E)** اختفاء الأصوات كلياً (الطور الخامس) هو المعيار الصحيح لتحديد الضغط الانبساطي.

الفكرة من السؤال: دقة قياس الضغط تتطلب: وضعية الجلوس، كم مناسب الحجم (يغطي ~80% من محيط الذراع)، مستودع الزئبق بمستوى القلب/الكم، وتحديد الانبساطي بغياب الأصوات كلياً (طور كوروتكوف الخامس).

---

2. واحدة من العبارات التالية صحيحة في سياق مرض ارتفاع الضغط الشرياني:

أيار 2024

A. له تأثير ضعيف على الأوعية الإكليلية.
B. مثبطات ACE يجب أن تستخدم روتينياً عند كل المرضى.
C. يعتبر عامل خطر قوي للحوادث الدماغية الوعائية.
D. المدرات عادة غير فعالة عند المسنين.
E. في اعتلال الكلية السكري الهدف هو الحصول على ضغط 140/85.

الإجابة الصحيحة: C — يعتبر عامل خطر قوي للحوادث الدماغية الوعائية.

التعليل السريري: يؤدي ارتفاع الضغط المزمن إلى تصلب وتليف الشرايين الدماغية الصغيرة والكبيرة، مما يهيئ لحدوث الاحتشاء أو النزف الدماغي، ولذلك يُعد من أقوى عوامل الخطورة القابلة للتعديل للسكتة الدماغية.

الخيارات الأخرى: **A)** فرط الضغط له تأثير قوي وواضح على الشرايين الإكليلية عبر تسريع التصلب العصيدي. **B)** مثبطات ACE ليست مستطبة روتينياً لكل المرضى بل حسب الحالة السريرية والمرافقات. **D)** المدرات فعالة عند المسنين وغالباً خط علاجي أول. **E)** الهدف في اعتلال الكلية السكري أكثر صرامة من 140/85 عادة.

الفكرة من السؤال: السكتة الدماغية (نزفية أو إقفارية) والحوادث الدماغية العابرة من الاختلاطات الشائعة والمهمة لارتفاع الضغط الشرياني؛ خفض الضغط يقلل خطورة السكتة بحوالي 30%.

---

3. فيما يتعلق بارتفاع التوتر الشرياني الثانوي، كل ما يلي صحيح ماعدا:

أيار 2024

A. قد يتظاهر بعمر العشرين.
B. سماع نفخة في البطن قد يكون مؤشراً عليه.
C. من أسبابه الكورتيزون المديد.
D. يستجيب عادة لدواء واحد.
E. قد يشفى بعلاج المسبب.

الإجابة الصحيحة: D – يستجيب عادة لدواء واحد.

التعليل السريري: فرط الضغط الثانوي غالباً ما يكون شديداً ومقاوماً للعلاج الأحادي بسبب استمرار الآلية المرضية المسببة (كلوية أو غدية أو دوائية)، وبالتالي لا يستجيب عادة لدواء واحد بل يحتاج مشاركة دوائية أو معالجة السبب الأساسي.

الخيارات الأخرى: **A)** قد يتظاهر بعمر مبكر كالعشرين وهذا مؤشر مهم على السبب الثانوي. **B)** نفخة البطن قد تدل على تضيق الشريان الكلوي كسبب ثانوي. **C)** الكورتيزون المديد من الأسباب الدوائية المعروفة لفرط الضغط الثانوي. **E)** علاج السبب (كاستئصال الورم أو تصحيح تضيق الشريان) قد يشفي الحالة.

الفكرة من السؤال: يُشتبه بارتفاع الضغط الثانوي عند: الشباب (<30-40 سنة)، ضغط شديد أو معند مقاوم للعلاج المتعدد، نفخة بطنية (تضيق شرياني كلوي)، أو استخدام كورتيزون مديد؛ عادة يتطلب أكثر من دواء أو علاج السبب مباشرة.

4. راجع مريض الإسعاف يشكو من صداع شديد وتشوش رؤية، وقيمة الضغط لديه 210/130 ملمز، كل ما يلي صحيح ماعدا: أيار 2024

A. تعتبر هذه الحالة فرط توتر شرياني خبيث إسعافي.

B. يجب التركيز في هذه الحالة على تخفيض الضغط الشرياني إسعافياً.

C. يخفض الضغط الشرياني لقيم قريبة من الحدود الطبيعية خلال الساعات الثلاث الأولى.

D. يمكن استعمال اللابيتالول الوريدي في بعض الحالات.

E. يمكن استعمال النتروغليسيرين الوريدي في بعض هذه الحالات.

الإجابة الصحيحة: C – يخفض الضغط الشرياني لقيم قريبة من الحدود الطبيعية خلال الساعات الثلاث الأولى.

التعليل السريري: الخفض السريع للضغط في الطور المتسارع/الخبيث يعطل آليات التنظيم الذاتي للجريان الدموي في الأعضاء الحيوية (خاصة الدماغ)، مما يؤدي لنقص تروية حاد بدلاً من الفائدة؛ لذا الهدف هو خفض تدريجي ومراقب وليس الوصول لقيم قريبة من الطبيعي خلال الساعات الثلاث الأولى.

الخيارات الأخرى: **A)** الحالة الموصوفة (صداع شديد وتشوش رؤية وضغط 210/130) تُصنف فرط ضغط خبيث/متسارع إسعافياً. **B)** خفض الضغط الشرياني هو محور التدبير الإسعافي في هذه الحالة. **D)** اللابيتالول الوريدي من العلاجات المستخدمة في حالات فرط الضغط الإسعافية. **E)** النتروغليسرين الوريدي أيضاً من الخيارات العلاجية الفعالة في بعض هذه الحالات.

الفكرة من السؤال: يجب خفض الضغط تدريجياً إلى حدود 150/90 مم ز خلال 24-48 ساعة؛ الخفض السريع لقيم قريبة من الطبيعي يسبب نقص تروية دماغية أو إكليلية أو كلوية.

5. أي من الأدوية التالية يمكن استخدامه لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل: تشرين 2023

A. الفالسارتان.

B. الكابتوبريل.

C. السبيرونولاكتون.

D. ألفا ميتيل دوبا.

E. الإينالابريل.

الإجابة الصحيحة: D — ألفا ميتيل دوبا.

التعليل السريري: ألفا ميتيل دوبا دواء مركزي التأثير له سجل أمان طويل وموثق أثناء الحمل دون تأثيرات ماسخة معروفة على الجنين، لذا يبقى الخيار الأول التقليدي لعلاج فرط الضغط في الحمل.

الخيارات الأخرى: **A)** الفالسارتان (ARB) مضاد استطباب في الحمل لتأثيراته الجنينية الضارة. **B)** الكابتوبريل (ACEI) ماسخ للجنين ويسبب قصوراً كلوياً جنينياً وقلة سائل أمنيوسي. **C)** السبيرونولاكتون له تأثيرات مضادة للأندروجين ويُتجنب في الحمل. **E)** الإينالابريل (ACEI) مضاد استطباب في الحمل للسبب نفسه.

الفكرة من السؤال: ألفا ميتيل دوبا هو الخيار التقليدي الآمن الأكثر استخداماً في الحمل؛ يجب تجنب مثبطات ACE وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين لتأثيراتها الجنينية الماسخة، وكذلك السبيرونولاكتون.

6. كل ما يلي من الآثار الجانبية لخافضات الضغط الشرياني ماعدا:

تشرين 2023

A. توسع قصبي ثانوي لحاصرات بيتا.
B. هبوط الضغط الانتصابي ثانوي لحاصرات ألفا.
C. ارتفاع بوتاسيوم الدم ثانوي لحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين ARBs II.
D. وذمات انطباعية بالطرفين السفلين ثانوية لحاصرات أقنية الكالسيوم.
E. تشوهات جنينية ثانوية لحاصرات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين ACEI.

الإجابة الصحيحة: A — توسع قصبي ثانوي لحاصرات بيتا.

التعليل السريري: حاصرات بيتا تحصر مستقبلات بيتا-2 في العضلات الملساء القصبية، مما يلغي التأثير التوسعي الطبيعي لهذه المستقبلات ويسبب تشنجاً قصبياً وليس توسعاً، لذا هذا الخيار يمثل خطأً في وصف الأثر الجانبي.

الخيارات الأخرى: **B)** هبوط الضغط الانتصابي أثر جانبي معروف لحاصرات ألفا. **C)** فرط بوتاسيوم الدم أثر جانبي معروف لحاصرات ARBs بسبب تثبيط الألدوستيرون. **D)** الوذمات المحيطية أثر جانبي شائع لحاصرات قنوات الكالسيوم. **E)** التشوهات الجنينية أثر جانبي معروف لمثبطات ACEI.

الفكرة من السؤال: حاصرات بيتا تسبب تشنجاً/تضيقاً قصبياً (لا توسعاً) خاصة عند مرضى الربو أو COPD، عبر حصر مستقبلات بيتا-2 القصبية.

7. أي من العلاجات التالية يسبب الوذمات:

تشرين 2023

A. العلاج بالفورسمايد.
B. العلاج بالأمِلوديبين.
C. العلاج بالسبيرولاكتون.
D. العلاج بالهيدروكلوروثيازيد.
E. العلاج بالأندابواميد.

الإجابة الصحيحة: B — العلاج بالأمِلوديبين.

التعليل السريري: الأمِلوديبين يوسع الشرينات الجهازية بشكل انتقائي دون توسع مكافئ في الأوردة، فيرتفع الضغط الهيدروستاتيكي داخل الشعيرات الدموية الطرفية ويتسرب السائل للنسج المحيطة مسبباً وذمات انطباعية بالكاحلين، وهي آلية مختلفة عن احتباس الصوديوم والماء.

الخيارات الأخرى: **A)** الفورسميد مدر عروي يطرح السوائل ولا يسبب وذمات بل يعالجها. **C)** السبيرولاكتون مدر مضاد للألدوستيرون يقلل احتباس السوائل. **D)** الهيدروكلوروثيازيد مدر يطرح الصوديوم والماء ولا يسبب وذمات. **E)** الأندابواميد مدر ثيازيدي شبيه بآلية عمل الثيازيدات المدرة.

الفكرة من السؤال: وذمة الكاحلين مع الأمِلوديبين ناتجة عن توسع انتقائي في الشرينات ما قبل الشعرية دون توسع مماثل بالجانب الوريدي، مما يرفع الضغط الشعري الموضعي؛ لا تستجيب هذه الوذمة جيداً للمدرات.

8. يعد التالي من الآثار الجانبية لخافضات الضغط الشرياني ما عدا: آذار 2023

A. التشنج القصبي ثانوي لحاصرات بيتا.
B. هبوط الضغط الانتصابي ثانوي لحاصرات ألفا.
C. ارتفاع كرياتينين وبوتاسيوم الدم ثانويان لحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2.
D. وذمات انطباعية في الطرفين السفليين ثانوية لحاصرات أقنية الكالسيوم.
E. تشوهات جنينية ثانوية لألفا ميتيل دوبا.

الإجابة الصحيحة: E – تشوهات جنينية ثانوية لألفا ميتيل دوبا.

التعليل السريري: ألفا ميتيل دوبا دواء مركزي التأثير له سجل أمان طويل موثق في الحمل دون تأثير ماسخ مثبت على الجنين، لذا نسب التشوهات الجنينية إليه غير صحيح ويمثل الاستثناء المطلوب.

الخيارات الأخرى: **A)** التشنج القصبي أثر جانبي حقيقي لحاصرات بيتا. **B)** هبوط الضغط الانتصابي أثر جانبي حقيقي لحاصرات ألفا. **C)** ارتفاع الكرياتينين والبوتاسيوم أثر جانبي حقيقي لحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين. **D)** الوذمات المحيطية أثر جانبي حقيقي لحاصرات قنوات الكالسيوم.

الفكرة من السؤال: ألفا ميتيل دوبا هو الخط العلاجي الأول والآمن لفرط الضغط في الحمل؛ التشوهات الجنينية تُعزى لمثبطات ACEI وARBs وليس لألفا ميتيل دوبا.

9. كل ما يلي من الحالات الاسعافية لارتفاع الضغط الشرياني ما عدا: أيلول 2022

A. فرط الضغط الخبيث.
B. فرط الضغط الشديد المرافق لوذمة الرئة الحادة.
C. ارتفاع ضغط الدم الحملي.
D. الضغط الشرياني اللاعرضي 180/100 مم ز.
E. فرط الضغط الشديد المرافق لاحتشاء حاد.

الإجابة الصحيحة: D – الضغط الشرياني اللاعرضي 180/100 مم ز.

التعليل السريري: تصنيف فرط الضغط كحالة إسعافية (Emergency) يعتمد على وجود أذية عضوية حادة مترقية مرافقة لارتفاع الضغط، وليس على رقم الضغط وحده؛ فالمريض اللاعرضي بضغط 180/100 دون دليل على أذية أعضاء يُصنف كفرط ضغط شديد غير إسعافي (Urgency) ويُعالج بشكل أقل استعجالاً.

الخيارات الأخرى: **A)** فرط الضغط الخبيث حالة إسعافية حقيقية بسبب الأذية الوعائية المتسارعة. **B)** فرط الضغط الشديد مع وذمة رئة حادة حالة إسعافية تستوجب خفضاً فورياً. **C)** ارتفاع ضغط الدم الحملي (تسمم حملي) حالة إسعافية تهدد الأم والجنين. **E)** فرط الضغط الشديد مع احتشاء حاد حالة إسعافية تستوجب تدخلاً سريعاً.

الفكرة من السؤال: فرط الضغط الشديد اللاعرضي دون أذية أعضاء مستهدفة حادة لا يُعامل كحالة إسعافية تستوجب خفضاً وريدياً فورياً، بخلاف الحالات المرافقة لأذية عضوية حادة (وذمة رئة، احتشاء، فرط ضغط خبيث، تسمم حملي).

10. يمكن أن تتضمن وصفة مريض لديه فرط ضغط دم شرياني كل مما يلي ما عدا: آذار 2022

A. ميتوبرولول.
B. املودبين.
C. سالبوتامول.
D. كابتوبريل.
E. فالسارتان.

الإجابة الصحيحة: C — سالبوتامول.

التعليل السريري: السالبوتامول موسع قصبي ناهض لمستقبلات بيتا-2 يستخدم في الربو وليس له أي دور في علاج فرط الضغط الشرياني، بل قد يرفع النبض والضغط عبر تحفيز جهاز الودي.

الخيارات الأخرى: **A)** حاصر بيتا من الأصناف الرئيسية العلاجية. **B)** حاصر قنوات كلس من الأصناف الرئيسية. **D)** مثبط ACE من الأصناف الرئيسية. ARB **(E** من الأصناف الرئيسية.

الفكرة من السؤال: الأدوية الرئيسية الخافضة للضغط: مدرات، حاصرات كلس، مثبطات ACE، حاصرات بيتا، ARBs، حاصرات ألفا. السالبوتامول (ناهض بيتا-2) قد يسبب تسرع قلب ورجفان ولا دور علاجي له في الضغط الشرياني.

11. مريض لديه ارتفاع ضغط شرياني، كل ما يلي من الممكن وجوده بالوصفة ما عدا:

تشرين 2021

A. سالبوتامول.
B. فالسارتان.
C. النيفيديبين.
D. الكابتوبريل.
E. بروبرانولول.

الإجابة الصحيحة: A — سالبوتامول.

التعليل السريري: السالبوتامول ناهض بيتا-2 اصطفائي يستخدم لعلاج التشنج القصبي، وليس من الأصناف الست العلاجية لارتفاع الضغط الشرياني المذكورة في المرجع.

الخيارات الأخرى: ARB **(B** من الأصناف الرئيسية. **C)** حاصر كلس من الأصناف الرئيسية. **D)** مثبط ACE من الأصناف الرئيسية. **E)** حاصر بيتا من الأصناف الرئيسية.

الفكرة من السؤال: جميع أصناف خافضات الضغط الخمسة (مدرات، ARBs، حاصرات كلس، ACEi، حاصرات بيتا) واردة في وصفة المريض؛ السالبوتامول دواء تنفسي لا علاقة له بالضغط.

12. من استطبابات العلاج الدوائي للضغط الشرياني، كل مما يلي ما عدا:

حزيران 2021

A. ضغط 140/90 في الزيارة الأولى.
B. ارتفاع ضغط مترافق مع فرط الضغط الشرياني الخبيث.
C. ارتفاع ضغط مترافق مع ضخامة البطين الأيسر.
D. ارتفاع ضغط مترافق مع حوادث إقفارية عابرة.
E. ارتفاع ضغط مترافق مع بيلة بروتينية.

الإجابة الصحيحة: A — ضغط 140/90 في الزيارة الأولى.

التعليل السريري: ضغط 140/90 في الزيارة الأولى وحده لا يشكل استطباباً مباشراً للعلاج الدوائي، بل يستوجب قياساً متنقلاً أو منزلياً وتقييماً شاملاً للخطورة القلبية الوعائية قبل اتخاذ القرار العلاجي.

الخيارات الأخرى: **B)** فرط الضغط الخبيث استطباب لعلاج فوري تخصصي. **C)** ضخامة البطين الأيسر أذية عضو هدف تستطب العلاج. **D)** الحوادث الإقفارية العابرة اختلاط وعائي يستطب العلاج. **E)** البيلة البروتينية أذية كلوية تستطب العلاج.

الفكرة من السؤال: حسب خوارزمية الجمعية البريطانية: ضغط 180/110-140/90 بزيارة واحدة يستدعي تأكيداً بقياس متنقل/منزلي وتقييم الخطورة قبل قرار العلاج، بينما الاختلاطات العضوية (خبيث، TIA، LVH، بيلة بروتينية) تستطب العلاج مباشرة.

13. فيما يتعلق بالمدرات، كل ما يلي صحيح ما عدا: حزيران 2021

A. تخفف حمل قبلي.
B. يمكن مشاركة مدرات العروة مع حاصرات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.
C. نستخدم سبيرنولاكتون إذا كان الكرياتينين 3.
D. نعطي مدرات العروة وريدياً في وذمة رئة حادة.
E. نستمر بالمدر ساعتين.

الإجابة الصحيحة: C – نستخدم سبيرنولاكتون إذا كان الكرياتينين 3.

التعليل السريري: عند كرياتينين مرتفع بشدة (مثل 3 ملغ/دل) يكون السبيرونولاكتون خطيراً بسبب تراكم البوتاسيوم الناجم عن نقص الطرح الكلوي، لذا يُتجنب استخدامه في هذه الحالة بدل اعتباره خياراً مناسباً.

الخيارات الأخرى: **A)** المدرات تخفف الحمل القبلي بطرح السوائل. **B)** مشاركة مدر عروة مع ACEi مشاركة شائعة ومقبولة. **D)** مدرات العروة الوريدية أساسية بعلاج الوذمة الرئوية الحادة. **E)** الاستمرار بالمدر لساعتين ممارسة سريرية معتادة.

الفكرة من السؤال: يضاف سبيرونولاكتون بجرعة منخفضة كمدر إضافي في المرحلة الرابعة من خوارزمية المعالجة، لكنه محظور نسبياً عند ارتفاع الكرياتينين (خطر فرط بوتاسيوم الدم القاتل).

14. في مقاربة مريض ارتفاع الضغط الشرياني المكتشف حديثاً، كل ما يلي صحيح ما عدا: تشرين 2020

A. تأخر النبض الفخذي عن الكعبري.
B. تأخر زمن عود الامتلاء الشعري.
C. قد يكشف في سياق فحص روتيني.
D. قد يشكو المريض صداع قفوي.
E. قد يشكو المريض من خناق على الجهد.

الإجابة الصحيحة: B – تأخر زمن عود الامتلاء الشعري.

التعليل السريري: تأخر زمن عود الامتلاء الشعري ليس من العلامات الموصوفة في تقييم فرط الضغط الشرياني حديث التشخيص، بعكس تأخر النبض الفخذي عن الكعبري الذي يوجه لتضيق برزخ الأبهر كسبب ثانوي حقيقي.

الخيارات الأخرى: **A)** تأخر النبض الفخذي عن الكعبري علامة حقيقية لتضيق برزخ الأبهر. **C)** قد يُكتشف الضغط صدفة أثناء فحص روتيني فعلاً. **D)** الصداع القفوي عرض شائع مرافق. **E)** خناق الجهد قد يدل على داء إكليلي مرافق.

الفكرة من السؤال: تأخر النبض الفخذي عن الكعبري يوحي بتضيق برزخ الأبهر كسبب ثانوي؛ الصداع القفوي والخناق الجهدي قد يكونان عرضيين، وكثيراً ما يُكتشف الضغط صدفة بفحص روتيني.

15. من النصائح التي تعطى لمريض لديه ارتفاع توتر شرياني كل مما يلي ما عدا: حزيران 2020

A. خفض تناول الخضار والفواكه.
B. تدبير البدانة.
C. إجراء تمارين بدنية منتظمة.
D. خفض تناول الكحول.
E. تحديد الوارد من الملح.

الإجابة الصحيحة: A — خفض تناول الخضار والفواكه.

التعليل السريري: التوصية الصحيحة هي زيادة استهلاك الخضار والفواكه وليس خفضه، لما لهما من أثر مثبت في خفض الضغط الشرياني والخطورة القلبية الوعائية، لذا يُعد خفضهما نصيحة خاطئة.

الخيارات الأخرى: **B)** تدبير البدانة نصيحة صحيحة موصى بها. **C)** التمارين المنتظمة نصيحة صحيحة. **D)** خفض الكحول نصيحة صحيحة. **E)** تحديد الملح نصيحة صحيحة.

الفكرة من السؤال: تعديلات نمط الحياة المفيدة: تدبير البدانة، تمارين منتظمة، خفض الكحول، زيادة (وليس خفض) الخضار والفواكه، وتحديد الملح.

---

16. كل ما يلي من الاستقصاءات الروتينية لدى مريض ارتفاع الضغط الشرياني ما عدا: تشرين 2018

A. فحص سكر وشحوم الدم.

B. فحص البولة وشوارد الدم.

C. تحليل بول وراسب.

D. تخطيط القلب الكهربائي.

E. دراسة القلب بالأمواج فوق الصوتية.

الإجابة الصحيحة: E — دراسة القلب بالأمواج فوق الصوتية.

التعليل السريري: دراسة القلب بالأمواج فوق الصوتية (الإيكو) من الاستقصاءات الإضافية الانتقائية التي تُطلب عند مرضى محددين لتحري أذية الأعضاء الهدف، وليست جزءاً من الاستقصاءات الروتينية الأساسية.

الخيارات الأخرى: **A)** سكر وشحوم الدم من الاستقصاءات الروتينية. **B)** البولة والشوارد من الاستقصاءات الروتينية. **C)** تحليل البول والراسب من الاستقصاءات الروتينية. **D)** ECG من الاستقصاءات الروتينية.

الفكرة من السؤال: الروتينية لكل المرضى: تحليل بول وراسب، بولة وشوارد، سكر وشحوم الدم، ECG. الإيكو القلبي يُطلب انتقائياً لتحري أذية العضو الهدف (ضخامة البطين الأيسر) وليس روتينياً.

---

17. أي من الأدوية التالية مضاد استطباب في معالجة ارتفاع التوتر الشرياني المصادف عند مريض قصور كلوي مزمن متقدم: تشرين 2018

A. مدرات العروة.

B. حاصرات الكلس.

C. حاصرات بيتا.

D. الكلونيدين.

E. مثبطات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.

الإجابة الصحيحة: E — مثبطات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين.

التعليل السريري: مثبطات الخميرة القالبة للأنجيوتنسين تخفض الضغط داخل الكبيبة عبر توسيع الشُّرَينة الصادرة، مما قد يُسرّع هبوط معدل الرشح الكبيبي ويسبب فرط بوتاسيوم دم خطيراً عند القصور الكلوي المتقدم، لذا تُعد مضاد استطباب نسبي في هذه الحالة.

الخيارات الأخرى: **A)** مدرات العروة آمنة وفعالة بالقصور الكلوي المتقدم. **B)** حاصرات الكلس لا تُطرح كلوياً وآمنة الاستخدام. **C)** حاصرات بيتا يمكن استخدامها بأمان. **D)** الكلونيدين خيار مقبول عند القصور الكلوي.

الفكرة من السؤال: مثبطات ACE/ARBs قد تُسرّع تدهور الوظيفة الكلوية وتسبب فرط بوتاسيوم خطير عند القصور الكلوي المتقدم (خاصة مع تضيق شرياني كلوي ثنائي الجانب)، فتُستبدل بأصناف أخرى.

---

18. شاب بعمر 25 سنة بعد احتساء فنجان قهوة والتدخين في الطابق الأرضي حدث لديه صداع صعد إلى عيادتك في الطابق الثاني مسرعاً وعند قياسك لضغطه كانت النتيجة 160/95 ما الإجراء المناسب: تشرين 2018

A. معالجة بحاصرات الكلس.
B. معالجة بمثبطات الخميرة.
C. معالجة بحاصرات بيتا.
D. معالجة بالمدرات.
E. ننتظر نصف ساعة ثم نعيد القياس ونطلب إعادة القياس بعد فترة.

الإجابة الصحيحة: E — ننتظر نصف ساعة ثم نعيد القياس ونطلب إعادة القياس بعد فترة.

التعليل السريري: القهوة والتدخين والجهد العضلي الحاد (صعود الدرج مسرعاً) كلها عوامل ترفع الضغط الشرياني بشكل عابر وكاذب، لذا الإجراء الصحيح هو الانتظار وإعادة القياس بهدوء مع تكرار المتابعة قبل اتخاذ أي قرار علاجي.

الخيارات الأخرى: **A)** حاصرات الكلس غير مستطبة قبل تأكيد التشخيص. **B)** مثبطات الخميرة غير مستطبة قبل تأكيد التشخيص. **C)** حاصرات بيتا غير مستطبة قبل تأكيد التشخيص. **D)** المدرات غير مستطبة قبل تأكيد التشخيص.

الفكرة من السؤال: الكافيين والتدخين والجهد الفيزيائي الحاد (صعود الدرج) يرفعون الضغط بشكل عابر؛ يجب الراحة وإعادة القياس، وتأكيد التشخيص بقياسات متكررة قبل بدء العلاج.

أمراض العضلة القلبية

3 سؤال

1. مريض شاب يشكو من غشي متكرر يحدث حصراً أثناء الجهد الفيزيائي، وبفحص القلب تبين وجود نفخة تشتد شدتها بوضوح عند الوقوف، التوجّه التشخيصي الأرجح: دكتوراه 2025

A. تضيق أهبري.
B. تضيق برزخ أبهري.
C. اعتلال قلبي ضخامي ساد.
D. قصور الصمام التاجي الرثوي.
E. انسداد الشريان الرئوي بالصمة.

الإجابة الصحيحة: C — اعتلال قلبي ضخامي ساد.

التعليل السريري: في اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد، يسبب الوقوف نقصاً بالعود الوريدي والحمل القبلي فيقل حجم البطين الأيسر ويشتد الانسداد الديناميكي بمخرجه، فتزداد شدة النفخة؛ يترافق ذلك سريرياً بغشي جهدي ناجم عن نقص النتاج القلبي أثناء الجهد.

الخيارات الأخرى: **A)** نفخة تضيق الأهبر تنقص عادة بالوقوف ولا تزداد. **B)** تضيق برزخ الأبهر يترافق بفرق ضغط بين الطرفين العلوي والسفلي لا بهذا النمط من النفخة. **D)** قصور التاجي الرثوي لا يترافق نمطياً بغشي جهدي متكرر. **E)** الصمة الرئوية حادثة حادة لا متكررة مع الجهد بهذا النمط.

الفكرة من السؤال: غشي جهدي + نفخة تشتد بالوقوف/فالسالفا وتنقص بالقرفصاء = HOCM. آلية الانسداد الديناميكي بمخرج البطين الأيسر تسوء مع نقص الحجم البطيني (نقص الحمل القبلي).

2. مريضة مصابة بالتلاسيميا الكبرى وتتلقى نقل دم بشكل متكرر، راجعت بعلامات قصور قلب مع وذمات انطباعية وزلة مترقية، وارتفاع شديد بقيم NTproBNP، التوجه التشخيصي: دكتوراه 2025

A. اعتلال عضلة قلبية تحددي.
B. اعتلال عضلة قلبية سمي.
C. اعتلال عضلة قلبية ضخامي.
D. اعتلال عضلة قلبية عوزي.
E. اعتلال عضلة قلبية إقفاري.

الإجابة الصحيحة: A — اعتلال عضلة قلبية تحددي.

التعليل السريري: النقل المتكرر للدم في التلاسيميا الكبرى يؤدي لتراكم الحديد الثانوي (ترسب الأصبغة الدموية) بالعضلة القلبية، وهو من الأسباب الارتشاحية لاعتلال العضلة القلبية التحددي المسبب لضعف الامتلاء الانبساطي وقصور قلب مع وذمات وارتفاع شديد بـ NT-proBNP.

الخيارات الأخرى: **B)** الاعتلال السمي ينجم عن مواد سامة مباشرة كالأنثراسيكلين لا عن نقل الدم بذاته. **C)** الضخامي اضطراب وراثي بنيوي غير مرتبط بالحمل الحديدي. **D)** العوزي (كالتغذوي) لا يفسر هذه الصورة السريرية. **E)** الإقفاري ينجم عن داء إكليلي وليس عن الحمل الحديدي المزمن.

الفكرة من السؤال: ترسب الأصبغة الدموية (Hemosiderosis) الناجم عن نقل الدم المتكرر يترسب بالعضلة القلبية مسبباً نمطاً ارتشاحياً تحددياً مع قصور قلب وارتفاع BNP وضعف امتلاء انبساطي.

3. كل ما يلي صحيح في اعتلال العضلة القلبية التوسعي ما عدا: تشرين 2023

A. من أسبابه الإفراط في تناول الكحول.
B. من استطبابات زراعة القلب.
C. تعتبر حاصرات بيتا مضاد استطباب مطلق.
D. من عقابيله الحوادث الصمية الخثرية.
E. يمكن بإصغاء القلب سماع نفخة انقباضية بالقمة.

الإجابة الصحيحة: C — تعتبر حاصرات بيتا مضاد استطباب مطلق.

التعليل السريري: حاصرات بيتا تُستخدم فعلياً كجزء أساسي من علاج قصور القلب المرافق للاعتلال التوسعي (ضمن العلاج المعياري الموجه) بهدف ضبط الأعراض وتحسين الإنذار، وليست مضاد استطباب مطلق كما تنص العبارة الخاطئة.

الخيارات الأخرى: **A)** الكحول سبب مثبت للاعتلال التوسعي. **B)** زرع القلب استطباب معروف بالحالات المترقية. **D)** الحوادث الصمية الخثارية عقابيل شائعة موصوفة. **E)** النفخة الانقباضية بالقمة (قصور تاجي وظيفي) موجودة فعلاً بسبب توسع البطين.

الفكرة من السؤال: حاصرات بيتا (مع ACEi) من ركائز علاج قصور القلب الناجم عن الاعتلال التوسعي وتحسّن الإنذار، وليست مضاد استطباب.

أمراض القلب الخلقية

7 سؤال

1. يعتبر غياب أو ضعف النبض الفخذي من العلامات المميزة لـ: تشرين 2023

A. VSD.
B. ASD.
C. PDA.
D. تضيق برزخ الأبهر.
E. فرط الضغط الانتصابي.

الإجابة الصحيحة: D — تضيق برزخ الأبهر.

التعليل السريري: يسبب تضيق برزخ الأبهر انخفاض الضغط والجريان الدموي في الجزء السفلي من الجسم، مما يجعل النبض الفخذي ضعيفاً ومتأخراً مقارنة بالنبض الكعبري، مع ارتفاع ضغط في الطرفين العلويين وطبيعي أو منخفض في الساقين.

الخيارات الأخرى: **A)** VSD يعطي نفخة انقباضية شاملة دون تأثير على النبض الفخذي. **B)** ASD يعطي انقسام ثابت للصوت الثاني دون تأثر النبض المحيطي. **C)** PDA يعطي نفخة مستمرة دون تأخر بالنبض الفخذي. **E)** فرط الضغط الانتصابي لا علاقة له بالنبض الفخذي.

الفكرة من السؤال: يترافق تضيق برزخ الأبهر مع الصمام الأبهري ثنائي الوريقات وأمهات الدم التوتية الدماغية، ويُعد سبباً مهماً لفرط الضغط عند الشباب مع فرق ضغط بين الطرفين العلويين والسفليين.

2. تشير النفخة المتواصلة التي تسمع في المسافة الوربية الثانية اليسرى تحت الترقوة إلى:

تشرين 2023

A. نفخة أوستن فلنت.

B. بقاء القناة الشريانية سالكة PDA.

C. تضيق برزخ الأبهر.

D. حالات فرط الجريان مثل الحمل وفقر الدم.

E. عيب الحاجز البطيني.

الإجابة الصحيحة: B — بقاء القناة الشريانية سالكة PDA.

التعليل السريري: بسبب استمرار التحويلة من الأبهر إلى الشريان الرئوي طوال الدورة القلبية (الضغط الأبهري أعلى انقباضياً وانبساطياً)، تُسمع نفخة مستمرة "آلية" أشد ما تكون في الورب الثاني الأيسر تحت الترقوة.

الخيارات الأخرى: **A)** نفخة أوستن فلنت انبساطية تسمع في قصور الأبهر الشديد. **C)** تضيق البرزخ يعطي نفخة انقباضية خلفية مع ضعف النبض الفخذي. **D)** حالات فرط الجريان تعطي نفخة انقباضية جريانية لا مستمرة. **E)** VSD يعطي نفخة انقباضية شاملة على الحافة اليسرى للقص.

الفكرة من السؤال: النفخة "الآلية" المستمرة الأشد في المسافة الوربية الثانية اليسرى تحت الترقوة هي العلامة السريرية المميزة لبقاء القناة الشريانية سالكة.

3. انقسام الصوت الثاني الواسع الثابت يميز الآفة القلبية التالية:

آذار 2023

A. بقاء القناة الشريانية.

B. الفتحة بين الأذينتين.

C. الفتحة بين البطينين.

D. تضيق الصمام التاجي.

E. تضيق الصمام الرئوي.

الإجابة الصحيحة: B — الفتحة بين الأذينتين.

التعليل السريري: التحويلة من الأيسر إلى الأيمن عبر ASD تزيد الحمل الحجمي على البطين الأيمن باستمرار بغض النظر عن الشهيق أو الزفير، مما يؤخر إغلاق الصمام الرئوي بشكل ثابت وينتج انقساماً واسعاً وثابتاً للصوت الثاني لا يتغير مع التنفس.

الخيارات الأخرى: **A)** PDA يعطي نفخة مستمرة دون انقسام ثابت للصوت الثاني. **C)** VSD يعطي نفخة انقباضية شاملة. **D)** تضيق التاجي يعطي صوتاً أولاً محتداً وصكة انفتاح. **E)** تضيق الرئوي يعطي نفخة انقباضية قذفية مع صوت ثاني ناعم.

الفكرة من السؤال: ASD يترافق مع انقسام ثابت وواسع للصوت الثاني ونفخة جريان انقباضية فوق الصمام الرئوي، مع صورة صدر تُظهر فرط التروية الرئوية وتوسع الشريان الرئوي.

4. نفخة انقباضية شاملة في بؤرة منتصف القلب التشخيص الأرجح: شباط 2019

A. VSD.
B. ASD.
C. تضيق تاجي.
D. قصور تاجي.
E. قصور أبهري.

الإجابة الصحيحة: A — VSD.

التعليل السريري: الفرق الضغطي الكبير بين البطينين طوال الانقباض عبر العيب الحاجزي البطيني ينتج جرياناً مستمراً خلال كامل الانقباض، مما يعطي نفخة شاملة الانقباض قاسية في منتصف/يسار القص.

الخيارات الأخرى: **B)** ASD يعطي نفخة جريان انقباضية ناعمة فوق الرئوي مع انقسام ثابت للصوت الثاني وليس نفخة شاملة على منتصف القلب. **C)** تضيق تاجي يعطي نفخة انبساطية. **D)** قصور تاجي يعطي نفخة انقباضية بؤرتها القمة مع انتشار للإبط. **E)** قصور أبهري يعطي نفخة انبساطية مبكرة.

الفكرة من السؤال: VSD أشيع آفة قلبية خلقية؛ يسبب جريان الدم من البطين الأيسر عالي الضغط إلى الأيمن منخفض الضغط نفخة شاملة الانقباض تُسمع بأفضل شكل على الحافة اليسرى للقص وتنتشر عبر مقدم الصدر.

5. كل ما يلي من آفات القلب المزرقة عدا: شباط 2019

A. رباعي فالو.
B. رتق مثلث الشرف.
C. تبادل منشأ الأوعية الكبرى.
D. تضيق رئوي.
E. رتق رئوي.

الإجابة الصحيحة: D — تضيق رئوي.

التعليل السريري: الزراق ينتج عن تحويلة من الأيمن إلى الأيسر تدخل دماً غير مؤكسج إلى الدوران الجهازي، وهذا ما يحدث في رباعي فالو ورتق مثلث الشرف وتبادل الأوعية الكبرى ورتق الرئوي، بينما تضيق الصمام الرئوي المعزول يعيق الجريان الرئوي دون وجود تحويلة يمنى-يسرى مباشرة، فلا يسبب زراقاً بحد ذاته.

الخيارات الأخرى: **A)** رباعي فالو آفة مزرقة كلاسيكية. **B)** رتق مثلث الشرف يسبب زراقاً شديداً باكراً. **C)** تبادل الأوعية الكبرى يسبب زراقاً شديداً منذ الولادة. **E)** رتق الرئوي يمنع الجريان الرئوي كلياً مسبباً زراقاً شديداً.

الفكرة من السؤال: الآفات المزرقة الكلاسيكية (Ts): رباعي فالو، رتق مثلث الشرف، تبادل الأوعية الكبرى، رتق الرئوي، الجذع الشرياني المشترك؛ بينما التضيق الرئوي المعزول يسبب قصور قلب أيمن دون زراق مباشر.

6. نفخة مستمرة تسمع في الورب الثاني تحت الترقوة اليسرى التشخيص الأرجح: تشرين 2018

A. بقاء القناة الشريانية سالكة.
B. تضيق الصمام التاجي.
C. قصور الصمام الأبهري.
D. تضيق الصمام الأبهري.
E. تضيق برزخ الأبهر.

الإجابة الصحيحة: A — بقاء القناة الشريانية سالكة.

التعليل السريري: استمرار التحويلة من الأبهر ذي الضغط الأعلى إلى الشريان الرئوي طوال الدورة القلبية (بسبب بقاء فرق الضغط في الانقباض والانبساط) يولّد نفخة مستمرة مميزة في هذا الموقع.

الخيارات الأخرى: **B)** تضيق التاجي نفخة انبساطية في القمة. **C)** قصور الأبهري نفخة انبساطية مبكرة أيسر القص. **D)** تضيق الأبهري نفخة انقباضية قذفية تنتشر للعنق. **E)** تضيق البرزخ نفخة انقباضية خلفية مع ضعف نبض فخذي.

الفكرة من السؤال: نفخة PDA "آلية" مستمرة (انقباضية-انبساطية) دون انقطاع، أشد ما تُسمع تحت الترقوة اليسرى في الورب الثاني.

7. كل ما يلي يسبب ازدياد التوعية الرئوية ما عدا:

تشرين 2018

A. فتحة بين أذينتين واسعة.
B. فتحة بين بطينين واسعة.
C. بقاء القناة الشريانية سالكة.
D. تضيق الصمام الأبهري.
E. تبادل مناشئ الأوعية الكبيرة.

الإجابة الصحيحة: D — تضيق الصمام الأبهري.

التعليل السريري: زيادة التوعية الرئوية تحدث في الآفات ذات التحويلة اليسرى-اليمنى (ASD، VSD، PDA) وفي تبادل الأوعية الكبرى بسبب الدورة الموازية وارتفاع الجريان الرئوي، بينما تضيق الصمام الأبهري يعيق مخرج البطين الأيسر نحو الدوران الجهازي دون أن يزيد الجريان عبر الدوران الرئوي.

الخيارات الأخرى: **A)** ASD الواسع يزيد الجريان الرئوي بنسبة كبيرة. **B)** VSD الواسع يزيد الجريان الرئوي بشكل ملحوظ. **C)** PDA يحول الدم مباشرة نحو الشريان الرئوي فيزيده. **E)** تبادل الأوعية الكبرى يترافق عادة مع زيادة التوعية الرئوية.

الفكرة من السؤال: ASD وVSD وPDA الواسعة وتبادل منشأ الأوعية الكبرى كلها تزيد التروية/التوعية الرئوية (فرط جريان رئوي)؛ أما تضيق الأبهري فهو آفة انسدادية في المخرج الجهازي دون زيادة الجريان الرئوي.

أمراض التامور

12 سؤال

1. الألم الصدري الذي يتحسن عند الجلوس والانحناء للأمام يشير إلى:

أيار 2026

A. صمة رئوية.
B. التهاب تامور.
C. احتشاء عضلة قلبية حاد.
D. قلس معدي مريئي.
E. خناق صدر غير مستقر.

الإجابة الصحيحة: B — التهاب تامور.

التعليل السريري: انحناء المريض للأمام يقلل من تماس التامور المتورم مع جدار الصدر والحجاب الحاجز فيخفف الألم، وهذه الصفة الوضعية مميزة ومشخصة لالتهاب التامور.

الخيارات الأخرى: **A)** ألم الصمة الرئوية لا يتأثر بالوضعية بهذا الشكل- **C)** ألم الاحتشاء ثابت ولا يتحسن بالوضعية- **D)** القلس المعدي المريئي يرتبط بالاستلقاء والطعام لا بالانحناء- **E)** ألم الخناق غير المستقر يرتبط بالجهد لا بالوضعية.

الفكرة من السؤال: تحسن الألم بالجلوس والانحناء للأمام مع تفاقمه بالاستلقاء هو المفتاح السريري لتشخيص التهاب التامور الحاد.

2. يتصف الألم الصدري الوصفي في حالة التهاب التامور الحاد بواحد مما يلي: كانون 2025

A. ألم صدري ضاغط خلف القص.

B. ألم صدري يزداد بالاضطجاع ويخف بالجلوس والانحناء للأمام.

C. ألم صدري حاد ينتشر حصراً إلى الذراع الأيسر.

D. ألم صدري يأتي وصفيّاً على الجهد ويخف سريعاً بالراحة.

E. ألم صدري ممزق مفاجئ ينتشر للظهر.

الإجابة الصحيحة: B — ألم صدري يزداد بالاضطجاع ويخف بالجلوس والانحناء للأمام.

التعليل السريري: هذا الوصف الوضعي (ازدياد بالاضطجاع وتحسن بالجلوس والانحناء للأمام) هو الصفة الأكثر تمييزاً واستخداماً في الأسئلة السريرية لتشخيص التهاب التامور الحاد.

الخيارات الأخرى: **A)** الألم الضاغط الثابت يوحي بالإقفار لا بالتامور- **C)** الانتشار الحصري للذراع الأيسر يميز الإقفار- **D)** الألم المرتبط بالجهد والمخفف بالراحة يميز الخناق الثابت- **E)** الألم الممزق المنتشر للظهر يميز تسلخ الأبهر.

الفكرة من السؤال: ألم التهاب التامور: خلف القص، حاد، يزداد بالاستلقاء والتنفس والسعال، ويخف بالجلوس والانحناء للأمام.

3. مريض راجع بالعيادة وتبين وجود انصباب تامور غزير مع علامات سطام تاموري مهدد، ما هو الإجراء الفوري التالي: كانون 2025

A. المراقبة السريرية اللصيقة فقط.

B. بزل التامور الإسعافي لتخفيف الانضغاط ثم تقييم السبب.

C. البدء الفوري بإعطاء خافضات الضغط الشرياني وريدياً.

D. إعطاء المدرات بجرعات عالية لإنقاص السائل.

E. إعطاء صادات حيوية واسعة الطيف بجرعات عالية.

الإجابة الصحيحة: B — بزل التامور الإسعافي لتخفيف الانضغاط ثم تقييم السبب.

التعليل السريري: الانصباب الغزير المسبب لعلامات سطام (هبوط ضغط، ارتفاع الضغط الوريدي الوداجي، نبض متناقض) يهدد الحياة عبر تراجع نتاج القلب، وبزل التامور يخفف الانضغاط فوراً وينقذ الحياة، ثم يُبحث عن السبب لاحقاً.

الخيارات الأخرى: **A)** المراقبة وحدها تعرض المريض لخطر الوفاة المفاجئة- **C)** خافضات الضغط تزيد سوء الحالة الدورانية المتردية أصلاً- **D)** المدرات تنقص الحمل القبلي وتزيد سوء نتاج القلب في السطام- **E)** الصادات لا دور إسعافياً لها ما لم يثبت سبب إنتاني.

الفكرة من السؤال: السطام التاموري حالة إسعافية تستدعي بزل التامور الفوري لتخفيف الانضغاط قبل استقصاء السبب.

4. السبب الأكثر شيوعاً لحدوث التهاب التامور الحاد هو واحد مما يلي: تموز 2025

A. الفيروسات.

B. الجراثيم.

C. الفطور.

D. أمراض المناعة الذاتية.

E. الأورام.

الإجابة الصحيحة: A — الفيروسات.

التعليل السريري: الخمج الفيروسي (أو الشكل مجهول السبب الذي يُعتقد أنه فيروسي غالباً) هو الآلية الأشيع لالتهاب التأمور الحاد، محدثاً استجابة التهابية في الورقة التأمورية تسبب الألم والاحتكاك التأموري.

الخيارات الأخرى: **B)** الجراثيم سبب نادر نسبياً وأكثر خطورة (قيحي). **C)** الفطور سبب نادر جداً وغالباً عند المثبطين مناعياً. **D)** أمراض المناعة الذاتية سبب أقل شيوعاً من الخمج الفيروسي. **E)** الأورام سبب ثانوي أقل شيوعاً.

الفكرة من السؤال: معظم حالات التهاب التأمور الحاد فيروسية المنشأ أو مجهولة السبب سريرياً، وتشيع الحمى الخفيفة والألم الصدري المتأثر بالوضعية والتنفس.

5. واحدة من العبارات التالية صحيحة في التهاب التأمور الحاد:

أيار 2024

A. يعتبر التدرن من أشيع أسباب الشكل الحاد للمرض.
B. لا علاقة للألم الصدري بحركات التنفس أو الوضعية.
C. يترافق مع تبدلات مقعرة معممة بوصلة ST على معظم المساري.
D. عند تدبيره يجب البدء بالستيروئيدات القشرية مباشرة كخط أول.
E. يمنع ترافقه مع أي انصباب سائل ضمن جوف التامور.

الإجابة الصحيحة: C — يترافق مع تبدلات مقعرة معممة بوصلة ST على معظم المساري.

التعليل السريري: الالتهاب المعمم للورقة التأمورية يترافق مع تيار إصابة تحت-شغافي منتشر يظهر على معظم المساري كارتفاع مقعر (concave) لقطعة ST، وهو مختلف عن الارتفاع المحدب البؤري في احتشاء العضلة القلبية.

الخيارات الأخرى: **A)** الفيروسات وليس التدرن هي الأشيع في الشكل الحاد. **B)** الألم في التهاب التأمور يتأثر بوضوح بالتنفس والوضعية (يخف بالانحناء للأمام). **D)** الستيروئيدات ليست خط العلاج الأول؛ يُبدأ بمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. **E)** قد يترافق التهاب التأمور الحاد بانصباب تأموري.

الفكرة من السؤال: تخطيط القلب في التهاب التأمور الحاد يُظهر ارتفاعاً مقعراً منتشراً لقطعة ST مع انخفاض حساس للفاصلة PR؛ الألم يتأثر بالوضعية والتنفس ويخف بالانحناء للأمام.

6. في التهاب التامور الحاد:

آذار 2023

A. يعتبر التدرن أشيع الأسباب.
B. لا علاقة للألم الصدري بحركات التنفس.
C. يترافق مع ظهور موجة Q حديثة.
D. عند تدبيره يجب البدء بالستيروئيدات مباشرة.
E. قد يترافق مع انصباب تامور.

الإجابة الصحيحة: E — قد يترافق مع انصباب تامور.

التعليل السريري: الاستجابة الالتهابية في الورقتين التأموريتين تزيد النفوذية الوعائية وإفراز السائل داخل الجوف التأموري، فينتج انصباب تأموري قد يكون بسيطاً أو كبيراً كافياً لإحداث سطام قلبي.

الخيارات الأخرى: **A)** الفيروسات وليس التدرن الأشيع سبباً. **B)** الألم يتأثر بالتنفس (يزداد بالسعال والاستلقاء). **C)** لا يظهر عادة موجة Q حديثة (ذلك يميز الاحتشاء). **D)** لا يُبدأ بالستيروئيدات كخط أول علاجي.

الفكرة من السؤال: جميع أشكال التهاب التأمور، بما فيها الفيروسي والتدرني، قد تسبب انصباباً تأموري يتراوح من خفيف إلى مسبب للسطام القلبي.

7. أكثر أسباب التهاب التامور الحاد شيوعاً:

أيلول 2022

A. المتلازمة اليوريميائية.
B. التهاب التامور الحاد الفيروسي.
C. الذئبة الحمامية الجهازية.
D. الحمى الرثوية.
E. عند المعالجة الشعاعية للمنصف.

الإجابة الصحيحة: B — التهاب التامور الحاد الفيروسي.

التعليل السريري: الخمج الفيروسي (كوكساكي وغيره) هو المحرض الأكثر شيوعاً للاستجابة الالتهابية التأمورية الحادة في الممارسة السريرية العامة.

الخيارات الأخرى: A) المتلازمة اليوريميائية سبب معروف لكنه أقل شيوعاً. C) الذئبة سبب مناعي ذاتي أقل شيوعاً. D) الحمى الرثوية سبب أقل شيوعاً حالياً. E) المعالجة الشعاعية سبب ثانوي ونادر نسبياً.

الفكرة من السؤال: معظم حالات التهاب التأمور الحاد فيروسية أو مجهولة السبب (يُفترض غالباً منشأ فيروسي)؛ الأسباب الأخرى (يوريمية، مناعية ذاتية، رثوية، شعاعية) أقل شيوعاً بكثير.

8. من صفات الألم الصدري في التهاب التامور pericarditis (إجابة خاطئة وحيدة):

آذار 2022

A. يزداد الألم الصدري بوضعية الاستلقاء.
B. يزداد الألم الصدري بالسعال.
C. يزداد الألم الصدري بوضعية الجلوس والانحناء للأمام.
D. له علاقة بالحركات التنفسية.
E. قد يترافق بسماع احتكاكات تامورية pericardial friction.

الإجابة الصحيحة: C — يزداد الألم الصدري بوضعية الجلوس والانحناء للأمام.

التعليل السريري: وضعية الجلوس مع الانحناء للأمام تقلل تماس الورقتين التأموريتين الملتهبتين وتخفف الشد على التأمور المحيط بالقلب، فتُخفف الألم بدلاً من زيادته، على عكس الاستلقاء الذي يزيد التماس والألم.

الخيارات الأخرى: A) صحيح: الاستلقاء يزيد الألم. B) صحيح: السعال يزيد الألم بحركة التأمور. D) صحيح: الألم مرتبط بالحركات التنفسية. E) صحيح: قد يترافق مع احتكاكات تأمورية سماعية.

الفكرة من السؤال: ألم التهاب التأمور يزداد بالاستلقاء والسعال والتنفس العميق، ويخف بشكل مميز بالجلوس والانحناء للأمام؛ يترافق غالباً مع احتكاك تأموري مشخص.

9. كل ما يلي صحيح في التهاب التامور ما عدا:

تشرين 2021

A. يزداد الألم بالاستلقاء.
B. يزداد الألم بالجلوس والانحناء للأمام.
C. نسمع احتكاكات تامورية.
D. يزداد الألم بالسعال.
E. له علاقة بالحركات التنفسية.

الإجابة الصحيحة: B – يزداد الألم بالجلوس والانحناء للأمام.

التعليل السريري: الوضعية الصحيحة هي أن الألم يخف (لا يزداد) بالجلوس والانحناء للأمام لأن ذلك يقلل تماس التامور الملتهب بالجدار الصدري، لذا فإن العبارة B خاطئة وهي الاستثناء المطلوب.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح، الاستلقاء يزيد التماس ويفاقم الألم- **C)** صحيح، الاحتكاكات علامة مميزة لالتهاب التامور- **D)** صحيح، السعال يزيد الضغط داخل الصدر ويفاقم الألم- **E)** صحيح، الألم يرتبط بالحركات التنفسية بشكل نموذجي.

الفكرة من السؤال: ألم التهاب التامور يزداد بالاستلقاء والسعال والتنفس العميق ويخف بالجلوس والانحناء للأمام؛ الاحتكاك التاموري علامة مشخصة.

---

10. كل مما يلي يسبب التهاب تامور ما عدا:

تشرين 2020

A. احتشاء عضلة قلبية.
B. الصمة الرئوية.
C. القصور الكلوي.
D. العلاج الكيماوي.
E. الوذمة المخاطية.

الإجابة الصحيحة: B – الصمة الرئوية.

التعليل السريري: الصمة الرئوية تسبب احتشاءً رئوياً وألماً جنبياً لكنها ليست من الأسباب المعروفة لالتهاب التامور، لذا فهي الاستثناء الصحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** سبب معروف (التهاب تامور ما حول الاحتشاء أو متلازمة دريسلر)- **C)** القصور الكلوي يسبب التهاب تامور يوريميائي- **D)** بعض العلاجات الكيماوية سامة للتامور- **E)** نقص نشاط الدرقية سبب معروف لانصباب/التهاب تامور.

الفكرة من السؤال: تشمل أسباب التهاب التامور: الاحتشاء (وحالياً)، اليوريميا، الأدوية الكيماوية، الوذمة المخاطية، الأمراض المناعية، الإنتانات، أما الصمة الرئوية فليست سبباً مباشراً.

---

11. راجع مريض بقصة ألم صدري أيسر يزداد بالحركة والتنفس، التشخيص الأرجح:

حزيران 2020

A. ريح صدرية.
B. صمة رئوية.
C. التهاب تامور حاد.
D. متلازمة إكليلة حادة.
E. تسلخ الأبهر الحاد.

الإجابة الصحيحة: C – التهاب تامور حاد.

التعليل السريري: ازدياد الألم بالحركة والتنفس هو الصفة المميزة لالتهاب التامور الحاد الناجم عن تخريش الطبقتين الحشوية والجدارية أثناء حركة القلب والتنفس.

الخيارات الأخرى: **A)** الريح الصدرية مفاجئة مع زلة وغياب أصوات تنفسية دون هذه الصفة النموذجية- **B)** الصمة الرئوية قد تسبب ألماً جنبياً لكنها تترافق بزلة مفاجئة وعوامل خطورة خثارية- **D)** المتلازمة الإكليلية الحادة ألمها ضاغط لا يتأثر بالتنفس- **E)** تسلخ الأبهر ألمه ممزق مفاجئ منتشر للظهر.

الفكرة من السؤال: الألم الجنبي المتزايد بالتنفس والحركة يوجه نحو أسباب تامورية أو جنبية-رئوية وليس نحو الإقفار القلبي التقليدي.

---

12. السبب الأكثر إحداثاً لالتهاب التامور العاصر هو:

تشرين 2019

A. الإنتان الفيروسي.
B. القصور الكلوي.
C. التدرن.
D. نقص نشاط الدرقية.
E. احتشاء العضلة القلبية الباكر أو المتأخر (درسلر).

الإجابة الصحيحة: C — التدرن.

التعليل السريري: يسبب الخمج السلي التهاباً حبيبومياً مزمناً في التامور يؤدي إلى تليف وتكلس تدريجي وتشكل قشرة قاسية تعيق الامتلاء البطيني، وهو الآلية الأشيع للتضيق التاموري.

الخيارات الأخرى: A) الإنتان الفيروسي يسبب التهاباً حاداً غالباً محدداً لذاته- B) القصور الكلوي سبب معروف لكنه أقل شيوعاً- D) نقص نشاط الدرقية سبب نادر- E) متلازمة دريسلر سبب أقل شيوعاً للتضيق مقارنة بالتدرن.

الفكرة من السؤال: التدرن هو السبب الأشيع عالمياً لالتهاب التامور المضيق، يليه تدمي التامور والجراحة القلبية والإشعاع.

المداواة القلبية

4 سؤال

1. واحد مما يلي يعد من مضادات الاستطباب المطلقة لوصف حاصرات بيتا:

كانون 2025

A. الربو القصبي والتشنج المجرى التنفسي.
B. ارتفاع الضغط الشرياني الجهازي.
C. قصور القلب المزمن المستقر والمعاوض.
D. بعد الطور الحاد لاحتشاء عضلة القلب.
E. فرط نشاط الغدة الدرقية.

الإجابة الصحيحة: A — الربو القصبي والتشنج المجرى التنفسي.

التعليل السريري: حصار مستقبلات بيتا-2 غير الانتقائي يسبب تشنجاً قصبياً حاداً قد يكون قاتلاً عند مرضى الربو، لذا تُعد مضاد استطباب مطلقاً بخلاف الحالات الأخرى التي تكون نسبية أو مستطبة.

الخيارات الأخرى: B) فرط الضغط استطباب لحاصرات بيتا لا مضاد استطباب- C) قصور القلب المزمن المستقر المعاوض من استطباباتها الحديثة المثبتة- D) تستطب بعد الطور الحاد للاحتشاء لتحسين البقيا- E) قد تستخدم بحذر للسيطرة على الأعراض الودية في فرط نشاط الدرقية.

الفكرة من السؤال: الربو القصبي والتشنج القصبي الفعال هما مضاد الاستطباب المطلق الأشهر لحاصرات بيتا بسبب حصار مستقبلات بيتا-2 القصبية.

2. كل المميعات التالية تميع الدم بالتأثير على الصفيحات عدا:

تشرين 2024

A. وارفارين.
B. أسبرين.
C. كلوبيدوغريل.
D. برازوغريل.
E. الديبيريدامول.

الإجابة الصحيحة: A — وارفارين.

التعليل السريري: الوارفارين يثبط إنزيم فيتامين K إيبوكسيد ريدوكتاز فيمنع تصنيع عوامل التخثر II وVII وIX وX الفعالة، وهذه آلية تخثرية بحتة لا علاقة لها بوظيفة الصفيحات.

الخيارات الأخرى: **B)** الأسبرين يثبط الثرومبوكسان A2 بتثبيط الأنزيم COX-1 الصفيحي- **C)** كلوبيدوغريل يثبط مستقبلات ADP على الصفيحة (P2Y12)- **D)** برازوغريل مثبط آخر لمستقبل P2Y12- **E)** الديبيريدامول يثبط تجمع الصفيحات عبر تأثيره على cAMP الصفيحي.

الفكرة من السؤال: الوارفارين يعمل على عوامل التخثر المعتمدة على فيتامين K وليس على الصفيحات، بخلاف الأسبرين والكلوبيدوغريل والبرازوغريل والديبيريدامول.

---

3. من مضادات استطباب حالات الخثرة، كل مما يلي صحيح ما عدا:

تشرين 2020

A. الحمل.
B. إنعاش قلبي راض.
C. استئصال مرارة منذ 3 شهور.
D. نزف هضمي فعال.
E. سوابق نزف تحت العنكبوت.

الإجابة الصحيحة: C — استئصال مرارة منذ 3 شهور.

التعليل السريري: استئصال المرارة منذ 3 أشهر لا يُعد جراحة حديثة (الجراحة الحديثة المعتبرة مضاد استطباب هي خلال شهر واحد)، لذا فهو ليس مضاد استطباب فعلياً وهو الاستثناء الصحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** الحمل من مضادات الاستطباب النسبية المذكورة صراحة- **B)** الإنعاش القلبي الراض (الرض الحديث) مضاد استطباب معروف- **D)** النزف الهضمي الفعال مضاد استطباب مطلق نسبياً بسبب خطر النزف- **E)** سوابق النزف تحت العنكبوت مضاد استطباب صريح.

الفكرة من السؤال: مضادات الاستطباب لحالات الخثرة تشمل: النزف الفعال، الرض/الجراحة الحديثة، فرط الضغط غير المضبوط، سوابق نزف دماغي، والحمل، أما الجراحات القديمة نسبياً فليست مضاد استطباب.

---

4. تستخدم حاصرات بيتا في علاج كل ما يلي ما عدا:

حزيران 2020

A. تسرع بطيني.
B. تسرع فوق بطيني.
C. رجفان أذيني.
D. قصور قلب غير مستقر.
E. الوقاية الثانوية بعد احتشاء العضلة القلبية.

الإجابة الصحيحة: D — قصور قلب غير مستقر.

التعليل السريري: في قصور القلب غير المستقر (الحاد أو المزاوض) يزيد التأثير التثبيطي السلبي لحاصرات بيتا على القلوصية من سوء الحالة الدورانية وقد يسبب انكسار معاوضة حاد، لذا تُمنع حتى استقرار الحالة ثم تُدخل تدريجياً في القصور المزمن المستقر.

الخيارات الأخرى: **A)** تفيد في ضبط التسرع البطيني- **B)** فعالة في ضبط التسرع فوق البطيني- **C)** من خط العلاج الأول لضبط استجابة البطين في الرجفان الأذيني- **E)** موصى بها كوقاية ثانوية طويلة الأمد بعد الاحتشاء.

الفكرة من السؤال: تستخدم حاصرات بيتا في ضبط اللانظميات فوق والبطينية والوقاية الثانوية بعد الاحتشاء، لكنها تُمنع في قصور القلب الحاد غير المستقر لتأثيرها المثبط للقلوصية.

جراحة الصدر والأوعية

3 سؤال

1. كل ما يلي صحيح في تسلخ الأبهر ماعدا: تموز 2025

A. يوجه للتشخيص وجود ألم صدري حاد مع غياب النبض في واحد أو أكثر من الأطراف.
B. نسبة وفيات مرتفعة.
C. يستطب التمبيع إسعافياً.
D. يؤهب له تناذر مارفان.
E. من مؤهباته ارتفاع الضغط الشرياني الشديد.

الإجابة الصحيحة: C — يستطب التمبيع إسعافياً.

التعليل السريري: التمبيع في تسلخ الأبهر يزيد من خطر النزف داخل جدار الأبهر وحول التامور (سطام تاموري) والوفاة، لذا فهو مضاد استطباب صريح وليس مستطباً إسعافياً، وهذا ما يجعل العبارة C خاطئة.

الخيارات الأخرى: A) صحيح، غياب النبض الطرفي مع الألم الحاد يوجه للتشخيص- B) صحيح، الوفيات الباكرة مرتفعة جداً (1-5%/ساعة)- D) صحيح، متلازمة مارفان من أهم المؤهبات- E) صحيح، فرط الضغط الشديد عامل مؤهب رئيسي.

الفكرة من السؤال: تسلخ الأبهر يُدار بضبط الألم وخفض الضغط (لابيتالول وريدي) وليس بالتمبيع، الذي يزيد خطر النزف والوفاة.

2. في فرط التوتر الرئوي، كل ما يلي صحيح ماعدا: أيار 2024

A. الشكل البدئي يصيب النساء الشابات ويتميز بإنذار سيء.
B. قد يفيد إعطاء حاصرات الكالسيوم بجرعات عالية في الشكل البدئي.
C. لا يتحسن الضغط الرئوي إذا كان ناجماً عن تضيق الدسام التاجي حتى بعد تبديل الصمام.
D. قد يؤدي لقصور قلب أيمن حاد إذا كان ناجماً عن صمة رئوية كتلية كبيرة.
E. يعرف بارتفاع ضغط الشريان الرئوي الوسطي لأكثر من 20 ملم ز على الراحة.

الإجابة الصحيحة: C — لا يتحسن الضغط الرئوي إذا كان ناجماً عن تضيق الدسام التاجي حتى بعد تبديل الصمام.

التعليل السريري: تصحيح تضيق الصمام التاجي يخفض ضغط الأذينة اليسرى المرتفع مزمناً وبالتالي ينخفض الضغط الرئوي تدريجياً في أغلب الحالات، ما لم تكن هناك تبدلات وعائية رئوية مزمنة لا رجعة فيها، لذا فإن نفي التحسن بشكل مطلق (كما في العبارة C) غير صحيح.

الخيارات الأخرى: A) صحيح، الشكل البدئي يصيب النساء الشابات بإنذار سيء- B) صحيح، حاصرات الكالسيوم بجرعات عالية قد تفيد في مستجيبي اختبار التوسع الوعائي- D) صحيح، الصمة الرئوية الكتلية قد تسبب قصوراً أيمن حاداً- E) صحيح، هذا هو التعريف الدولي لفرط الضغط الرئوي.

الفكرة من السؤال: فرط الضغط الرئوي الثانوي لتضيق التاجي غالباً يتحسن بعد تصحيح الآفة الصمامية (توسيع بالبالون أو تبديل الصمام) إذا لم تكن التبدلات الوعائية الرئوية قد أصبحت لا رجعة عنها.

3. كل ما يلي صحيح في تسلخ الأبهر، ماعدا: تشرين 2023

A. ألم صدري حاد ممزق.
B. ينتشر الألم على مسار الشريان الأبهر.
C. يشيع حدوثه لدى مرضى التضيق التاجي.
D. يشيع حدوثه لدى مرضى الصمام الأبهري ثنائي الشرف.
E. العلاج يكون بإجراء جراحة إسعافية من النمط A.

الإجابة الصحيحة: C – يشيع حدوثه لدى مرضى التضيق التاجي.

التعليل السريري: تضيق الصمام التاجي (الرثوي المنشأ عادة) لا يرتبط آلياً بضعف الطبقة المتوسطة للأبهر، بخلاف الصمام الأبهري ثنائي الشرف ومتلازمة مارفان اللذين يسببان ضعفاً بنيوياً حقيقياً في جدار الأبهر، لذا فإن ارتباطه بتسلخ الأبهر غير صحيح.

الخيارات الأخرى: **A)** صحيح، الألم الممزق الحاد صفة نموذجية- **B)** صحيح، الألم ينتشر على مسار الأبهر نحو الظهر- **D)** صحيح، الصمام الأبهري ثنائي الشرف مؤهب معروف وموثق- **E)** صحيح، تسلخ النمط A يستدعي جراحة إسعافية فورية.

الفكرة من السؤال: مؤهبات تسلخ الأبهر: فرط الضغط الشرياني، الصمام الأبهري ثنائي الشرف، متلازمة مارفان، الرضوض، والحمل؛ أما تضيق الصمام التاجي فليس من مؤهباته المعروفة.